

Facilitation du parcours patient au Bénin

Dossier de projet — étude, cadrage, démarches, enquête, institutionnel, contrats — 22 août 2026

Dossier de projet — version 1

Objet — Déterminer s'il existe au Bénin un problème réel qu'un service privé d'accompagnement du parcours de soins peut résoudre légalement, utilement et durablement, et réunir tout ce qu'il faut pour en décider.

Porteur [Prénom NOM] · [Téléphone] · [Courriel]

Date 22 août 2026

Statut — Dossier de travail. Ne constitue pas un avis juridique. Aucune affirmation juridique ne doit être portée dans un contrat, un business plan destiné à des investisseurs ou une présentation institutionnelle sans avoir été recoupée avec le Journal Officiel et validée par un avocat inscrit au barreau du Bénin.

SOMMAIRE GÉNÉRAL

NOTE DE SYNTHÈSE

COMMENT UTILISER CE DOSSIER

ÉTAT D'AVANCEMENT

PARTIE I — ÉTUDE JURIDIQUE, INSTITUTIONNELLE ET STRATÉGIQUE

- 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
- 2. CADRE JURIDIQUE BÉNINOIS
- 3. DROITS ET DEVOIRS DU PATIENT — ET DE SA FAMILLE
- 4. OBLIGATIONS ET LIMITES DES PROFESSIONNELS
- 5. CARTOGRAPHIE DU PARCOURS PATIENT
- 6. PRINCIPAUX POINTS DE RUPTURE
- 7. RÔLE LÉGALEMENT POSSIBLE DU FACILITATEUR
- 8. RISQUES JURIDIQUES ET ÉTHIQUES — ET CRITIQUE DU CONCEPT
- 9. MODÈLE INSTITUTIONNEL, PILOTE ET VALIDATION TERRAIN
- 10. MODÈLE ÉCONOMIQUE, GOUVERNANCE ET RECOMMANDATIONS
- CONCLUSION
- ANNEXE A — TABLEAU « QUI FAIT QUOI ? »
- ANNEXE B — DROIT / OBLIGATION / TEXTE / ARTICLE
- ANNEXE C — PROBLÈME / CAUSE POSSIBLE / SOLUTION / INTERVENTION DU FACILITATEUR
- ANNEXE D — VERT / ORANGE / ROUGE
- ANNEXE E — SOURCES OFFICIELLES CONSULTÉES

PARTIE II — LE PÉRIMÈTRE DÉFENDABLE

- 1. LE PROBLÈME, REDÉFINI EN UNE PHRASE
- 2. CE QUE VOUS ABANDONNEZ
- 3. LA FONCTION : OPÉRATEUR DE CONTINUITÉ
- 4. L'OBJET CENTRAL : LE RELEVÉ DE PARCOURS
- 5. LA FRONTIÈRE, RENDUE OPÉRATIONNELLE
- 6. LES TROIS OFFRES
- 7. LE COÛT CACHÉ : VOTRE ARGUMENT COMMERCIAL
- 8. LES QUATRE CHIFFRES À PRODUIRE
- 9. LE PLAN 90 JOURS
- 10. LES TROIS SIGNAUX D'ARRÊT
- 11. LA CHECKLIST AVANT LA PREMIÈRE PRESTATION
- 12. LE PITCH EN 90 SECONDES
- CONCLUSION

PARTIE III — LES QUATRE DEMANDES ÉCRITES

- COURRIER 1 — Secrétariat général du Gouvernement
- COURRIER 2 — Autorité de Régulation du Secteur de la Santé
- COURRIER 3 — Autorité de Protection des Données à caractère Personnel
- BRIEF 4 — Consultation d'avocat

- TABLEAU DE SUIVI DES DEMANDES

PARTIE IV — LE KIT D’ENQUÊTE TERRAIN

- 1. LES TROIS QUESTIONS, ET POURQUOI IL FAUT LES SÉPARER
- 2. PROTOCOLE D’OBSERVATION — LE PATIENT TRACEUR
- 3. FICHE PATIENT TRACEUR
- 4. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À L’OBSERVATION
- 5. GRILLES D’ENTRETIEN
- 6. LE TEST DE SOLVABILITÉ — SEMAINES 7 À 10
- 7. RÈGLES DE SAISIE
- 8. CE QUE VOUS PRODUISEZ EN SEMAINE 12

PARTIE V — LE DOSSIER POUR UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT

- PIÈCE 1 — NOTE DE PRÉSENTATION
- PIÈCE 2 — PROJET DE CONVENTION
- PIÈCE 3 — PRÉPARATION DU RENDEZ-VOUS

PARTIE VI — DOCUMENTS CONTRACTUELS ET PROCÉDURES

- DOCUMENT 1 — CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE
- DOCUMENT 2 — CONTRAT DE PRESTATION À DOUBLE SIGNATURE
- DOCUMENT 3 — CONSENTEMENT DU PATIENT
- DOCUMENT 4 — CODE DE CONDUITE DE L’ACCOMPAGNATEUR
- DOCUMENT 5 — LES SIX FICHES DE PROCÉDURE
- CHECKLIST — AVANT LA PREMIÈRE PRESTATION

NOTE DE SYNTHÈSE

Quatre pages qui se lisent seules. Le reste du dossier les documente.

Le projet en une phrase

Créer une entreprise de services qui fait circuler l'information et les documents entre les acteurs d'un parcours de soins, et qui tient les familles informées de l'état des démarches, de leur coût et de ce qui reste à faire — **sans jamais toucher au contenu médical.**

Le problème

Dans le parcours de soins béninois, chaque acteur fait correctement son travail, et personne n'est chargé de relier ces travaux entre eux. Le médecin prescrit, le laboratoire analyse, la caisse encaisse, le pharmacien dispense. Chacun de ces actes peut être irréprochable, et le parcours dans son ensemble rester chaotique. Ce qui manque n'est pas la compétence : c'est le **chaînage**.

Ce chaînage est assuré par défaut par la famille — c'est-à-dire par la personne la moins équipée pour le faire, et qui paie pour le privilège. Elle transporte des documents qu'elle ne peut pas lire entre des gens qui ne se parlent pas. Elle arbitre l'ordre des dépenses sans aucune information clinique. Et elle est le seul acteur qui voit le parcours en entier — le seul, aussi, que personne n'interroge.

Le retournement commercial. La famille fait déjà ce travail, gratuitement et mal, et elle en paie les conséquences en trajets inutiles, journées de travail perdues, examens refaits et médicaments achetés pour rien. Le projet ne vend donc pas un service nouveau : il vend la professionnalisation d'un travail déjà effectué. C'est la seule proposition qui tienne face à une capacité de paiement très faible — une étude conduite en 2023 dans un hôpital de référence du sud du Bénin conclut que **seuls 14,74 % des usagers avaient une capacité de paiement satisfaisante.**

Ce que le droit permet, et ce qu'il interdit

Le droit béninois reconnaît déjà l'essentiel : accès aux soins, information, consentement, refus de soins, dignité, confidentialité, droit de se plaindre. La Charte des droits et devoirs des patients, lancée le 23 septembre 2025, consacre seize droits et sept devoirs. Le projet ne crée donc aucun droit nouveau : il rend effectifs des droits existants.

Trois interdits structurent tout le reste.

La dispensation de médicaments est réservée aux établissements habilités, et la vente hors des lieux autorisés est punie de un à cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 à 2 000 000 FCFA d'amende. Le projet renonce donc à toute logistique du médicament au lancement.

L'exercice de la médecine appartient aux médecins. Aucun diagnostic, aucune interprétation de résultat, aucune évaluation de gravité — y compris « pour rassurer ».

Les données de santé relèvent d'un régime d'autorisation préalable de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel. Le relevé de parcours, même dépourvu de tout élément clinique, en fait partie : la définition légale inclut la prestation de services de soins. **L'autorisation de l'APDP est un prérequis de lancement, pas une régularisation ultérieure.**

Un point de vigilance majeur. La loi n°2020-37 a été modifiée par la loi n°2022-17 du 19 octobre 2022, qui réécrit trente-six articles, dont presque tous ceux relatifs aux droits du patient. Le texte de ces articles n'a pas pu être obtenu. C'est la première vérification à faire faire.

Le produit

Une fonction : opérateur de continuité du parcours. Trois verbes, et rien d'autre — acheminer un document ou une question, tenir à jour un relevé daté des démarches, alerter un soignant d'un fait observable ou une famille d'une échéance.

Un objet : le relevé de parcours. Un document papier, daté, tenu à jour par l'opérateur, propriété de la famille, sans aucune copie conservée. Il répond à quatre questions à tout moment : où en est-on, qu'est-ce qui a été payé, qu'est-ce qui reste à faire, où sont les papiers. Il comporte un statut « sans objet » qui résout le cas des prestations payées puis devenues inutiles.

Une frontière applicable en deux secondes. « *Ma phrase resterait-elle vraie si je ne savais rien de la maladie de ce patient ?* » Oui, c'est du circuit, c'est autorisé. Non, c'est du contenu, c'est interdit.

Les payeurs, dans l'ordre

Rang	Segment	Pourquoi	Ce qu'il achète
1	Familles présentes , à l'acte	Pour apprendre et mesurer	L'acheminement tracé d'un résultat d'examen jusqu'au prescripteur
2	Établissements de santé	Le décret n°2025-481 leur impose un dispositif de sécurité des patients dont un domaine porte sur l'implication du patient et de la communauté. Échéance datée, budget identifiable.	Des livrables de conformité : supports d'information, recueil de l'expérience patient, appui documentaire
3	Diaspora béninoise	Solvable en devises, géographiquement empêchée, finance déjà les soins de ses proches sans aucun moyen de contrôle	Une présence de confiance et un compte rendu écrit

Le grand public comme canal principal est écarté : la capacité de paiement documentée ne le permet pas.

Ce qui reste à prouver

Quatre chiffres, et rien ne se décide avant.

#	Chiffre	Seuil
1	Coût caché moyen d'un épisode pour un ménage	$\geq 3 \times$ le prix envisagé, sinon pas de marché grand public
2	Délai médian entre la prescription d'un examen et le retour du résultat au prescripteur	S'il est déjà court, l'offre d'entrée n'a pas de marché sur ce site
3	Taux de conversion payant réel — on compte ceux qui paient, pas	À fixer par écrit avant le test

#	Chiffre	Seuil
	ceux qui disent oui	
4	Lettres d'intention d'établissements	≥ 2 sur 5 sollicitées

Le troisième est celui que la plupart des porteurs de projet omettent, parce que c'est le seul qui peut faire mal.

Le calendrier

Douze semaines, quatre-vingt-dix jours, une décision écrite au terme.

Semaines 1-2, le socle juridique et les outils. Semaines 3-6, l'observation de trente à cinquante parcours sur trois sites contrastés. Semaines 5-8, les entretiens. Semaines 7-10, le test de solvabilité — l'offre est vendue réellement, à prix affiché. Semaines 8-11, cinq rendez-vous de direction. Semaine 12, la note de décision : go, no-go, ou pivot.

Les risques, par ordre de probabilité

Risque	Probabilité	Gravité	Traitement
Non-conformité au régime des données de santé	Élevée si rien n'est fait	Élevée	Démarche APDP engagée avant le premier client
Dérive d'un accompagnateur vers le contenu médical	Moyenne	Très élevée	Test des deux secondes, scripts écrits, supervision, sanction
Présence non autorisée en établissement	Élevée sans convention	Moyenne	Ne jamais opérer sans convention écrite
Requalification en distribution de médicaments	Écartée par construction	Très élevée	Le service n'est pas lancé
Perception par l'hôpital d'un contrôleur privé	Réelle	Élevée	Positionnement conformité, rappel des devoirs des patients, aucun bénéfice tiré d'un litige

Les quatre signaux d'arrêt, écrits à l'avance

Un. Le taux de conversion payant est sous le seuil fixé **et** aucun établissement ne signe de lettre d'intention. **Deux.** L'avocat conclut à un risque pénal non maîtrisable sur le cœur de l'activité, et non sur ses périphéries déjà écartées. **Trois.** Le coût caché mesuré est inférieur à trois fois le prix, et l'offre destinée aux établissements ne trouve pas preneur. **Quatre.** Aucune convention écrite obtenue en quatre-vingt-dix jours malgré des rendez-vous obtenus. Ce ne serait pas un problème d'exécution commerciale, mais le signal que le système ne veut pas d'un tiers dans ses murs.

La décision attendue

Ce dossier ne demande pas d'argent et ne propose pas de recruter. Il demande une seule chose : **exécuter les quatre-vingt-dix jours, produire les quatre chiffres, et décider ensuite.**

Ce que ce dossier ne contient pas encore

Par honnêteté, et parce qu'un dossier qui prétend tout contenir n'est pas crédible :

- aucun chiffre d'affaires prévisionnel, aucun plan de financement, aucune grille tarifaire — ils dépendent des quatre chiffres et seraient inventés aujourd'hui ;
 - aucun statut de société ni objet social rédigé — ils dépendent de la consultation d'avocat ;
 - aucun texte des trente-six articles modifiés en 2022, du décret n°2025-481 ni de la Charte officielle — ils font l'objet des trois premières demandes ;
 - aucune donnée de terrain — c'est précisément l'objet des semaines 3 à 11.
-

COMMENT UTILISER CE DOSSIER

Les six parties

Partie	Contenu	Quand s'en servir
I	L'étude juridique, institutionnelle, opérationnelle et stratégique	Pour comprendre le terrain de jeu et ses limites. À lire une fois en entier, puis à consulter par l'annexe D.
II	Le cadrage opérationnel — le périmètre défendable	Le cœur du dossier. C'est la définition du produit. À relire avant chaque décision.
III	Les quatre demandes écrites	Semaines 1-2. À signer et envoyer.
IV	Le kit d'enquête terrain	Semaines 3-11. À imprimer et emporter.
V	Le dossier pour une direction d'établissement	À partir de la semaine 8.
VI	Les documents contractuels et les procédures	Avant la première prestation payante.

L'ordre de lecture selon qui vous êtes

Vous, porteur du projet. La note de synthèse, puis la partie II en entier, puis la partie I. La partie I est longue : ne la lisez pas en premier, vous vous découragerez avant d'arriver au produit.

Un avocat. La partie I, l'annexe B, l'annexe D, puis le brief de la partie III et les documents de la partie VI.

Un directeur d'établissement. La note de synthèse et la partie V uniquement. Rien d'autre — le reste ne le concerne pas et une masse de papier se lit comme un manque de clarté.

Un investisseur ou un incubateur. La note de synthèse, puis les quatre chiffres de la partie II, puis les signaux d'arrêt. Il jugera davantage sur les signaux d'arrêt que sur les promesses.

Un futur associé. Tout, dans l'ordre. Et notamment la partie 8 de l'étude, qui contient les sept objections au projet.

Les quatre niveaux de fiabilité

Chaque affirmation juridique du dossier porte un marqueur. Cette distinction n'est pas une précaution de style : elle conditionne l'usage que vous pouvez faire de chaque phrase.

Marqueur	Signification	Usage
TEXTE	Disposition lue dans un texte officiel identifié	Peut fonder une décision, après vérification au Journal Officiel
INTERPRÉTATION	Lecture raisonnée, non tranchée par la jurisprudence	À faire valider par un avocat. Ne pas inscrire tel quel dans un contrat.

Marqueur	Signification	Usage
PRATIQUE	Fonctionnement rapporté par des sources secondaires	Hypothèse de travail, à vérifier par enquête
HYPOTHÈSE	Raisonnement de l'analyste, non sourcé	Ne jamais présenter comme une règle

Les pièces jointes séparées

Quatre fichiers accompagnent ce dossier et ne peuvent pas y être reproduits, parce qu'ils sont faits pour être remplis :

Fichier	Usage
Cartographie du parcours patient	Matrices T0 à T14, parcours maternité et décès, annexes A à E de l'étude
Outils du périmètre défendable	Relevé de parcours à imprimer, calculateur de coût caché, checklist, carte des phrases
Saisie de l'enquête terrain	Parcours suivis, test de solvabilité, entretiens, synthèse des quatre chiffres
Tableau de bord du projet	Le pilotage des quatre-vingt-dix jours, à tenir à jour chaque semaine

Les trois règles qui gouvernent tout le dossier

Le facilitateur agit sur le circuit, jamais sur le contenu.

Il transmet la question au professionnel ; il ne transmet jamais la réponse à sa place.

Il ne qualifie jamais une situation de faute. Il décrit des faits et oriente vers l'autorité compétente.

ÉTAT D'AVANCEMENT

À tenir à jour. Le tableau de bord joint en contient la version travaillante.

Prérequis	Statut	Échéance	Bloque
Version consolidée de la loi n°2020-37	À faire	Semaine 2	Toute la partie juridique
Consultation d'avocat	À faire	Semaine 4	La décision de la semaine 12
Autorisation APDP	À faire	Semaine 6	La première prestation
Décret n°2025-481 et référentiel	À faire	Semaine 3	L'offre destinée aux établissements

Prérequis	Statut	Échéance	Bloque
Charte officielle des patients	À faire	Semaine 3	Les supports d'information
Convention avec un établissement	À faire	Semaine 11	Le pilote
Assurance responsabilité civile professionnelle	À faire	Avant la 1re prestation	La première prestation
Enquête terrain — 30 à 50 parcours	À faire	Semaine 7	Les chiffres 1 et 2
Test de solvabilité	À faire	Semaine 10	Le chiffre 3
Cinq rendez-vous de direction	À faire	Semaine 11	Le chiffre 4
Note de décision	À faire	Semaine 12	La suite du projet

PARTIE I — ÉTUDE JURIDIQUE, INSTITUTIONNELLE ET STRATÉGIQUE

Le terrain de jeu et ses limites. Ce que le droit béninois reconnaît, ce qu'il interdit, et ce qui n'a pas pu être vérifié.

Objet — Déterminer s'il existe au Bénin un problème réel qu'un service privé de facilitation du parcours de soins peut résoudre **légalement, utilement et durablement**.

Date de l'analyse — 22 août 2026 **Statut** — Document de travail. Ne constitue pas un avis juridique.

AVERTISSEMENT MÉTHODOLOGIQUE — À LIRE AVANT TOUT

Cette étude distingue systématiquement quatre niveaux de fiabilité. Cette distinction n'est pas une précaution de style : elle conditionne l'usage que vous pouvez faire de chaque affirmation.

Marqueur	Signification	Usage possible
[TEXTE]	Disposition lue dans un texte officiel identifié (numéro, date, article).	Peut fonder une décision, après vérification au Journal Officiel .
[INTERPRÉTATION]	Lecture raisonnée d'un texte, non tranchée par la jurisprudence ou l'administration.	À faire valider par un avocat béninois. Ne pas inscrire tel quel dans un contrat.
[PRATIQUE]	Fonctionnement de terrain rapporté par des sources secondaires (presse, études académiques, documents d'institutions).	Hypothèse de travail. À vérifier par enquête.
[HYPOTHÈSE]	Raisonnement de l'analyste, non sourcé.	Ne jamais présenter comme une règle.

Trois limites majeures que vous devez connaître

1. La loi n°2020-37 a été largement réécrite en 2022 — et je n'ai pas pu lire cette réécriture.

La loi n°2022-17 du 19 octobre 2022 modifie 36 articles de la loi n°2020-37, dont : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 65, 66, 80, 81.

Autrement dit : **presque tous les articles relatifs aux droits du patient, au consentement, au refus de soins, à la plainte, aux devoirs de la population et au décès ont été modifiés**. Je n'ai pu récupérer que le nouvel article 1er (définitions) ; le texte des autres articles modifiés n'était pas extractible des versions numériques accessibles.

Conséquence pratique : les numéros et le contenu d'articles cités dans cette étude à partir de la version 2021 doivent être **impérativement recoupés avec la version consolidée 2022** avant tout usage contractuel, commercial ou institutionnel. C'est le premier acte de vérification à confier à un avocat.

Note importante : votre document de départ ne mentionnait pas cette modification de 2022. C'est exactement le type d'angle mort qui peut fragiliser un business plan bâti sur une lecture datée de la loi.

2. Le décret n°2025-481 existe, mais son texte intégral ne m'était pas lisible.

L'existence, le titre exact et la date du décret sont confirmés par le Secrétariat général du Gouvernement. Le PDF officiel n'a pas de couche texte exploitable. Le contenu décrit ici provient de sources institutionnelles secondaires (communiqué du Conseil des ministres, gouv.bj, ARS, presse nationale) et du manuel de sécurité des patients diffusé par l'ARS. **Le détail article par article reste à vérifier.**

3. Le Code pénal (loi n°2018-16) : articles non localisés.

Je n'ai pas pu localiser les articles précis relatifs à l'exercice illégal de la médecine, à la violation du secret professionnel et à la non-assistance à personne en danger dans le Code pénal béninois de 2018. Les qualifications pénales évoquées dans cette étude s'appuient sur la loi n°2021-03 (qui contient ses propres sanctions, vérifiées) et sur un raisonnement analogique. **Je n'ai pas trouvé de disposition officielle suffisamment claire pour conclure sur le périmètre pénal exact de l'exercice illégal de la médecine au Bénin.**

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1.1 Réponse courte à la question posée

Oui, il existe au Bénin un problème réel. Non, ce n'est probablement pas exactement celui que vous pensez avoir identifié. Et la partie de ce problème qu'un service privé peut légalement traiter est **plus étroite** — mais aussi **plus défendable** — que le concept large de « facilitateur du parcours patient ».

1.2 Les six conclusions qui comptent

Conclusion 1 — Le droit béninois est de votre côté, mais il ne crée pas votre marché.

La loi n°2020-37 reconnaît déjà l'accès aux soins, l'information, le consentement, le refus de soins, la dignité, la confidentialité et le droit de se plaindre. La Charte des droits et devoirs des patients, lancée le 23 septembre 2025 par l'ARS avec le ministère de la Santé et Amnesty International Bénin, consacre 16 droits et 7 devoirs. Votre service ne créerait donc aucun droit nouveau : il rendrait effectifs des droits existants.

C'est une bonne chose sur le plan juridique — vous n'avez rien à faire reconnaître. C'est un problème sur le plan commercial : **l'effectivité d'un droit est rarement un produit que quelqu'un accepte de payer.** Ce point est développé en partie 8 et il est le plus important de toute l'étude.

Conclusion 2 — Le décret n°2025-481 est votre meilleure porte d'entrée, et elle n'est pas B2C.

Le décret du 23 juillet 2025 impose aux établissements publics **et privés** un dispositif de sécurité des patients, structuré autour de cinq domaines dont l'un est explicitement « **implication du patient et de la communauté** ». Le dispositif comporte 21 normes et 134 critères pour les hôpitaux, 19 normes et 125 critères pour les structures de premier contact, avec un délai de mise en conformité de 12 mois et une évaluation par l'ARS tous les trois ans.

Traduction : **depuis 2025, améliorer l'information et l'implication du patient n'est plus une bonne intention hospitalière, c'est une obligation réglementaire évaluée.** Un établissement qui doit se mettre en conformité a un problème daté, mesuré, et un responsable désigné. C'est la définition d'un besoin solvable. Aucun ménage béninois n'a d'échéance réglementaire ; les hôpitaux, oui.

Conclusion 3 — Le médicament est la zone la plus dangereuse de votre projet.

La loi n°2021-03 réserve la dispensation aux établissements habilités (art. 17) et punit la vente de médicaments hors des lieux autorisés de **1 à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 à 2 000 000 FCFA d'amende** (art. 90). Le code de déontologie médicale interdit par ailleurs au médecin d'exercer dans des locaux commerciaux où sont vendus des médicaments (art. 20, ordonnance n°1973-14).

Un service qui achète, détient, transporte et remet un médicament s'expose à une requalification. Le seul montage défendable — et il reste à faire valider — repose sur trois piliers : **la famille est l'acheteur et le propriétaire**

juridique du produit, la facture de la pharmacie est au nom du patient, et votre rémunération ne porte **jamais** sur le médicament. Détails en partie 7.4.

Conclusion 4 — Vous ne pouvez pas recevoir d'argent d'une pharmacie. Jamais.

Le modèle « pharmacies partenaires qui versent une commission » est à écarter sans discussion. Il vous placerait en situation de conflit d'intérêts frontal, il détruirait la confiance qui est votre seul actif, et il vous rapprocherait des logiques de compérage et de partage d'honoraires que la déontologie des professions de santé prohibe (art. 18, ordonnance n°1973-14). Un facilitateur payé par un vendeur n'est pas un facilitateur : c'est un rabatteur.

Conclusion 5 — Les données de santé constituent le risque le plus silencieux et le plus sous-estimé.

L'article 394 du Code du numérique soumet les données de santé à un régime particulier impliquant une **autorisation préalable de l'APDP** — pas une simple déclaration. Or votre accompagnateur n'est pas un professionnel de santé : **il n'est pas tenu au secret médical**, seulement à une obligation contractuelle, juridiquement plus faible. Photographier des ordonnances et conserver des résultats vous ferait entrer, dès le premier client, dans un régime lourd sans en avoir les protections.

Recommandation ferme : concevez le service pour détenir le moins de données possible. Zéro photo d'ordonnance conservée. C'est un choix d'architecture, pas une option de conformité.

Conclusion 6 — Le problème dominant au Bénin n'est pas l'incompréhension. C'est l'argent.

Une étude conduite en 2023 dans un hôpital de référence du sud du Bénin conclut que **seuls 14,74 % des usagers avaient une capacité de paiement satisfaisante**. Les facteurs associés à l'incapacité de payer incluent le chômage, le petit commerce, l'absence de dispositif social hospitalier et l'attente au paiement d'une heure ou plus.

Cela ne détruit pas votre idée. Cela la déplace. Vendre un service de compréhension à des ménages dont le problème premier est de payer les soins eux-mêmes est structurellement difficile. **Deux reformulations méritent d'être testées avant tout autre chose** : (a) le segment payeur naturel est la **diaspora** — absente géographiquement, solvable en devises, et dont la demande est précisément « quelqu'un sur place en qui j'ai confiance » ; (b) le service à plus forte valeur perçue n'est peut-être pas la compréhension médicale mais la **navigation financière** — inscription à l'AMO, identification de ce qui est déjà gratuit (la césarienne l'est), lecture d'une facture, évitement de dépenses inutiles.

1.3 Ce que je vous déconseille, clairement

À écarter	Motif
Le B2C grand public comme modèle principal	Capacité de paiement documentée très faible. Vous vendriez du confort à des gens en arbitrage de survie.
Toute commission versée par une pharmacie, un laboratoire ou une clinique	Conflit d'intérêts, risque déontologique, destruction de l'actif « confiance ».
La constitution d'une base de données médicales	Régime d'autorisation APDP, absence de secret médical opposable, risque réputationnel majeur.
Le positionnement « défense du patient contre l'hôpital »	Vous fermeriez toutes les portes hospitalières en six mois.
Le lancement avant une convention écrite avec au moins un établissement	Vous seriez un tiers non identifié dans un lieu de soins. Situation intenable.

1.4 Ce que je vous recommande de tester d'abord

1. **Un pilote conventionné** avec un hôpital de zone ou un CHD, adossé explicitement à sa mise en conformité au décret n°2025-481, domaine « implication du patient et de la communauté ».

2. **Une offre diaspora** en parallèle, sur un périmètre volontairement étroit : présence physique, compte rendu écrit, coordination administrative, zéro contenu médical.
 3. **Une enquête terrain de 8 à 12 semaines** avant de figer l'offre — protocole détaillé en partie 9.
-

2. CADRE JURIDIQUE BÉNINOIS

2.1 Architecture générale

Le droit de la santé béninois pertinent pour votre projet repose sur quatre étages :

Étage 1 — La loi-cadre. Loi n°2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes, **modifiée par la loi n°2022-17 du 19 octobre 2022**. Elle pose les droits du patient, les obligations des praticiens et des établissements, le régime de responsabilité.

Étage 2 — Les lois sectorielles. Loi n°2021-03 du 1er février 2021 sur les activités pharmaceutiques. Loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique, modifiée par la loi n°2020-35 du 6 janvier 2021, pour les données personnelles.

Étage 3 — Les décrets d'organisation. Décret n°2022-148 (pyramide sanitaire), décret n°2019-417 (création de l'ARS), décret n°2025-481 (sécurité des patients), décret n°2023-327 (assurance maladie obligatoire), décret n°2023-422 (statuts de l'ABMed).

Étage 4 — La déontologie professionnelle. Ordonnance n°1973-14 du 8 février 1973 instituant un code de déontologie médicale ; ordonnance n°1973-30 du 31 mars 1973 pour d'autres professions de santé. Textes anciens, dont l'articulation avec la loi de 2021 mériterait une vérification. **[À VÉRIFIER]**

2.2 Les textes, un par un

Loi n°2020-37 du 3 février 2021 — protection de la santé des personnes

Source : Secrétariat général du Gouvernement, <https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2020-37/> **Modifiée par :** loi n°2022-17 du 19 octobre 2022, <https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2022-17/>

Dispositions relevées dans la version 2021 — **numérotation à reconstruire après la modification de 2022 :**

Art.	Contenu	Portée pour votre projet
5	Le droit à la santé est un droit fondamental ; le système sanitaire garantit l'égal accès aux soins.	Fondement général. Ne crée pas d'obligation directe pour un tiers privé.
6	Droit au respect de la vie privée et de la dignité ; à l'information et au respect de la confidentialité ; à l'expression de sa volonté.	Cœur de votre proposition de valeur. Le droit à l'information existe ; il est mal exercé.
7	« Tout patient a le droit d'accepter ou de refuser un acte médical ou l'application d'un traitement médical. »	Votre rôle : aider à formuler. Jamais à décider.
8	En cas de faute médicale suspectée, le patient ou sa famille peut saisir le ministre chargé de la santé, l'ordre national concerné ou	Disposition opérationnelle immédiatement exploitable — voir 7.3. Un délai court que les familles

Art.	Contenu	Portée pour votre projet
	la juridiction compétente, dans un délai de deux mois.	ignorent presque toujours.
9	Le consentement du patient est obtenu par le médecin ou tout autre praticien pour tout acte ou traitement médical.	Le consentement appartient au patient. Votre accompagnateur ne le porte ni ne le supplée.
10	La décision d'accepter ou de refuser un soin peut être exprimée à tout moment.	Réversibilité. Utile à expliquer aux familles.
11	En cas de refus malgré les risques, le praticien consigne la décision au dossier et informe le chef d'établissement, qui informe le procureur.	Procédure lourde et méconnue. Source d'incompréhension familiale majeure.
12	Mêmes procédures lorsque la personne de confiance désignée refuse les soins.	Confirme l'existence de la « personne de confiance » en droit béninois.
13	Refus parental mettant en danger la vie de l'enfant : information sur les conséquences civiles et pénales, consignation, saisine du juge des mineurs ou du procureur.	Situation à haut risque. Votre accompagnateur ne doit jamais s'y positionner.
14	La violation des articles 6, 9, 10, 11, 12 et 13 est passible de sanctions pénales.	Les droits du patient sont pénalement sanctionnés. Argument fort auprès des directions.
21	L'État assure la protection de la personne et des biens du praticien dans l'exercice de ses fonctions.	Rappel utile : le soignant est aussi protégé. À intégrer dans votre discours institutionnel.
22	Le professionnel fait preuve de responsabilité, moralité, probité, éthique, esprit d'équipe, dévouement, équité.	Standard de comportement.
28	« Le pharmacien est au service du public. Il fait preuve du même dévouement envers tous les malades. »	
45	La population, à l'occasion de l'utilisation des services de santé, fait preuve de responsabilité, de discipline, de probité, d'esprit d'équipe.	Base légale des « devoirs du patient » — rédaction très générale.

Art.	Contenu	Portée pour votre projet
56	Signalement des maladies à déclaration obligatoire sous 72 h à l'autorité hiérarchique, à titre confidentiel et exclusif ; interdiction de transmettre hors de la structure sauf ordre de la loi.	Confirme un régime de confidentialité strict. Un tiers privé n'y a aucun accès.
65	« Tout décès est médicalement constaté. » Modalités fixées par acte réglementaire.	Le constat de décès est un acte médical . Point capital pour le scénario décès.
66	Aucun acte de décès ne peut être délivré sans la déclaration de décès.	Chaîne administrative.
67	L'audit de décès est obligatoire.	Ouverture institutionnelle majeure — voir 7.5.
68	Les responsables des structures produisent mensuellement un rapport sur les résultats des audits de décès.	Obligation périodique documentée : donc un besoin de collecte et de mise en forme.
75	Tout praticien commettant une faute médicale causant un dommage est passible de sanction administrative ou pénale.	
76	Tout établissement de soins dans lequel un patient subit un dommage du fait des soins engage sa responsabilité civile .	Responsabilité de l'établissement, distincte de celle du praticien.
77	Tout établissement sanitaire, public ou privé, doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile.	Précédent utile : l'assurance RC est une obligation légale dans ce secteur. Vous devrez vous assurer aussi.

[TEXTE / à recontrôler post-2022] pour l'ensemble du tableau.

Loi n°2022-17 du 19 octobre 2022 — modification de la loi n°2020-37

Source : <https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2022-17/>

Son article 1er énumère les articles modifiés : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 36, 37, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 65, 66, 80, 81. [TEXTE]

Le nouvel article 1er introduit ou précise des définitions, dont « **audit de décès** » (analyse systématique et critique de la qualité des soins), « **déclaration obligatoire** », « **environnement** » et « **équité en santé** ». [TEXTE]

Le contenu des 35 autres articles modifiés n'a pas pu être extrait. [LACUNE — action prioritaire]

Un point de contexte : la loi n°2022-17 est présentée dans la presse béninoise comme portant notamment sur l'entrée en vigueur de l'assurance maladie obligatoire. [PRATIQUE] Il est donc plausible que la modification ait un axe « financement et couverture » en plus de l'axe « droits ». À confirmer.

Décret n°2025-481 du 23 juillet 2025 — dispositif pour la sécurité des patients

Source : <https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2025-481/>

Titre exact confirmé : « portant réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin ». [TEXTE]

Éléments de contenu reconstitués à partir de sources institutionnelles [PRATIQUE, fiabilité moyenne à bonne] :

- **Champ** : tous les acteurs exerçant dans les établissements de santé publics et privés, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
- **Objectifs affichés** : réduire les préjudices causés aux patients, améliorer la qualité du service, restaurer la confiance des populations et accroître la fréquentation des formations sanitaires.
- **Structure du dispositif — cinq domaines** : (1) management et gouvernance ; (2) **implication du patient et de la communauté** ; (3) pratiques cliniques sécurisées ; (4) environnement sécurisé ; (5) apprentissage continu.
- **Référentiel** : 21 normes et 134 critères pour les hôpitaux ; 19 normes et 125 critères pour les structures de premier contact. Critères classés en niveaux essentiel, fondamental et avancé.
- **Calendrier** : 12 mois de mise en conformité à compter de l'entrée en vigueur ; évaluations ensuite tous les trois ans. Échéance de **fonctionnement numérique au 1er janvier 2026**.
- **Pilotage** : l'ARS conduit les évaluations avec des outils standardisés. Auto-évaluations engagées dès mars 2024 (près de 1 900 recensées). Les établissements conformes reçoivent une classification de niveau ; les non-conformes reçoivent un plan d'amélioration plutôt qu'une sanction immédiate.
- **Plateforme numérique** développée avec l'APDP pour la transmission de documents et la communication, avec protection du secret médical.

Pourquoi ce texte est central pour vous : le domaine 2 « implication du patient et de la communauté » est, littéralement, votre métier — mais transformé en obligation opposable à l'établissement. Vous ne vendez plus une idée : vous vendez une **contribution à une conformité datée et évaluée**.

[ACTION PRIORITAIRE] Obtenir le texte intégral du décret et le référentiel de normes auprès de l'ARS. Le domaine 2 et ses critères constituent, à eux seuls, le cahier des charges de votre offre B2B.

Loi n°2021-03 du 1er février 2021 — activités pharmaceutiques

Source : <https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2021-03/>

Art.	Contenu	Portée
6	Seuls les pharmaciens, ou des personnes agissant sous leur responsabilité, peuvent effectuer notamment la préparation, l'importation, l'exportation et la distribution des médicaments.	Monopole pharmaceutique. Le mot « distribution » est le plus dangereux pour vous.
7	Exceptions pour établissements agréés et vétérinaires dans leurs cliniques.	Aucune exception ne vise un prestataire de services logistiques.
17	« La dispensation de médicaments ne peut être faite que par les établissements habilités », selon des règles de bonnes pratiques.	Vous ne dispensez pas. Point final.
41	Les officines privées	Le circuit d'approvisionnement est

Art.	Contenu	Portée
	s'approvisionnent auprès des grossistes-répartiteurs, sauf dérogation.	fermé et nommé. Vous n'y figurez pas.
72	Dans les établissements de soins privés, le médicament ne peut être séparé de la prestation de soins.	Confirme le lien indissociable soin/médicament dans le privé.
73	Les pharmacies des établissements publics s'approvisionnent auprès des centrales d'achat publiques dédiées.	Une rupture en pharmacie hospitalière publique renvoie à un problème de chaîne publique, pas à une faute du soignant. Argument déterminant dans le scénario « médicament urgent ».
90	Interdiction de la vente sur la voie publique, dans les marchés et au détail hors des lieux autorisés. Peine : 1 à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 à 2 000 000 FCFA d'amende.	La sanction est réelle et lourde.
91-95	Sanctions pour fausses déclarations : 2 à 10 ans, 500 000 à 500 000 000 FCFA.	

[TEXTE]

Observation : la loi ne contient pas d'articles spécifiquement consacrés à la vente en ligne ni au transport de médicaments par un tiers. **[LACUNE]** Ce silence n'est pas une autorisation — c'est une zone grise. Une zone grise sur laquelle pèsent les articles 6 et 90 n'est pas un espace de liberté ; c'est un espace de risque non chiffré.

Code du numérique — loi n°2017-20 du 20 avril 2018, modifiée par la loi n°2020-35 du 6 janvier 2021

Art.	Contenu	Portée
1er	Définition des données sensibles : incluent les données relatives à la santé et à la génétique. Définition des données concernant la santé : toute information concernant l'état physique et mental d'une personne, y compris la prestation de services de soins. Définitions du consentement (volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée) et du responsable du traitement .	Une photo d'ordonnance est une donnée de santé. Un nom associé à un service hospitalier aussi.
394	Les données de santé relèvent d'un régime particulier : autorisation préalable de l'APDP.	L'obligation centrale. Autorisation, pas déclaration.

Art.	Contenu	Portée
405, 407, 410	Formalités préalables auprès de l'APDP : déclaration préalable de tous les traitements automatisés ou non automatisés.	La formalité s'applique aussi aux traitements non automatisés — donc à un registre papier.
435	Tenue d'un registre des traitements.	
387	Rapport annuel de l'APDP.	

[TEXTE, sous réserve] — les numéros d'articles proviennent de documents pédagogiques de l'APDP et d'un article professionnel béninois, non de la lecture directe du Code. **À faire confirmer.**

Ce que cela signifie concrètement : dès le premier client, si vous enregistrez un nom, un numéro de téléphone et un motif d'hospitalisation, vous êtes responsable de traitement de données de santé. Vous devez : obtenir le consentement exprès et spécifique du patient (pas seulement de la famille), demander l'autorisation de l'APDP, tenir un registre, sécuriser, définir une durée de conservation et une procédure de suppression.

Décret n°2022-148 — organisation de la pyramide sanitaire

Trois niveaux **[TEXTE, art. 3]** :

- **Périphérique (zone sanitaire)** : structures de premier contact — centres de santé d'arrondissement et de commune, maternités et dispensaires isolés, infirmeries scolaires et de travail, cabinets et cliniques privés (art. 11) — offrant un « paquet minimum de soins » ; l'**hôpital de zone** en assure la référence (art. 13 : médecine générale, chirurgie générale, obstétrique, pédiatrie, urgences, diagnostic de base).
- **Intermédiaire (départemental)** : Directions départementales de la santé et **CHD** (art. 18, 21 : médecine et chirurgie générales et spécialisées, obstétrique, pédiatrie, urgences et réanimation, diagnostic avancé).
- **Central** : structures ministérielles et hôpitaux nationaux de référence (art. 23).

Utilité pour vous : la mauvaise orientation dans la pyramide est une cause majeure de déplacements inutiles et de dépenses évitables. Une famille qui se présente au CHD pour un motif relevant du centre de santé d'arrondissement paie plus cher, attend plus longtemps, et encombre un service. **C'est un problème d'orientation pur — donc dans votre périmètre légal sans aucune ambiguïté.**

Décret n°2019-417 du 25 septembre 2019 — Autorité de régulation du secteur de la santé (ARS)

[TEXTE] L'ARS conduit les processus de **certification des établissements** de santé et en assure le suivi (art. 5), ainsi que les processus d'**accréditation des praticiens** médicaux et paramédicaux. La certification atteste qu'un établissement satisfait aux normes de qualité et de sécurité après évaluation interne et externe (art. 6). Les actes d'accréditation et de certification sont pris par le ministre chargé de la Santé sur rapport motivé de l'Autorité. Une commission qualité instruit les dossiers de certification (art. 33).

Constat important : le décret **ne mentionne pas explicitement** un mécanisme de traitement des plaintes des usagers par l'ARS. **[LACUNE]** L'article 8 de la loi n°2020-37 oriente les plaintes vers le ministre, l'ordre professionnel ou la juridiction — pas vers l'ARS. Ne dites donc pas à une famille qu'elle « peut saisir l'ARS » sans avoir vérifié ce point.

Décret n°2023-422 du 26 juillet 2023 — ABMed

[TEXTE / PRATIQUE] L'Agence béninoise du Médicament et des autres produits de santé est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, sous tutelle du ministère de la Santé. Missions : autorisation des établissements pharmaceutiques, homologation des produits, surveillance de la qualité et de la disponibilité, inspection de toutes les activités pharmaceutiques, lutte contre les produits falsifiés, vigilance.

Pourquoi c'est votre interlocuteur : c'est l'ABMed, et non l'ARS, qui est compétente pour vous dire si votre montage logistique médicament est acceptable. Une position écrite de l'ABMed vaudrait mille pages de business plan.

Décret n°2023-327 du 21 juin 2023 — assurance maladie obligatoire

[TEXTE — titre uniquement] Le contenu n'était pas extractible. L'AMO est en déploiement, avec un durcissement des obligations en 2025-2026 **[PRATIQUE]**.

[ACTION] Récupérer le décret et le panier de soins. La navigation AMO est, à mon sens, un des gisements de valeur les plus tangibles de votre projet — mais vous ne pouvez pas la vendre sans maîtriser le texte.

Code de déontologie médicale — ordonnance n°1973-14 du 8 février 1973

Source : <https://sgg.gouv.bj/doc/ordonnance-1973-14/>

Art.	Contenu	Portée pour un tiers non soignant
5	Hors cas d'urgence, le médecin doit porter assistance immédiate quand aucun autre secours médical n'est disponible.	
7	« Le secret professionnel s'impose à tout médecin, sauf dérogation par la loi. »	Votre accompagnateur n'est pas couvert par ce secret. Il ne peut donc pas en être le destinataire légitime sans le consentement du patient.
11	La médecine ne peut être pratiquée comme un commerce ; publicité et procédés spectaculaires interdits.	Attention à votre communication : ne jamais faire de publicité qui associe un médecin nommé à votre service.
18 (2°, 4°, 5°)	Interdiction de la dichotomie et du partage de bénéfices entre praticiens ; interdiction des commissions pour orientation de patients et de toute rémunération pour prescriptions ou actes médicaux.	Fondement déontologique du refus de toute commission. Si un médecin ne peut recevoir de commission pour orienter, un tiers qui en verse ou en reçoit se place dans un système que la déontologie condamne.
20	Le médecin ne peut exercer dans des locaux commerciaux où sont vendus des médicaments ou appareils, ni dans leurs dépendances.	Interdit d'adosser un point de conseil médical à une activité de vente.
33	Un pronostic grave peut être tu avec discrétion ; un pronostic fatal doit en principe être révélé à la famille, sauf interdiction du patient.	L'annonce appartient au médecin. Votre accompagnateur ne l'anticipe ni ne la double.
35	Le médecin ne peut se retirer qu'en assurant la continuité des soins et	

Art.	Contenu	Portée pour un tiers non soignant
	en donnant les informations nécessaires.	
37	L'avortement thérapeutique requiert le consentement exprès de la patiente, sauf urgence extrême.	

[TEXTE] Texte ancien (1973) ; son articulation avec la loi n°2020-37 modifiée mériterait une vérification par un juriste. **[À VÉRIFIER]**

Charte des droits et devoirs des patients en République du Bénin

Lancée le 23 septembre 2025 par l'Autorité de régulation du secteur de la santé, avec le ministère de la Santé et Amnesty International Bénin. **16 droits et 7 devoirs.** **[TEXTE / PRATIQUE]**

Droits identifiés dans les sources accessibles (liste **incomplète**) :

1. Libre choix de l'établissement de santé
2. Libre choix du professionnel de santé
3. Droit à un environnement sanitaire sain, sûr et adapté à sa condition
4. Accès équitable aux soins, sans discrimination
5. Respect de la vie privée
6. Protection de l'intimité
7. Respect de la dignité
8. Consentement éclairé avant tout acte
9. Droit de refuser un traitement
10. Droit d'accepter un traitement
11. Droit à l'information et à la compréhension de son état, des examens et des traitements proposés, et de poser des questions
12. Confidentialité des informations médicales
13. Droit à des soins sûrs, prodigués par du personnel qualifié avec un matériel approprié
14. Droit d'être traité avec courtoisie, respect et dignité, sans discrimination
15. Droit à la continuité des soins **[à confirmer]**
16. Droit à des soins de qualité quels que soient l'âge, l'origine ou la situation

Devoirs identifiés (liste **incomplète**) :

1. Respecter le règlement intérieur de l'établissement
2. Suivre les prescriptions médicales
3. Informer le personnel de toute complication
4. Adopter un comportement respectueux envers le personnel soignant
5. Respecter les autres patients
6. Fournir des informations exactes sur sa santé pour faciliter le diagnostic et le traitement
7. Signaler les anomalies ou risques pour la santé publique

[ACTION PRIORITAIRE] Obtenir la charte officielle auprès de l'ARS ou d'Amnesty International Bénin. **Ce document est votre meilleur outil de médiation** : il est officiel, pédagogique, bilingue dans son esprit, et il légitime immédiatement votre discours auprès des familles comme des soignants. Vous n'avez pas besoin d'écrire votre propre charte — vous devez diffuser celle-là.

2.3 Conflits et articulations entre textes

Conflit apparent n°1 — Version 2021 vs version 2022 de la loi n°2020-37. Résolution : la loi n°2022-17 du 19 octobre 2022 est postérieure et modificative. **C'est elle qui prévaut** pour les 36 articles concernés. Toute citation de la version initiale est aujourd'hui potentiellement caduque.

Conflit apparent n°2 — Déontologie de 1973 vs loi de 2021. Résolution : une loi prime sur une ordonnance à valeur réglementaire dans son domaine. Mais la loi de 2021 ne semble pas avoir abrogé expressément le code de déontologie. **[INTERPRÉTATION]** Les deux coexistent, la loi l'emportant en cas de contradiction directe. À faire trancher.

Conflit apparent n°3 — Qui traite les plaintes ? L'article 8 de la loi n°2020-37 désigne le ministre, l'ordre national, ou la juridiction. Le décret n°2019-417 confie à l'ARS la certification et l'accréditation, sans mécanisme de plainte explicite. **[LACUNE]** Il n'y a pas nécessairement contradiction — plutôt deux circuits distincts (disciplinaire/juridictionnel d'un côté, qualité/certification de l'autre). Mais pour une famille, cette dualité est illisible. **C'est un point de rupture identifié, et un espace d'intervention pour vous.**

3. DROITS ET DEVOIRS DU PATIENT — ET DE SA FAMILLE

3.1 Le patient

Ses droits (synthèse opérationnelle)

Droit	Base	Ce que la famille comprend mal, en pratique
Accès aux soins et égalité	L. 2020-37 art. 5 ; Charte	Confond « droit d'accès » et « gratuité ». La plupart des soins restent payants.
Information	L. 2020-37 art. 6 ; Charte	Croit que le silence du médecin est un refus d'informer, alors qu'il est souvent une contrainte de temps ou de langue.
Compréhension et droit de poser des questions	Charte	Ignore qu'elle a le droit de demander une reformulation. C'est le levier le plus simple et le plus efficace.
Consentement	L. 2020-37 art. 9 ; Charte	Croit que signer un papier est le consentement. Le consentement est un processus, pas une signature.
Refus de soins	L. 2020-37 art. 7, 10	Ignore que le refus est réversible à tout moment (art. 10) et qu'il déclenche une procédure formelle (art. 11).
Dignité, vie privée, intimité	L. 2020-37 art. 6 ; Charte	Ne se plaint jamais, par crainte de représailles sur la qualité des soins.

Droit	Base	Ce que la famille comprend mal, en pratique
Confidentialité	L. 2020-37 art. 6, 56 ; Code numérique	Ne sait pas que la confidentialité s'oppose aussi à d'autres membres de la famille .
Sécurité des soins	Décret 2025-481 ; Charte	Récent. Presque totalement inconnu du public.
Plainte et recours	L. 2020-37 art. 8	Ignore le délai de deux mois . C'est la lacune la plus coûteuse.
Libre choix de l'établissement et du professionnel	Charte	Théorique en zone rurale : le libre choix suppose une offre.
Continuité des soins	L. 2020-37 (art. 5) ; déontologie art. 35	Ne sait pas à qui s'adresser entre deux consultations.

Ses devoirs

[TEXTE] L'article 45 de la loi n°2020-37 (dans sa version 2021) formule les devoirs de façon très générale : responsabilité, discipline, probité, esprit d'équipe. La Charte de 2025 est plus concrète : respecter le règlement intérieur, suivre les prescriptions, informer le personnel des complications, se comporter respectueusement envers le personnel et les autres patients, donner des informations exactes sur sa santé, signaler les anomalies et risques de santé publique.

Point important pour votre positionnement institutionnel : un service qui rappelle aussi les **devoirs** du patient est perçu très différemment, par les soignants, d'un service qui ne parle que de droits. Faites-en un pilier explicite de votre discours. C'est peu coûteux et cela change tout dans la relation avec les équipes.

3.2 La famille et l'accompagnant — la distinction la plus mal comprise du système

C'est ici que se logent la majorité des malentendus, et c'est ici que votre projet peut faire le plus de dégâts s'il est mal conçu.

Ce que le droit béninois reconnaît :

- La **personne de confiance** existe : l'article 12 de la loi n°2020-37 prévoit les procédures applicables « lorsque la personne de confiance désignée refuse les soins ». **[TEXTE]** Le régime précis de sa désignation n'a pas pu être vérifié. **[LACUNE — à vérifier dans la version 2022]**
- Les **parents** interviennent pour le mineur (art. 13).
- La **famille** est destinataire de l'annonce d'un pronostic fatal, sauf interdiction du patient (déontologie art. 33).
- La famille peut **saisir** les autorités en cas de faute médicale suspectée (art. 8).

Ce que le droit ne dit pas : que la famille décide. Un patient adulte conscient décide seul. Un époux, un fils aîné, un chef de famille n'ont **aucun pouvoir de décision médicale** de plein droit sur un adulte capable.

[INTERPRÉTATION] En pratique, au Bénin comme ailleurs en Afrique de l'Ouest, la décision est fréquemment collective et familiale, y compris pour des adultes capables. Ce décalage entre le droit et l'usage est un **fait social**, pas une pathologie. Votre service ne doit ni le nier ni l'aggraver.

Règle que je vous recommande d'inscrire dans votre code de conduite :

L'accompagnateur s'adresse en priorité au patient lui-même lorsque celui-ci est conscient et capable. Il ne transmet d'information médicale à un tiers, fût-il un proche, qu'avec l'accord du patient. En cas de doute, il ne transmet rien et renvoie la famille vers le soignant.

Cette règle vous coûtera des clients mécontents. Elle vous évitera un contentieux et vous distinguera immédiatement de n'importe quel intermédiaire informel.

3.3 Le tiers payeur familial — la situation la plus fréquente et la plus piègeuse

Le cas typique : c'est le fils installé à Cotonou, ou en France, qui paie. Il veut donc savoir. Le patient, lui, est le seul titulaire du droit à l'information.

[INTERPRÉTATION] Payer ne donne aucun droit d'accès aux informations médicales. Le contrat de votre service doit donc distinguer explicitement :

- le **client** (celui qui paie et qui reçoit un service logistique, administratif et organisationnel) ;
- le **patient** (le seul titulaire des droits médicaux, dont le consentement écrit conditionne toute circulation d'information le concernant).

Concrètement : votre contrat type doit comporter **deux signatures** dès que le payeur n'est pas le patient, et le service doit rester exécutable même si le patient refuse la transmission d'informations. Sinon, vous vendez un service dont l'exécution dépend d'un consentement que vous ne contrôlez pas.

4. OBLIGATIONS ET LIMITES DES PROFESSIONNELS

Cette partie répond aux points 4 à 8 de votre cahier des charges. Un avertissement d'abord : **je n'ai pas trouvé, pour les infirmiers et les sages-femmes béninois, de texte réglementaire accessible définissant précisément leurs actes et compétences.** Ce qui suit repose donc, pour ces deux professions, sur la loi n°2020-37 (dispositions générales) et sur des principes communs à l'espace francophone. **Traitez-le comme une hypothèse à vérifier auprès des ordres et associations professionnelles béninoises, pas comme une règle établie.**

4.1 Le médecin

Obligation	Base	Conséquence pour le facilitateur
Recueillir le consentement pour tout acte ou traitement	L. art. 9	Vous ne recueillez jamais un consentement. Vous pouvez aider à préparer les questions avant l'entretien.
Informar le patient	L. art. 6	Vous ne remplacez pas l'information médicale. Vous pouvez aider à reformuler une question et à vérifier que la famille a compris ce que le médecin a dit.
Respecter le secret professionnel	Déontologie art. 7	Vous n'êtes pas destinataire de plein droit.
Consigner un refus de soins au dossier, informer le chef d'établissement	L. art. 11	Vous pouvez expliquer la procédure à la famille. Vous ne l'enclenchez pas.
Assurer la continuité des soins en	Déontologie art. 35	

Obligation	Base	Conséquence pour le facilitateur
cas de retrait		
Porter assistance immédiate hors urgence si aucun autre secours n'est disponible	Déontologie art. 5	
Annoncer un pronostic fatal à la famille, sauf interdiction du patient	Déontologie art. 33	L'annonce du décès et du pronostic appartient au médecin. Interdiction absolue pour vous.
Ne pas percevoir de commission pour orientation de patients, ne pas partager d'honoraires	Déontologie art. 18	Corollaire direct : vous ne versez ni ne recevez aucune commission.
Ne pas exercer dans des locaux commerciaux vendant des médicaments	Déontologie art. 20	N'installez jamais un point de service dans ou contre une pharmacie.
Ne pas pratiquer la médecine comme un commerce ; pas de publicité	Déontologie art. 11	Ne nommez jamais un médecin dans votre communication commerciale.
Répondre d'une faute médicale (sanction administrative ou pénale)	L. art. 75	

4.2 L'infirmier

[HYPOTHÈSE — à vérifier] Exécution des soins relevant de son rôle propre et des soins prescrits ; surveillance de l'état du patient ; administration des traitements selon prescription et protocoles ; transmission des informations à l'équipe ; tenue des documents de soins ; alerte du médecin en cas de changement d'état.

Ce que cela implique pour vous : l'infirmier est, dans les faits, **l'interlocuteur le plus accessible et le plus continu** pour une famille hospitalisée. C'est aussi celui qui subit le plus la charge non médicale (explications répétées, orientation, gestion des accompagnants). Si votre service allège cette charge sans la lui retirer, l'infirmier devient votre meilleur allié. S'il la retire, il devient votre adversaire. Ce point est stratégique, pas cosmétique.

4.3 La sage-femme

[HYPOTHÈSE — à vérifier] Suivi de la grossesse normale, surveillance du travail, réalisation de l'accouchement eutocique, soins au nouveau-né, dépistage des situations à risque et appel du médecin, consultations prénatales et postnatales.

Spécificité béninoise vérifiée [PRATIQUE] : la **césarienne est gratuite au Bénin**, prise en charge par l'État via l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne (ANGC). Cette gratuité est régulièrement mal connue, mal appliquée ou mal comprise.

C'est un exemple parfait de ce que vous pouvez apporter sans aucun risque juridique : informer une famille que la césarienne est gratuite, lui indiquer le périmètre exact de cette gratuité (ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas), et l'aider à faire valoir ce droit. Ce n'est pas de la médecine. C'est de l'information administrative sur un dispositif public. Valeur immédiate, risque nul, effet mesurable sur la dépense du ménage.

[ACTION] Récupérer le texte et le périmètre exact de la gratuité de la césarienne auprès de l'ANGC.

4.4 Le pharmacien

Obligation	Base	Conséquence
Être au service du public, avec le même dévouement envers tous	L. 2020-37 art. 28	
Ne dispenser que dans un établissement habilité, selon les bonnes pratiques	L. 2021-03 art. 17	La dispensation implique le contrôle de l'ordonnance et le conseil. Aucun tiers ne peut s'y substituer.
S'approvisionner auprès des grossistes-répartiteurs (privé) ou des centrales publiques (public)	L. 2021-03 art. 41, 73	
Monopole sur préparation, importation, exportation, distribution	L. 2021-03 art. 6	

4.5 L'établissement de santé

Obligation	Base
Répondre civilement des dommages subis du fait des soins	L. 2020-37 art. 76
Souscrire une assurance de responsabilité civile	L. 2020-37 art. 77
Faire constater médicalement tout décès	L. 2020-37 art. 65
Conduire des audits de décès (obligatoires) et produire un rapport mensuel	L. 2020-37 art. 67, 68
Être informé par le praticien d'un refus de soins et en informer le procureur	L. 2020-37 art. 11
Mettre en place le dispositif de sécurité des patients (5 domaines, normes et critères)	Décret 2025-481
Se soumettre à la certification par l'ARS	Décret 2019-417 art. 5, 6
Offrir le paquet de services correspondant à son niveau dans la pyramide	Décret 2022-148

Lecture stratégique : les obligations de l'établissement sont **documentaires et organisationnelles** autant que cliniques. Rapports mensuels d'audits de décès, procédures écrites, auto-évaluation, plans d'amélioration, implication des patients. Ce sont des livrables. Un hôpital de zone sous-doté en personnel administratif a un problème de production de livrables. **Vous savez produire des livrables.** C'est là que se trouve la valeur B2B la plus immédiate — et elle ne touche à aucun acte de soin.

4.6 Votre entreprise — ce qu'elle n'est pas

Avant de dire ce que vous pouvez faire, il faut être clair sur ce que vous n'êtes **pas**, au sens du droit béninois :

- Vous n’êtes pas un **établissement de santé** : vous ne relevez donc pas de l’autorisation d’ouverture ni de la certification ARS — mais vous ne bénéficiez d’aucune des prérogatives associées.
- Vous n’êtes pas un **professionnel de santé** : vous n’êtes ni inscrit à un ordre, ni accrédité, ni tenu au secret médical, ni couvert par les protections de l’article 21.
- Vous n’êtes pas un **établissement pharmaceutique** : vous ne pouvez ni détenir, ni distribuer, ni dispenser de médicaments.
- Vous n’êtes pas un **assureur** ni un **intermédiaire d’assurance** : attention si vous vous approchez de l’AMO ; l’intermédiation en assurance est une activité réglementée dans l’espace CIMA. **[À VÉRIFIER]**
- Vous n’êtes pas un **mandataire judiciaire** : vous ne représentez personne devant une juridiction.

Vous êtes une **entreprise de services**, soumise au droit commun des sociétés et des contrats, à la fiscalité de droit commun, et — parce que vous touchez à des données de santé — au régime le plus exigeant du Code du numérique.

Cette absence de statut n’est pas une interdiction. C’est un vide. Un vide peut être comblé favorablement (par une convention, une reconnaissance, une expérimentation) ou défavorablement (par une interdiction, une requalification). Votre stratégie institutionnelle doit viser activement la première option. **Ne pariez pas sur le silence des textes ; allez chercher un écrit.**

5. CARTOGRAPHIE DU PARCOURS PATIENT

5.1 Méthode

Le parcours est découpé en 15 moments (T0 à T14), plus deux parcours particuliers (maternité, décès en hospitalisation). À chaque moment, quatre questions :

Qui sait ? Qui décide ? Qui agit ? Qui doit être informé ?

La matrice complète — 19 colonnes par étape, conforme à votre cahier des charges — se trouve dans le **classeur Excel joint**, qui est le véritable outil de travail. Ce qui suit en est la lecture analytique : les moments qui comptent, et pourquoi.

Avertissement : les colonnes « risque » de la matrice décrivent des **risques structurellement possibles**, identifiés par analyse du parcours. Elles ne constituent ni un constat, ni une accusation, ni une mesure de fréquence. Aucune de ces cases ne doit être présentée à un établissement comme un reproche. La fréquence réelle est précisément ce que l’enquête terrain (partie 9) doit établir.

5.2 Les quatre questions, appliquées

Le tableau ci-dessous est la version condensée. Il montre une chose : **dans presque toutes les étapes, celui qui sait et celui qui doit agir ne sont pas la même personne, et rien n’organise le transfert entre les deux.** C’est la définition d’un point de rupture.

Moment	Qui sait ?	Qui décide ?	Qui agit ?	Qui doit être informé ?	Écart principal
T0 Arrivée	Personne. La famille arrive avec une plainte, pas un diagnostic.	Le tri (agent d’accueil ou infirmier).	Famille, agent d’accueil.	La famille, sur le circuit et le coût.	La famille ignore où elle est arrivée dans la pyramide et si c’est le bon niveau.

Moment	Qui sait ?	Qui décide ?	Qui agit ?	Qui doit être informé ?	Écart principal
T1 Accueil administratif	L'établissement (tarifs, pièces, statut AMO).	L'établissement.	La famille (paie, fournit).	La famille.	Les tarifs et la couverture AMO sont rarement expliqués avant l'engagement de la dépense.
T2 Consultation	Le médecin (après examen).	Le médecin.	Le médecin.	Le patient, puis la famille avec son accord.	Temps de consultation court + langue + vocabulaire. L'information est donnée, mais non reçue.
T3 Hypothèse diagnostique	Le médecin.	Le médecin.	Le médecin.	Le patient.	La famille entend un mot, pas un raisonnement. Elle repart avec une certitude fausse ou une angoisse.
T4 Prescription	Le médecin.	Le médecin.	Le patient/la famille (exécution).	Le patient, le pharmacien, le labo.	La famille ne sait pas ce qui est urgent, ce qui est optionnel, ni ce que ça coûtera au total.
T5 Paiement	La caisse.	La famille (payer ou non).	La famille.	L'établissement.	Le moment de vérité économique. Attente longue, arbitrages invisibles, abandons silencieux.
T6 Examen (labo/imagerie)	Le service technique.	Le médecin (indication).	Le patient, un brancardier, un accompagnant.	Le prescripteur.	Qui transporte le patient ? Souvent la famille. Et personne ne suit le délai de rendu.
T7 Résultat	Le laboratoire.	Le médecin	La famille	Le prescripteur.	La famille

Moment	Qui sait ?	Qui décide ?	Qui agit ?	Qui doit être informé ?	Écart principal
		(interprétation).	(récupère souvent le résultat).		détient un document qu'elle ne comprend pas et dont le médecin ignore parfois qu'il est prêt. Rupture majeure.
T8 Traitement	Le médecin, l'infirmier.	Le médecin.	L'infirmier.	Le patient.	Changements de traitement non réexpliqués à la famille.
T9 Pharmacie	Le pharmacien.	Le pharmacien (validation).	La famille (achat), le pharmacien (dispensation).	Le prescripteur en cas d'indisponibilité .	La rupture de stock déclenche une course dont personne n'est responsable. Voir 7.4.
T10 Hospitalisation	L'équipe de soins.	Le médecin.	L'équipe, la famille (garde, repas, achats).	Le patient et la famille, quotidiennement.	Aucun point d'information régulier. La famille apprend par déduction.
T11 Aggravation / urgence	L'infirmier en premier.	Le médecin.	L'équipe.	La famille, immédiatement .	Le délai entre le constat infirmier et la décision médicale. Et l'absence de la famille au mauvais moment.
T12 Amélioration	L'équipe.	Le médecin.	L'équipe.	La famille.	Les prescriptions antérieures ne sont pas toujours annulées. Dépenses résiduelles.
T13 Sortie	Le médecin, l'administration.	Le médecin.	La famille (règlement, transport).	Le patient, la famille, le médecin	Ordonnance de sortie mal comprise ; solde

Moment	Qui sait ?	Qui décide ?	Qui agit ?	Qui doit être informé ?	Écart principal
				traitant.	à payer découvert au dernier moment.
T14 Suivi	Personne, en réalité.	Le patient.	Le patient.	Le médecin, si rendez-vous.	Le vide le plus complet du parcours. Personne n'est responsable de la continuité entre deux passages.

5.3 Les trois moments les plus créateurs de valeur pour un facilitateur

Si vous ne deviez intervenir qu'à trois endroits, ce seraient ceux-ci. Ils partagent trois caractéristiques : forte densité de malentendus, aucun contenu médical, aucun acteur actuellement responsable.

A. T1 → T5 : le couloir administratif et financier. De l'accueil au premier paiement. C'est ici que se décide le reste : ce que la famille croit devoir payer, ce qu'elle paie inutilement, ce qu'elle n'ose pas demander. Une étude conduite en 2023 dans un hôpital de référence du sud du Bénin associe l'incapacité de payer à l'**absence de dispositif social hospitalier** et à une **attente au paiement d'une heure ou plus**. **[PRATIQUE]** Ce sont des facteurs organisationnels, pas médicaux. Donc traitables par un tiers.

B. T6 → T7 : la boucle de l'examen. Le patient part faire un examen, la famille récupère le résultat, et le circuit de retour vers le prescripteur n'est garanti par personne. C'est un problème purement logistique et informationnel. Un tiers qui garantit que le résultat revient au bon médecin dans le bon délai crée une valeur médicale réelle **sans poser aucun acte médical**. C'est le point d'entrée idéal.

C. T13 → T14 : la sortie et l'après. L'ordonnance de sortie, le rendez-vous de contrôle, les signes qui doivent faire revenir. Rien n'organise ce passage. **Attention** : c'est aussi la zone où la tentation de « conseiller » est la plus forte, et donc où le risque d'exercice illégal est le plus élevé. Le service ne doit y produire que du **rappel** (« votre rendez-vous est le 12 »), du **transport de document**, et de la **reformulation de ce que le médecin a écrit** — jamais d'interprétation.

5.4 Parcours particulier A — Femme enceinte, maternité, accouchement

Moment	Point de tension	Intervention possible du facilitateur	Limite
Consultations prénatales	Assiduité, coût cumulé, compréhension des examens	Rappel des rendez-vous, information sur le calendrier de suivi, préparation des questions	Aucun conseil sur la grossesse elle-même
Préparation à l'accouchement	Ignorance du contenu du « kit », du lieu, des coûts	Liste pratique, information sur les tarifs de l'établissement, sur la gratuité de la césarienne	Ne jamais orienter vers un lieu d'accouchement pour des raisons non médicales

Moment	Point de tension	Intervention possible du facilitateur	Limite
Admission en travail	Urgence, stress, accompagnant unique ou absent	Coordination du transport, présence administrative, contact avec la famille	Ne jamais entrer dans la salle de naissance sans autorisation explicite
Décision de césarienne	Consentement dans l'urgence ; famille non présente ; croyance que c'est payant	Rappeler que la césarienne est gratuite et le périmètre de cette gratuité	Ne jamais commenter l'indication de la césarienne
Post-partum	Sortie précoce, méconnaissance des signes d'alerte	Remise du document d'information de l'établissement, rappel du rendez-vous	Ne jamais évaluer un signe d'alerte
Nouveau-né	Vaccination, déclaration de naissance, allaitement	Accompagnement des démarches d'état civil, rappel du calendrier vaccinal officiel	Ne jamais se prononcer sur l'état de l'enfant

Point critique : la maternité est le domaine où la pression émotionnelle est la plus forte et où l'urgence est la plus fréquente. C'est donc le domaine où votre accompagnateur sera le plus tenté de dépasser sa ligne. **Si vous lancez un axe maternité, il doit avoir le protocole le plus strict de tout votre dispositif, pas le plus souple.**

5.5 Parcours particulier B — Décès pendant l'hospitalisation

Étape	Règle	Rôle du facilitateur
Constat	« Tout décès est médicalement constaté » (L. art. 65). [TEXTE]	Aucun. Attendre.
Annonce à la famille	Relève du médecin (déontologie art. 33 pour le pronostic ; par extension, l'annonce). [INTERPRÉTATION]	Interdiction absolue d'annoncer ou de laisser deviner. Si la famille demande, renvoyer au médecin.
Déclaration de décès	Aucun acte de décès sans déclaration (L. art. 66). [TEXTE]	Accompagnement administratif, sur mandat écrit de la famille.
Audit de décès	Obligatoire (L. art. 67) ; rapport mensuel des structures (L. art. 68). [TEXTE]	Aucun rôle direct. Mais voir 7.5 : opportunité institutionnelle.
Arrêt des prestations en cours	Aucune règle explicite trouvée. [LACUNE MAJEURE]	Voir 7.5.
Dépenses déjà engagées	Aucune règle explicite trouvée. [LACUNE MAJEURE]	Voir 7.5.
Formalités funéraires	Régime non vérifié. [LACUNE]	Accompagnement administratif uniquement.

Je n'ai pas trouvé de disposition officielle suffisamment claire pour déterminer, en droit béninois : quelles prestations doivent être arrêtées au décès, qui a la charge de mettre à jour le statut du patient dans les circuits administratifs, et quel est le régime des sommes engagées pour des prestations non réalisées.

Cette lacune est peut-être le résultat le plus important de toute l'étude. Ce que vous décrivez comme un dysfonctionnement n'est pas encadré par une règle claire — ce n'est donc probablement **pas une faute**, mais un **angle mort procédural**. Et un angle mort procédural, ça se comble par une procédure. C'est exactement le genre de contribution qu'un établissement peut accepter d'un partenaire extérieur sans se sentir accusé.

6. PRINCIPAUX POINTS DE RUPTURE

6.1 Grille de qualification — à utiliser systématiquement

Votre cahier des charges demandait de ne jamais transformer une difficulté en faute. Voici la grille à appliquer, dans cet ordre, avant toute conclusion :

#	Catégorie	Question test	Qui peut corriger
1	Dysfonctionnement organisationnel	Le problème se reproduirait-il avec d'autres personnes aux mêmes postes ?	La direction
2	Erreur humaine	Une personne compétente a-t-elle fait, une fois, ce qu'elle ne fait pas d'habitude ?	L'encadrement, par formation ou barrière
3	Problème de communication	L'information existait-elle quelque part sans atteindre son destinataire ?	Un dispositif de transmission
4	Contrainte légale ou réglementaire	Le soignant était-il tenu de faire ce qui paraît absurde ?	Le législateur
5	Manque de ressources	Le personnel, le matériel ou le stock étaient-ils disponibles ?	Le financeur
6	Mauvaise pratique éventuelle	Y a-t-il un écart à un protocole écrit connu ?	L'ordre, l'établissement
7	Faute potentielle	Y a-t-il dommage + manquement + lien de causalité ?	Un juge, un ordre — pas vous
8	Incompréhension du patient	La règle a-t-elle été appliquée correctement et mal comprise ?	Un facilitateur — vous

Règle d'or : votre entreprise ne qualifie **jamais** en catégorie 6 ou 7. Elle décrit des faits, elle oriente vers l'autorité compétente, elle s'arrête. Le jour où votre accompagnateur dit à une famille « c'est une faute », vous perdez l'accès aux hôpitaux et vous vous exposez personnellement.

6.2 Les vingt et une ruptures, qualifiées

Rupture	Catégorie dominante	Traitable par vous ?
Absence d'information	1, 3, 5	Oui — partiellement
Mauvaise compréhension	3, 8	Oui — cœur de métier
Langage médical incompréhensible	3, 8	Oui — reformulation, langues nationales
Absence d'interlocuteur identifié	1	Oui — identification, pas substitution
Mauvaise orientation dans la pyramide	1, 3, 8	Oui — risque nul
Attente excessive	1, 5	Partiellement — préparation, anticipation
Déplacement inutile	1, 3	Oui — vérification préalable
Rupture de stock	5 (chaîne publique, cf. art. 73)	Non — vous ne pouvez que réduire le temps de recherche
Difficulté à trouver un médicament prescrit	5	Partiellement — zone à haut risque, voir 7.4
Difficulté à trouver un examen	1, 5	Oui
Mauvaise transmission d'une information	3	Oui — boucle T6→T7
Paiement d'une prestation devenue sans objet	1, 3	Oui — vigilance et alerte
Poursuite d'une démarche après changement d'état	1, 3	Oui — c'est votre cas critique
Difficulté à comprendre une ordonnance	3, 8	Partiellement — limite dangereuse. Vous pouvez lire ce qui est écrit ; vous ne pouvez pas expliquer pourquoi c'est prescrit.
Difficulté à comprendre les résultats	8	Non. Interdit. Renvoi au prescripteur, sans exception.
Absence de famille auprès du patient	Contexte social	Oui — c'est le cœur de l'offre diaspora
Communication en maternité	3	Oui , avec protocole renforcé

Rupture	Catégorie dominante	Traitable par vous ?
Communication en urgence	1, 3, 5	Limité — l'urgence n'est pas votre terrain
Communication lors d'un décès	1, 3	Après l'annonce médicale uniquement
Problème de confidentialité	1, 3	Oui , mais vous êtes vous-même un risque
Problème lié aux données personnelles	4	Vous êtes le risque. Voir 8.3

6.3 Les trois ruptures que je considère comme les plus rentables à traiter

1. La boucle de l'examen (T6→T7). Faible risque juridique, forte valeur médicale indirecte, mesurable (délai entre prescription et retour du résultat au prescripteur), et immédiatement compréhensible par une direction hospitalière.

2. L'orientation dans la pyramide (T0). Risque juridique nul. Effet direct sur la dépense du ménage et sur l'engorgement des services. Chiffrable.

3. La compréhension du coût et de la couverture (T1→T5). C'est là que l'argent se perd. Et c'est là que la valeur perçue par un ménage est la plus élevée, parce qu'elle se mesure en francs CFA et non en confort.

Notez ce que ces trois ruptures ont en commun : **aucune ne touche au contenu médical**. C'est ce qui les rend défendables. Le paradoxe de votre projet est que sa partie la plus vendeuse (« comprendre ce que dit le médecin ») est aussi sa partie la plus risquée, tandis que sa partie la plus ingrate (la logistique de l'information et de l'argent) est celle qui crée le plus de valeur défendable.

7. RÔLE LÉGALEMENT POSSIBLE DU FACILITATEUR

7.1 Le principe directeur

Une seule règle permet de trancher 90 % des cas :

Le facilitateur agit sur le CIRCUIT. Jamais sur le CONTENU.

Circuit : où aller, quand, avec quoi, combien ça coûte, qui contacter, quel document manque, où en est la démarche, qui doit être prévenu. Contenu : ce qu'a le patient, ce qu'il faut lui faire, si le traitement est bon, ce que veut dire ce résultat.

Deuxième règle, pour les cas restants :

Le facilitateur transmet la question au professionnel ; il ne transmet jamais la réponse à sa place.

7.2 Classification VERT / ORANGE / ROUGE

 **VERT — activités clairement compatibles**

Activité	Pourquoi c'est vert
Expliquer l'organisation de l'établissement, les circuits, les horaires, les services	Information factuelle publique. Aucun contenu médical.

Activité	Pourquoi c'est vert
Orienter dans la pyramide sanitaire (décret 2022-148)	Information réglementaire publique.
Aider à préparer les questions à poser au médecin	Renforce le droit à l'information (L. art. 6) sans s'y substituer. Améliore la consultation pour les deux parties.
Vérifier après l'entretien que la famille a compris, et la renvoyer au soignant si non	C'est le geste le plus utile et le plus sûr de tout le métier. Vous ne réexpliquez pas : vous détectez l'incompréhension et vous la renvoyez à la source.
Traduire en langues nationales ce que le professionnel a dit, en sa présence ou avec son accord	Traduction ≠ interprétation. Cadre à écrire strictement.
Accompagner physiquement le patient dans ses déplacements internes	Aide logistique.
Suivre les démarches administratives, les pièces, les délais	Administratif pur.
Rappeler les rendez-vous et les échéances	
Informersur les tarifs affichés et sur les dispositifs de gratuité existants (césarienne, AMO)	Information sur des dispositifs publics. Forte valeur, risque nul.
Aider à lire une facture et à repérer une incohérence de facturation	Contrôle administratif, pas médical.
Transporter un document entre deux services d'un même établissement, sur mandat écrit	Logistique documentaire. Attention aux données — voir 8.3.
Vérifier par téléphone la disponibilité d'un examen avant déplacement	Évite un déplacement inutile.
Informers la famille de l'existence de la Charte des droits et devoirs des patients	Diffusion d'un document officiel.
Expliquer l'existence et le délai de deux mois de l'article 8	Information juridique générale, non personnalisée.
Signaler à l'infirmier ou au médecin de garde qu'une famille est inquiète	Alerte, pas diagnostic.
Produire pour un établissement des supports d'information patients	Prestation B2B. Le cœur de l'offre défendable.
Recueillir la satisfaction et l'expérience des patients pour un établissement	Répond au domaine 2 du décret 2025-481.

 ORANGE — possible sous conditions strictes

Activité	Condition indispensable
Présence dans un service hospitalier	Convention écrite avec l'établissement. Badge, périmètre, horaires, référent désigné. Sans convention

Activité	Condition indispensable
	: vous êtes un tiers non identifié dans un lieu de soins. Intenable.
Lire à voix haute une ordonnance à une personne non lettrée	Lecture littérale uniquement, sans aucun commentaire , avec renvoi systématique au pharmacien. Le glissement vers l'explication est quasi automatique : il faut une formation et un contrôle.
Manipuler des documents médicaux (ordonnance, résultat)	Consentement écrit du patient . Autorisation APDP. Aucune conservation. Transport en enveloppe close.
Communiquer une information médicale à un proche	Uniquement avec l'accord exprès du patient, tracé.
Rechercher la disponibilité d'un médicament auprès de pharmacies	Aucune contrepartie financière de la pharmacie, jamais. Liste ouverte, non exclusive. Traçabilité. Voir 7.4.
Réserver un médicament pour une famille	Réservation au nom du patient , paiement par la famille, facture au nom du patient. Voir 7.4.
Faire transporter un médicament acheté par la famille	La zone la plus risquée du projet. Voir 7.4. Ne pas lancer sans avis écrit d'un avocat et, si possible, position de l'ABMed.
Accompagner une démarche de plainte	Information sur la procédure et les délais, aide à la mise en forme des faits. Jamais de qualification juridique, jamais de représentation. Orientation vers un avocat.
Intervenir en maternité	Protocole renforcé, accord de la sage-femme responsable, jamais en salle de naissance sans autorisation.
Intervenir dans un contexte de décès	Uniquement après l'annonce par le médecin, sur mandat écrit de la famille.
Utiliser une application mobile ou une base de données	Autorisation APDP préalable. Minimisation. Chiffrement. Durée de conservation définie.
Facturer un abonnement à une famille	Vérifier l'obligation d'information sur les prix et le régime de la vente de services. Attention à ne pas créer un produit assimilable à une couverture santé (régime CIMA). [À VÉRIFIER]

 ROUGE — interdit

Activité	Fondement
Poser ou évoquer un diagnostic	Exercice illégal de la médecine.
Prescrire, modifier, suspendre un traitement	Idem.
Interpréter un résultat d'examen	Idem. Même « juste pour rassurer ».

Activité	Fondement
Conseiller d'arrêter ou de continuer un traitement	Idem.
Évaluer la gravité d'un symptôme	Idem.
Donner, remettre ou vendre un médicament au patient	L. 2021-03 art. 6, 17, 90. Peine : 1 à 5 ans + 500 000 à 2 000 000 FCFA.
Détenir un stock de médicaments	Idem.
Prendre une marge sur le prix d'un médicament	Idem + requalification en distribution.
Recevoir une commission d'une pharmacie, d'un laboratoire, d'une clinique ou d'un médecin	Déontologie art. 18. Conflit d'intérêts destructeur.
Consentir à la place du patient	L. art. 9. Sanctions pénales (art. 14).
Annoncer un décès ou un pronostic fatal	Déontologie art. 33.
Affirmer qu'il y a eu faute médicale	Risque de diffamation. Compétence exclusive du juge et de l'ordre.
Représenter une famille devant une juridiction ou un ordre	Monopole de l'avocat.
Constituer et conserver un dossier médical	Code du numérique. Absence de secret médical opposable.
Transmettre une information médicale sans consentement du patient	L. art. 6, 56 ; Code du numérique.
Garantir un résultat médical	Obligation de résultat impossible à tenir. Publicité trompeuse.
Nommer un professionnel de santé dans une communication commerciale	Déontologie art. 11.
Installer un point de service dans une pharmacie	Déontologie art. 20 (par analogie). [INTERPRÉTATION]

7.3 Trois services à forte valeur, risque faible, que vous n'avez pas listés

A. Le rappel du délai de deux mois (art. 8). Une famille qui pense avoir subi un préjudice dispose de deux mois pour saisir le ministre, l'ordre ou la juridiction. **[TEXTE, à reconstruire après 2022]** Ce délai est court et méconnu. L'informer de son existence — sans jamais qualifier les faits ni recommander de saisir — est une prestation d'information juridique générale, licite, et d'une valeur considérable pour la famille. **Précaution indispensable :** cette prestation doit être délivrée de façon neutre et systématique, jamais comme une incitation. Si vous devenez le prestataire qui « pousse à porter plainte », vous perdez l'accès aux établissements — et vous perdez donc votre capacité à aider qui que ce soit.

B. La navigation AMO / gratuité. Identifier ce qui est déjà pris en charge et ce qui ne l'est pas. La césarienne est gratuite. L'AMO se déploie. **Chaque franc CFA qu'une famille ne dépense pas parce que vous lui avez dit qu'elle n'avait pas à le dépenser est une preuve de valeur immédiatement mesurable.** C'est votre meilleur argument commercial et il n'y a aucun risque juridique.

C. La production documentaire pour les établissements. Le décret 2025-481 et l'article 68 de la loi (rapport mensuel des audits de décès) créent des obligations documentaires récurrentes. Les hôpitaux de zone n'ont pas toujours les moyens de les produire. Une prestation de mise en forme, de collecte de données patients et de rédaction est du service aux entreprises pur — aucun contenu médical, un besoin daté, un budget identifiable.

7.4 CAS CRITIQUE 1 — Médicament injectable urgent, pharmacie en rupture

Les faits

Prescription d'un injectable urgent. Pharmacie de l'établissement en rupture. La famille doit chercher ailleurs. Plusieurs officines également en rupture. Le patient reste hospitalisé pendant ce temps.

Qui est responsable de quoi

Question	Réponse	Base
Responsable de la prescription	Le médecin prescripteur.	L. 2020-37 art. 9, 75
Responsable de la dispensation	Le pharmacien de l'établissement habilité.	L. 2021-03 art. 17
Responsable de l' approvisionnement de l'établissement	L'établissement, via les centrales d'achat publiques pour le secteur public (art. 73) ou les grossistes-répartiteurs pour le privé (art. 41).	L. 2021-03 art. 41, 73
Responsable de la rupture elle-même	Personne, au sens d'une faute individuelle. Une rupture de stock est un événement de chaîne d'approvisionnement.	[INTERPRÉTATION]

Ce point mérite d'être dit clairement, et il changera votre relation avec les soignants : lorsqu'une famille est envoyée chercher un médicament à l'extérieur, le soignant qui l'envoie n'est presque jamais l'auteur du problème. Il est lui-même bloqué. Une entreprise qui comprend cela et le dit sera accueillie. Une entreprise qui arrive en dénonçant sera fermée dehors.

Ce que la famille peut légalement faire

Acheter le médicament prescrit dans une officine autorisée, sur présentation de l'ordonnance, et l'apporter à l'établissement. **[INTERPRÉTATION]** — pratique courante, non explicitement encadrée par les textes consultés, et non interdite dès lors que l'achat se fait auprès d'un établissement habilité (a contrario de l'art. 90).

Ce que votre entreprise peut faire — et le mur qu'elle ne peut pas franchir

Ce qui est défendable :

1. **Appeler des officines pour vérifier la disponibilité.** Simple recherche d'information. Aucune contrepartie financière de l'officine.
2. **Communiquer l'information à la famille.** Liste de plusieurs officines, jamais une seule, jamais une exclusivité.
3. **Demander à l'officine de réserver au nom du patient.** La réservation est faite au nom du patient, qui reste l'acheteur.
4. **Accompagner physiquement un membre de la famille à l'officine.** Le membre de la famille achète, paie, reçoit la facture à son nom et le conseil du pharmacien.

Ce qui devient dangereux :

5. **Le coursier qui va chercher le produit à la place de la famille.** C'est le point de bascule. Analyse :

L'article 6 de la loi n°2021-03 réserve la **distribution** des médicaments aux pharmaciens ou aux personnes agissant sous leur responsabilité. L'article 90 punit la vente au détail hors des lieux autorisés de 1 à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 à 2 000 000 FCFA. Un tiers qui prend possession d'un médicament, le déplace et le remet à un patient exerce matériellement une opération qui ressemble à de la distribution. **[INTERPRÉTATION]**

La défense possible : le tiers agit comme **mandataire du patient**, non comme opérateur pharmaceutique. Le médicament n'entre jamais dans son patrimoine ; il ne fixe pas le prix ; il ne conseille pas ; il ne stocke pas ; sa rémunération est un forfait de service indépendant de la nature et du prix du produit. Le montage est celui du mandat civil, comparable à un proche qui rend service.

La faiblesse de cette défense : elle repose sur une **qualification civile** opposée à une **incrimination pénale** dont le périmètre exact n'est pas défini par les textes consultés, et elle est fragilisée par le caractère **professionnel, répété et rémunéré** de l'activité. Un mandat isolé et gratuit entre proches n'est pas la même chose qu'une prestation commerciale organisée.

Ma position : ne lancez pas ce service au démarrage. Ce n'est pas une interdiction certaine — c'est un risque non chiffré sur une activité qui ne sera jamais votre principale source de revenus. Vous mettriez en jeu la totalité de l'entreprise pour une prestation marginale.

Si vous y tenez malgré tout, les conditions minimales sont cumulatives : - Mandat écrit et daté, signé par le patient ou son représentant, désignant nominativement le produit et l'officine ; - Facture émise par l'officine **au nom du patient**, jamais au nom de l'entreprise ; - Paiement effectué par la famille (mobile money direct à l'officine, idéalement) ; - Aucune marge, aucune remise, aucune commission, dans aucun sens ; - Aucun stockage, aucune rupture de charge : trajet direct officine → établissement ; - Remise **au personnel soignant**, jamais au patient lui-même, avec émargement ; - Refus catégorique pour les produits soumis à réglementation particulière (stupéfiants, psychotropes, chaîne du froid) ; - **Avis écrit préalable d'un avocat béninois, et demande de position écrite à l'ABMed.**

Transport : ce que je n'ai pas trouvé

Je n'ai pas trouvé de disposition officielle suffisamment claire dans la loi n°2021-03 concernant le transport de médicaments par un tiers non pharmaceutique, ni concernant les conditions de conservation en transport pour un particulier. **[LACUNE]** Ce silence est un risque, pas une permission.

Responsabilité en cas de retard — et ce que vos CGV doivent dire

Si votre entreprise s'engage à récupérer un médicament et que le retard cause un préjudice, votre responsabilité contractuelle peut être engagée. Ce risque est **structurellement supérieur** à votre capacité d'assurance de départ.

Clauses indispensables :

Obligation de moyens, jamais de résultat. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre les diligences raisonnables. Elle ne garantit ni la disponibilité d'un produit, ni un délai, ni un résultat médical.

Exclusion du champ médical. L'entreprise n'exerce aucune activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique. Elle ne se substitue à aucun professionnel de santé.

Refus de l'urgence vitale. L'entreprise n'intervient pas dans les situations d'urgence vitale, qui relèvent exclusivement de l'établissement de santé.

Plafond de responsabilité aligné sur le montant de la prestation, dans les limites admises par le droit béninois. **[À VÉRIFIER — les clauses limitatives ne sont pas toujours opposables]**

Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite et communicable. Précédent utile : l'article 77 de la loi n°2020-37 impose déjà cette assurance aux établissements de santé.

Mon conseil le plus ferme sur ce point : écrivez dans vos CGV que vous n'intervenez pas sur les médicaments urgents. Le jour où un patient décède pendant que votre coursier est dans les embouteillages, aucune clause ne vous protégera dans l'opinion, même si elle vous protège en droit.

7.5 CAS CRITIQUE 2 — Décès avant réalisation de démarches prescrites

Les faits

Patient hospitalisé. Examens ou achats prescrits. Le patient décède avant que certaines démarches soient réalisées ou avant que des produits achetés soient utilisés.

Ce que dit le droit

Question	Réponse	Base
Qui informe la famille du décès ?	Le médecin. Le décès est un constat médical.	L. art. 65 ; déontologie art. 33 [INTERPRÉTATION pour l'annonce]
Qui met à jour le statut du patient ?	Non déterminé.	[LACUNE]
Quelles prestations doivent être arrêtées ?	Non déterminé.	[LACUNE]
Quelles démarches continuent malgré le décès ?	Le constat médical (art. 65), la déclaration (art. 66), l'audit de décès (art. 67) et le rapport mensuel (art. 68) sont obligatoires et postérieurs au décès.	[TEXTE]
Comment traiter les dépenses engagées ?	Non déterminé. Relève du droit commun des contrats et de la succession.	[LACUNE]
Quels documents doivent être établis ?	Constat médical, déclaration de décès, éléments de l'audit.	[TEXTE]

L'analyse qui compte

Il n'existe pas, dans les textes consultés, de procédure organisant l'arrêt des prestations en cours au moment du décès. C'est un vide, pas une faute.

Conséquence logique : dans un établissement où les circuits sont cloisonnés — la caisse, le laboratoire, la pharmacie, le service — l'information du décès met un certain temps à parvenir à chacun. Pendant ce délai, une famille peut continuer une démarche engagée. Ce n'est ni une escroquerie, ni une négligence individuelle : c'est un défaut de synchronisation entre des circuits qui n'ont pas été conçus pour se parler.

Je le dis explicitement, parce que votre cahier des charges le demandait : une famille qui a payé un examen non réalisé ou acheté un produit non utilisé n'a pas nécessairement été victime d'une faute. Elle a été victime d'un **angle mort procédural**. La différence n'est pas sémantique — elle détermine si vous entrez dans un hôpital comme partenaire ou comme adversaire.

Ce que vous pouvez faire

Avant (prévention — c'est ici que se trouve la vraie valeur) : - Tenir, avec la famille, un relevé simple et daté des démarches engagées : quoi, où, combien, réalisé ou non. Un tableau, pas un dossier médical. - Aucune donnée médicale : « examen prescrit le 12/03, 15 000 F, payé, non réalisé » suffit. Pas de nom d'examen si évitable.

Au moment du décès : - Silence total sur le fait médical. Attendre l'annonce du médecin. - Aucune initiative sans mandat écrit de la famille.

Après, sur mandat écrit : - Signaler aux services concernés, de façon factuelle et non accusatoire, que le patient est décédé et qu'une démarche est en cours. - Réunir les justificatifs des sommes engagées. - Formuler une demande écrite et courtoise de régularisation auprès de l'administration. - **Ne jamais qualifier.** « Nous constatons qu'un examen payé le 12/03 n'a pas été réalisé et souhaitons connaître la procédure applicable. » Pas : « on nous a fait payer pour rien. » - Si l'établissement refuse, informer la famille de ses recours. S'arrêter là.

L'opportunité institutionnelle que vous ne devez pas manquer

L'article 67 rend l'**audit de décès obligatoire** et l'article 68 impose un **rapport mensuel**. [TEXTE] L'audit de décès est défini par la loi n°2022-17 comme une « analyse systématique et critique de la qualité des soins ». [TEXTE]

Un établissement doit donc déjà analyser ses décès. Il lui manque souvent le temps, la méthode et la main-d'œuvre administrative.

Proposition à porter aux directions : contribuer, sous convention et sans accès aux données cliniques, à la partie **organisationnelle et administrative** de l'audit — chronologie des démarches, points de rupture de circulation de l'information, prestations restées en suspens. Vous ne touchez pas au clinique. Vous apportez ce qui manque. Et vous documentez, au passage, exactement le problème que vous voulez résoudre — avec des données qui appartiennent à l'hôpital, ce qui vous évite d'en constituer vous-même.

C'est, à mon avis, la meilleure porte d'entrée institutionnelle de tout votre projet.

8. RISQUES JURIDIQUES ET ÉTHIQUES — ET CRITIQUE DU CONCEPT

Cette partie est celle que vous avez explicitement demandée : une analyse critique, pas une validation. Je la traite dans cet ordre : d'abord les risques du projet tel qu'il est conçu, ensuite les objections de fond sur le concept lui-même.

8.1 Cartographie des risques juridiques

Risque	Probabilité si rien n'est fait	Gravité	Mitigation
Requalification en exercice illégal de la médecine	Moyenne — dérive naturelle des accompagnateurs sur le terrain	Très élevée	Formation, scripts écrits, contrôle, sanction interne immédiate, clause contractuelle
Requalification en distribution/dispensation illicite	Moyenne à élevée si vous faites du transport de médicaments	Très élevée (1-5 ans, 500 000-2 000 000 F)	Ne pas lancer ce service. Sinon : montage 7.4 + avis écrit
Non-conformité au Code du numérique (données de santé)	Élevée — c'est le risque le plus probable de tous	Élevée	Minimisation radicale, autorisation APDP avant le premier client

Risque	Probabilité si rien n'est fait	Gravité	Mitigation
Violation de confidentialité par un accompagnateur	Moyenne	Élevée	Clause de confidentialité, formation, traçabilité, sanction
Mise en cause contractuelle sur un retard ou une erreur	Moyenne	Moyenne à élevée	Obligation de moyens, plafond, assurance RC pro
Diffamation / dénigrement d'un professionnel	Faible si gouvernance stricte	Élevée	Interdiction absolue de qualifier une faute
Conflit d'intérêts (commissions)	Faible si vous tenez la ligne	Fatale pour la marque	Interdiction absolue, écrite, auditable
Présence non autorisée dans un établissement	Élevée sans convention	Moyenne	Ne jamais opérer sans convention écrite
Requalification en intermédiation d'assurance	Faible	Moyenne	Vérifier le régime CIMA avant toute offre type « abonnement santé » [À VÉRIFIER]
Requalification du contrat de travail des accompagnateurs	Moyenne	Moyenne	Statut salarié plutôt que prestataire pour les intervenants en établissement

8.2 Les risques éthiques — plus dangereux que les risques juridiques

Le risque d'aggraver l'inégalité. Un service payant d'accompagnement crée mécaniquement deux catégories de patients dans le même couloir : ceux qui ont un accompagnateur et les autres. Dans un hôpital public, c'est une bombe sociale et un problème moral réel. **Vous devez y répondre avant qu'on vous le demande.** La réponse la plus solide : une part de gratuité contractuellement garantie dans chaque convention hospitalière (par exemple, un pourcentage d'heures pour des patients désignés par le service social), et une transparence totale sur les tarifs.

Le risque de déresponsabiliser l'établissement. Si votre présence permet à l'hôpital de ne pas améliorer sa propre information des patients, vous devenez le pansement qui empêche la guérison. Le décret 2025-481 impose à l'établissement d'impliquer le patient — pas de sous-traiter cette implication. Votre offre doit être formulée comme un **transfert de compétence** (nous vous aidons à faire), pas comme une **substitution durable** (nous faisons à votre place). C'est aussi commercialement plus intelligent : la substitution se fait couper au premier arbitrage budgétaire.

Le risque de capture émotionnelle. Vos accompagnateurs seront présents dans des moments d'intensité extrême. Ils seront aimés, puis investis d'une autorité qu'ils n'ont pas. Une famille finira par leur demander : « à votre avis, on fait quoi ? » La seule réponse acceptable — « je ne peux pas répondre à cette question, allons la poser ensemble au médecin » — est contre-intuitive, coûteuse émotionnellement et doit être répétée en formation jusqu'à devenir un réflexe.

Le risque de devenir un canal de plaintes. Si votre modèle économique tire un quelconque bénéfice des litiges, vous êtes fini. Aucune rémunération, aucun partenariat, aucune part de chiffre d'affaires ne doit dépendre d'un contentieux.

Le risque sur vos propres accompagnateurs. Exposition répétée à la souffrance, à la mort, à la colère des familles. Sans supervision, vous les userez en dix-huit mois. Prévoyez une supervision régulière dès le premier recrutement — c’est un coût, et il n’est pas optionnel.

8.3 Le risque données, en détail

C’est le risque le plus probable, le plus sous-estimé, et le seul qui peut vous atteindre **avant même d’avoir un seul client mécontent**.

Pourquoi il est spécifique à vous : un médecin qui détient un dossier médical est tenu au secret professionnel (déontologie art. 7) et protégé par un cadre ancien et connu. Votre accompagnateur, lui, n’est tenu à rien d’autre qu’à son contrat de travail. Il détient les mêmes informations avec beaucoup moins d’obligations — et donc beaucoup moins de protections pour le patient.

Architecture recommandée — par ordre de préférence :

Niveau	Description	Recommandation
N0 — Zéro donnée	Aucun enregistrement. L’accompagnateur travaille avec la famille sur ses propres documents et ne conserve rien.	Idéal au démarrage. Contraignant, mais élimine 90 % du risque.
N1 — Données administratives seules	Nom, contact, établissement, dates, montants, statut des démarches. Aucune donnée clinique.	Cible réaliste. Reste un traitement de données personnelles, mais potentiellement hors du régime « données de santé » si aucun élément clinique n’est enregistré. [INTERPRÉTATION — à faire valider par l’APDP, car le seul fait d’associer un nom à une hospitalisation peut suffire à qualifier une donnée de santé]
N2 — Données de santé	Photos d’ordonnances, résultats, diagnostics.	À éviter tant que possible. Autorisation APDP (art. 394), consentement exprès du patient, registre (art. 435), sécurité, durée de conservation, procédure de suppression, éventuellement DPO.

Décisions à prendre avant la première prestation :

1. Quel niveau ? (Je recommande N1, avec une discipline stricte pour ne pas glisser en N2.)
2. Qui consent ? Le patient, pas le payeur. Formulaire bilingue, oralisé si nécessaire.
3. Combien de temps ? Fixez une durée courte — trois mois après la fin de la prestation, par exemple — et supprimez réellement.
4. Qui a accès ? Principe du besoin d’en connaître. Un accompagnateur n’accède qu’à ses propres dossiers.
5. Que se passe-t-il en cas de fuite ? Procédure de notification écrite avant l’incident, pas après.
6. **Démarche APDP engagée avant le premier client, pas après.** Les régularisations a posteriori se voient.

8.4 CRITIQUE DE FOND — sept objections que vous devez traiter

Vous avez demandé une analyse critique. Voici les objections que je formulerais si j’étais l’investisseur en face de vous.

Objection 1 — Vous vendez la résolution d'un problème secondaire à des gens qui ont un problème primaire.

Le problème dominant documenté dans le système de santé béninois est **financier**. Une étude conduite en 2023 dans un hôpital de référence du sud du Bénin conclut que **seuls 14,74 % des usagers avaient une capacité de paiement satisfaisante**, avec des facteurs associés incluant le chômage (OR = 48,98), le petit commerce (OR = 17,12), l'absence de dispositif social hospitalier (OR = 4,64) et une attente au paiement d'une heure ou plus (OR = 5,07). [PRATIQUE — source académique, un établissement, 2023]

Un ménage qui n'arrive pas à payer la consultation n'achètera pas un service d'accompagnement. La compréhension est un besoin réel, mais c'est un besoin de **deuxième rang** : il n'apparaît qu'une fois le premier résolu.

Ce qui sauve le projet : deux des facteurs listés ci-dessus — l'absence de dispositif social et l'attente au paiement — sont **organisationnels**. Ils sont donc dans votre périmètre. Mais cela signifie que votre valeur n'est pas « je vous explique », c'est « **je vous fais économiser** ». Reformulez toute votre proposition de valeur autour de l'argent économisé, pas de la compréhension gagnée. Un service qui fait économiser 20 000 FCFA se vend 5 000 FCFA. Un service qui apporte de la sérénité ne se vend pas.

Objection 2 — Vous avez probablement généralisé une expérience personnelle.

Votre document de départ décrit avec une précision remarquable un scénario de décès avec des démarches poursuivies et des dépenses inutiles. Cette précision suggère un vécu.

Un vécu est un excellent point de départ et un très mauvais point d'arrivée. Il vous dit qu'un problème **existe** ; il ne vous dit ni sa **fréquence**, ni sa **distribution**, ni s'il est le **plus douloureux** parmi les problèmes possibles, ni si les gens **paieraient** pour l'éviter.

La partie 9 propose un protocole pour trancher. **Ne financez rien avant de l'avoir exécuté**. C'est le conseil le plus important de cette étude après celui sur les médicaments.

Objection 3 — Le concept est trop large pour être exécutable.

Votre liste de services comporte dix items hétérogènes : compréhension, communication, administratif, orientation, déplacements, logistique médicament, coordination, accompagnement, identification d'interlocuteurs, réduction des dépenses. Ils ne mobilisent ni les mêmes compétences, ni les mêmes risques, ni les mêmes payeurs, ni les mêmes preuves de valeur.

Une entreprise qui démarre avec dix promesses n'en tient aucune. **Choisissez-en une, prouvez-la, mesurez-la, puis élargissez**. Sur la base de cette analyse, je recommanderais de commencer par la **boucle de l'examen (T6→T7)** ou par la **navigation financière (AMO, gratuités, facturation)** — les deux ont un risque juridique faible et une preuve de valeur chiffrable.

Objection 4 — Vous n'avez pas identifié votre payeur naturel.

Le payeur le plus évident de ce type de service dans le contexte béninois n'est pas le patient hospitalisé. C'est **le membre de la famille qui n'est pas là**.

La diaspora béninoise a trois caractéristiques qui en font un client structurellement adapté : elle dispose de revenus en devises, elle est géographiquement empêchée, et elle finance déjà massivement les soins de ses proches restés au pays sans aucun moyen de contrôle ni d'information. Ce qu'elle achète n'est pas « de la compréhension » : c'est **une présence de confiance et un compte rendu**. C'est très exactement votre service, vendu à quelqu'un qui peut le payer et qui en ressent le manque tous les jours.

Ce segment n'apparaît nulle part dans votre document. **Je le considère comme la piste B2C la plus prometteuse, et de loin.**

Attention cependant : ce segment amplifie le risque de l'objection 1 sur le plan éthique (un service pour ceux qui ont de la famille à l'étranger) et le risque données (transferts internationaux de données personnelles — régime spécifique du Code du numérique, **[À VÉRIFIER]**).

Objection 5 — L'hôpital pourrait vous voir comme une menace, pas comme une aide.

Un tiers présent dans un service, qui note ce qui se passe, qui parle aux familles, qui repère les incohérences de facturation : de l'intérieur, cela ressemble à un contrôleur. Aucune direction n'ouvre volontairement ses portes à un contrôleur privé.

Deux contre-mesures indispensables : - Votre positionnement doit être explicitement **au service de la conformité de l'établissement** (décret 2025-481), pas au service du contrôle du soignant. - Vos accompagnateurs doivent rappeler les **devoirs** des patients autant que leurs droits. C'est peu coûteux et cela change radicalement la perception des équipes.

Objection 6 — La valeur pour l'hôpital est supposée, pas démontrée.

Vous listez des bénéfices attendus : moins d'incompréhensions, meilleure expérience patient, moins de déplacements inutiles, meilleure orientation, moins d'erreurs organisationnelles, satisfaction, sécurité, allègement de la charge non médicale des soignants.

Aucun de ces bénéfices n'est démontré à ce stade. Ce sont des hypothèses plausibles. Les présenter comme des acquis dans un business plan est la meilleure façon de perdre la crédibilité d'un directeur d'hôpital, qui sait très bien qu'on ne peut pas le savoir.

Le seul discours tenable : « voici ce que nous pensons pouvoir améliorer, voici comment nous proposons de le **mesurer**, voici ce que nous nous engageons à faire si la mesure est négative. » Un pilote avec des indicateurs et une clause d'arrêt vaut mieux que dix pages de promesses.

Objection 7 — Vous n'existez pas juridiquement.

Il n'y a, dans le droit béninois, aucun statut de « facilitateur du parcours patient ». Ce n'est pas une interdiction, c'est un vide. Un vide peut être comblé dans les deux sens.

Stratégie recommandée : ne restez pas dans le silence. Allez chercher, dans l'ordre : (1) une convention écrite avec un établissement ; (2) une information formelle à l'ARS de votre existence et de votre périmètre ; (3) une position écrite de l'ABMed si vous touchez au médicament ; (4) une autorisation APDP. Quatre écrits. Ils constituent, ensemble, votre licence sociale d'opérer — et ils sont probablement plus précieux que votre premier client.

8.5 Le problème est-il bien posé ? Ma réponse

Vous avez formulé le problème ainsi : *les patients et leurs familles ne comprennent pas, se perdent, perdent du temps et de l'argent dans un système qu'ils ne maîtrisent pas.*

C'est vrai. Mais c'est un **symptôme**.

Le problème sous-jacent me paraît être : **personne, dans le parcours béninois, n'est responsable de la continuité de l'information entre les acteurs.** Le médecin est responsable de son acte, l'infirmier du sien, la caisse de la sienne, le laboratoire du sien. Personne n'est responsable du **lien** entre eux. La famille occupe ce rôle par défaut, sans compétence, sans mandat, sans information et sans temps.

Cette reformulation change deux choses.

Elle change votre client. Si le problème est un défaut de continuité de l'information dans une organisation, alors c'est un problème d'organisation. Les problèmes d'organisation se vendent aux organisations. Le B2B n'est pas un pis-aller commercial : c'est la conséquence logique d'un diagnostic correct.

Elle change votre produit. Vous ne vendez pas de l'accompagnement humain à la demande. Vous vendez **une fonction de continuité** : un rôle qui n'existe pas dans l'organigramme et que le décret 2025-481 rend désormais obligatoire de couvrir. C'est plus étroit, moins émouvant, et beaucoup plus solide.

Existe-t-il une meilleure solution ? Peut-être, et je vous la soumetts honnêtement : pour une partie substantielle des ruptures identifiées, la solution la moins chère n'est pas un accompagnateur humain — c'est un **document**. Une fiche par parcours, en français et en langues nationales, remise à l'admission, disant : voici les étapes, voici les coûts, voici ce qui est gratuit, voici qui contacter, voici votre rendez-vous. Une fiche coûte 50 francs et ne s'épuise pas.

Cela ne détruit pas votre projet. Cela suggère que votre **premier produit** pourrait être une prestation d'ingénierie documentaire vendue aux établissements, et que l'accompagnement humain devrait être réservé aux situations où le document ne suffit pas : illettrisme, absence de famille, complexité élevée, diaspora. Cette séquence est moins glorieuse. Elle est beaucoup plus finançable.

9. MODÈLE INSTITUTIONNEL, PILOTE ET VALIDATION TERRAIN

9.1 Comment présenter le projet — un discours par interlocuteur

Le même projet doit être présenté différemment selon la personne en face. Ce n'est pas de la manipulation : chacun a un problème différent, et vous ne résolvez pas le même pour tous.

Interlocuteur	Son problème réel	Ce que vous dites	Ce que vous ne dites jamais
Direction d'hôpital	La conformité au décret 2025-481 dans les délais, la réputation, la fréquentation, les plaintes.	« Nous vous aidons à documenter et à atteindre le domaine 2 du dispositif de sécurité des patients — implication du patient et de la communauté — avec des indicateurs mesurables et un pilote à durée déterminée. »	Que vous avez constaté des dysfonctionnements. Que vous défendez les patients.
Médecin-chef	Son temps. La qualité de ses consultations. Sa responsabilité.	« Vos patients arriveront en consultation avec leurs questions préparées et leurs documents complets. Nous ne touchons à rien de médical, et nous vous renvoyons systématiquement toute question clinique. »	Que vous allez « expliquer » à leur place.
Infirmier-chef	La charge non médicale. Les accompagnants dans le service. Les mêmes questions cinquante fois par jour.	« Nous prenons l'orientation, l'administratif et les questions répétitives. Nous vous alertons, nous	Que vous allez « améliorer la communication » — cela s'entend comme un reproche.

Interlocuteur	Son problème réel	Ce que vous dites	Ce que vous ne dites jamais
		ne décidons rien, et nous ne restons jamais sans votre accord. »	
Sage-femme responsable	La sécurité en maternité. Les familles en salle. Les urgences.	« Protocole renforcé, jamais en salle de naissance sans votre autorisation, information des familles sur la gratuité de la césarienne et sur les démarches. »	Rien qui touche à l'indication ou à la surveillance.
Pharmacien	Le respect du monopole. Sa responsabilité. Les ruptures qu'il subit.	« Nous ne dispensons rien, nous ne stockons rien, nous ne prenons aucune marge et nous n'acceptons aucune commission. Nous réduisons le temps que les familles perdent à chercher. »	Toute idée de partenariat commercial. C'est le sujet qui vous grille.
Administration / facturation	Les impayés. Les contestations. Les files d'attente.	« Des familles qui comprennent leur facture contestent moins et paient mieux. Nous pouvons aussi documenter les prestations restées en suspens. »	Que vous cherchez des erreurs de facturation.
ARS	La mise en œuvre effective du dispositif, la certification, la donnée.	« Nous souhaitons vous informer de notre existence, de notre périmètre strict et de nos limites, et contribuer à la remontée d'information sur l'expérience patient. »	Que vous vous positionnez comme un régulateur ou un recours.
ABMed	Le respect du monopole pharmaceutique.	« Nous voulons votre position écrite sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire en matière de recherche et de transport de médicaments. »	Rien. Demandez, écoutez, obéissez.
APDP	La conformité des traitements de données de santé.	« Voici notre traitement, voici pourquoi il est minimal, voici notre demande d'autorisation.	Ne pas les contacter du tout — c'est l'erreur la plus fréquente.

Interlocuteur	Son problème réel	Ce que vous dites	Ce que vous ne dites jamais
		»	

9.2 Ce que l'hôpital pourrait y gagner — et ce qui doit être prouvé

Votre cahier des charges le demandait explicitement : je ne suppose aucun de ces bénéfices. Voici ce qui est plausible, et ce que le pilote doit mesurer.

Bénéfice attendu	Statut	Indicateur de vérification
Réduction des incompréhensions	Hypothèse	Score de compréhension post-consultation (3 questions fermées) avant/après
Amélioration de l'expérience patient	Hypothèse	Enquête de satisfaction standardisée, avant/après, même instrument
Réduction des déplacements inutiles	Hypothèse, mesurable	Nombre de venues n'ayant donné lieu à aucun acte
Meilleure circulation de l'information	Hypothèse, mesurable	Délai prescription → retour du résultat au prescripteur
Meilleure orientation des familles	Hypothèse, mesurable	Part des présentations à un niveau inadapté de la pyramide
Réduction d'erreurs organisationnelles	Hypothèse faible	Nombre de prestations engagées puis devenues sans objet
Amélioration de la satisfaction	Hypothèse	Idem expérience patient
Amélioration de la sécurité du patient	Non démontrable par un pilote court	À ne pas revendiquer. Contribution possible à des critères du référentiel ARS, pas plus.
Réduction de la charge non médicale des soignants	Hypothèse, mesurable	Auto-déclaration du temps passé en explications non cliniques, sur échantillon de postes

Deux bénéfices supplémentaires, plus faciles à démontrer et rarement cités : - **Amélioration du taux de recouvrement** : une famille qui comprend sa facture et le calendrier de paiement paie plus souvent. C'est un indicateur que l'administration suit déjà. - **Production de livrables de conformité** : nombre de documents produits pour le dossier de certification. Binaire, incontestable, immédiat.

9.3 Le protocole de validation terrain

C'est la partie que vous avez demandée avec le plus d'insistance : « je veux éviter absolument de construire une entreprise sur la base d'une seule expérience personnelle. » Voici comment.

Principe de base : séparer trois questions

Question	Méthode	Erreur classique
Le problème existe-t-il ?	Observation directe + registres	Se contenter de demander aux gens. Ils répondent toujours oui.
Est-il fréquent ?	Comptage sur échantillon défini	Généraliser à partir des cas les plus marquants
Quelqu'un paierait-il pour l'éviter ?	Test d'engagement réel	Demander « paieriez-vous ? ». La réponse déclarative n'a aucune valeur prédictive.

La troisième question est la seule qui décide de l'existence de votre entreprise, et c'est celle que la plupart des porteurs de projet ne testent jamais.

Phase 1 — Cadrage (2 semaines)

- Choisir **3 établissements contrastés** : un hôpital de zone, un CHD, une structure de premier contact. Un seul site ne prouve rien ; trois sites contrastés permettent de distinguer ce qui est structurel de ce qui est local.
- Obtenir une autorisation écrite de la direction pour chaque site. Sans autorisation, aucune observation.
- Vérifier l'existence d'un comité d'éthique compétent et, le cas échéant, obtenir son avis. **[À VÉRIFIER — régime de la recherche sur des sujets humains au Bénin]**
- Constituer un protocole écrit : ce que vous observez, ce que vous ne notez jamais, comment vous anonymisez.

Phase 2 — Observation non participante (4 semaines)

Placez-vous dans les couloirs, pas dans les chambres. Notez des faits horodatés, jamais de données médicales.

Ce qu'on observe, concrètement : - Le trajet réel d'un patient de l'arrivée à la sortie : nombre d'arrêts, nombre de personnes à qui il parle, nombre de fois où il revient sur ses pas. - Les temps d'attente à chaque étape. - Le nombre de fois où une famille pose la même question à des personnes différentes. - Le délai entre la prescription d'un examen et la remise du résultat au prescripteur. - Le nombre de patients repartis sans avoir vu un soignant. - Le nombre d'orientations vers l'extérieur pour un médicament.

Méthode recommandée : le « patient traceur ». Suivre 30 à 50 patients de bout en bout, avec leur consentement, en notant uniquement la chronologie et les étapes — jamais le contenu clinique. C'est la méthode la plus convaincante auprès d'une direction hospitalière, parce qu'elle produit un schéma, pas une opinion.

Phase 3 — Entretiens (3 semaines)

Toujours en fin d'enquête, jamais au début : vous devez savoir ce que vous cherchez avant de demander.

À la direction 1. Où en êtes-vous de la mise en conformité au dispositif de sécurité des patients ? Quels critères du domaine « implication du patient » vous posent le plus de difficulté ? 2. Combien de réclamations recevez-vous par mois ? Sur quoi portent-elles ? 3. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher aujourd'hui : les impayés, les litiges, le turnover, autre chose ? 4. Qui, dans votre organisation, est responsable de l'information des familles ? 5. Qu'est-ce qui vous ferait refuser un partenaire extérieur ?

Aux médecins 1. Combien de temps consacrez-vous en moyenne à expliquer des choses non cliniques ? 2. Quelle proportion de vos patients revient sans avoir fait ce que vous aviez prescrit ? Pourquoi, selon vous ? 3. Que faites-vous quand un examen que vous avez prescrit ne revient jamais ? 4. Qu'est-ce qu'un tiers extérieur ne devrait jamais faire dans votre service ? 5. Si vous pouviez déléguer une seule tâche non médicale, laquelle ?

Aux infirmiers 1. Combien de fois par jour répondez-vous à la même question d'accompagnants ? 2. Que se passe-t-il quand un patient n'a pas de famille présente ? 3. Comment les familles apprennent-elles l'évolution de l'état d'un patient ? 4. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps ? 5. Qu'est-ce qui vous inquiéterait si une personne extérieure était présente dans le service ?

Aux sages-femmes 1. Les femmes savent-elles que la césarienne est gratuite ? Qu'est-ce qu'elles croient devoir payer ? 2. Comment se passe l'information de la famille pendant le travail ? 3. Quelles ruptures d'information voyez-vous le plus souvent en post-partum ? 4. Qu'est-ce qui rendrait une présence extérieure acceptable en maternité — et inacceptable ?

Aux pharmaciens 1. À quelle fréquence orientez-vous une famille vers l'extérieur pour un produit indisponible ? 2. Que font les familles ensuite ? Reviennent-elles ? 3. Voyez-vous revenir des produits achetés et non utilisés ? 4. Qu'est-ce qui vous poserait un problème déontologique dans une aide à la recherche de disponibilité ?

Aux patients (après la sortie, jamais pendant les soins) 1. Racontez-moi ce qui s'est passé depuis votre arrivée. (*Question ouverte, laisser dérouler — c'est la plus informative de toutes.*) 2. Y a-t-il eu un moment où vous ne saviez pas quoi faire ? Qu'avez-vous fait ? 3. Combien avez-vous dépensé ? Y a-t-il quelque chose que vous avez payé et qui n'a servi à rien ? 4. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué ce que vous aviez ? Avez-vous compris ? 5. Combien de trajets avez-vous faits ?

Aux accompagnants 1. Combien de jours avez-vous manqué le travail ? 2. Qu'est-ce que vous avez dû faire vous-même que vous ne pensiez pas devoir faire ? 3. À qui vous êtes-vous adressé quand vous ne compreniez pas ? 4. Qu'est-ce qui vous aurait le plus aidé ?

Phase 4 — Le test de solvabilité (2 à 3 semaines) — la phase décisive

Ne demandez jamais « paieriez-vous ? ». Faites payer.

Protocole minimal : - Proposez une prestation réelle, limitée et clairement décrite, à un tarif affiché, à 30 à 50 familles. - Mesurez : combien acceptent d'entendre l'offre, combien acceptent le principe, **combien paient effectivement**, combien reviennent une deuxième fois. - Le seul chiffre qui compte est le troisième. Les deux premiers sont de la politesse. - Variez le tarif entre sous-groupes pour observer l'élasticité.

En parallèle, testez le segment diaspora : une offre simple (visite, compte rendu écrit sous 24 h, coordination administrative), diffusée dans des réseaux de Béninois de l'étranger. Mesurez le taux de conversion et le prix accepté. **[HYPOTHÈSE : ce segment convertira nettement mieux et à un prix supérieur. C'est une hypothèse à falsifier, pas une certitude.]**

Testez aussi le B2B : présentez à trois directions une prestation de conformité au décret 2025-481, chiffrée. La question n'est pas si elles trouvent l'idée bonne — elles la trouveront bonne. La question est si elles signent une lettre d'intention.

Phase 5 — Distinguer perception et réalité

C'est le point le plus difficile de toute enquête de terrain, et vous avez eu raison de l'inscrire dans votre cahier des charges.

Méthode	Ce qu'elle permet
Triangulation systématique	Ne retenir un fait que s'il est confirmé par au moins deux sources de nature différente : un témoignage et une observation, ou un témoignage et un registre.
Confrontation aux registres	Comparer le temps d'attente ressenti au temps horodaté. L'écart est en soi une donnée précieuse : une attente d'une heure vécue comme trois heures est un problème d'information, pas de délai.

Méthode	Ce qu'elle permet
Question ouverte d'abord	Toujours faire raconter avant de proposer des catégories. Les questions fermées fabriquent les réponses qu'elles contiennent.
Contre-interrogatoire bienveillant	« Qu'est-ce qui aurait pu expliquer cela autrement ? » Appliquer systématiquement la grille des 8 catégories de la partie 6.1.
Recherche active du cas contraire	Chercher délibérément les patients dont le parcours s'est bien passé. S'ils sont majoritaires, votre marché est plus petit que prévu. C'est une information que vous devez vouloir connaître.
Ne jamais interroger seulement les mécontents	Le biais de sélection est le tueur silencieux des études de marché.
Séparer les rôles	Celui qui observe ne doit pas être celui qui vend.

Indicateurs à mesurer — tableau de bord du pilote

Indicateur	Unité	Source	Pourquoi il compte
Délai prescription → résultat chez le prescripteur	heures	Registres	Le plus démonstratif
Nombre de venues sans acte	n / semaine	Registres	Déplacements inutiles
Part des présentations au mauvais niveau de la pyramide	%	Observation	Orientation
Temps d'attente au paiement	minutes	Chronométrage	Facteur documenté d'incapacité de payer
Score de compréhension post-consultation	/3	3 questions fermées	Cœur de votre promesse
Dépense totale du ménage par épisode	FCFA	Déclaratif + justificatifs	Le chiffre qui parle à tout le monde
Prestations engagées devenues sans objet	n	Registres + relevé familial	Votre cas critique
Familles ayant payé la prestation test	n et %	Vos propres registres	L'indicateur décisif
Taux de retour (deuxième achat)	%	Idem	Preuve de valeur réelle
Réclamations reçues par l'établissement	n / mois	Direction	Effet indirect

Collecte des incidents

Utilisez un formulaire court : date, heure, lieu, ce qui a été observé (faits uniquement), qui était présent (fonctions, pas noms), conséquence constatée, **catégorie provisoire parmi les 8 de la partie 6.1**, action entreprise.

Trois règles absolues : aucune donnée médicale ; aucune identification nominative de professionnel ; aucune qualification de faute. Le formulaire lui-même doit rendre ces dérives impossibles — ne prévoyez pas de case pour un nom de soignant.

9.4 Architecture du pilote recommandé

Paramètre	Recommandation
Durée	6 mois — assez pour mesurer, assez court pour que la direction s'engage
Périmètre	Un seul service , choisi avec la direction. Pas tout l'hôpital.
Effectif	2 accompagnateurs + 1 superviseur. Pas plus.
Cadre	Convention écrite : périmètre, horaires, interdits, référent hospitalier, confidentialité, propriété des données, clause de résiliation immédiate
Financement	Idéalement mixte : une part hôpital, une part fondation ou bailleur. Un pilote entièrement gratuit n'est pas pris au sérieux ; un pilote entièrement payant ne se signe pas.
Évaluation	Indicateurs définis avant le démarrage, mesurés avant/après, présentés même s'ils sont mauvais
Sortie	Trois issues prévues dès la signature : arrêt, poursuite payante, transfert de compétence à l'établissement. La troisième doit être présentée comme un succès, pas comme un échec commercial.

10. MODÈLE ÉCONOMIQUE, GOUVERNANCE ET RECOMMANDATIONS

10.1 Les six modèles économiques possibles

Aucun chiffre n'est avancé — vous n'en avez pas encore le droit, faute d'enquête. Ce qui suit est une analyse structurelle.

Modèle 1 — Paiement direct par la famille (B2C à l'acte)

Qui paie	La famille présente
Pourquoi	Détresse immédiate, besoin ponctuel
Valeur fournie	Présence, orientation, démarches

Conflits d'intérêts	Faible
Risques réglementaires	Faibles, sauf si vous vendez de la « compréhension médicale »
Verdict	Faible viabilité comme modèle principal. Capacité de paiement documentée très basse. Achat en situation de crise, donc non récurrent, donc coût d'acquisition élevé pour un revenu unique.

Modèle 2 — Abonnement familial

Qui paie	Un ménage, mensuellement, avant d'en avoir besoin
Pourquoi	Anticipation, tranquillité
Valeur fournie	Disponibilité
Conflits d'intérêts	Faible
Risques réglementaires	Attention : un abonnement qui promet une prise en charge en cas de maladie peut s'approcher d'un produit d'assurance, activité réglementée dans l'espace CIMA. [À VÉRIFIER impérativement]
Verdict	Difficile en B2C local (payer contre un risque qu'on n'a pas encore). Beaucoup plus crédible en version diaspora , où l'abonnement finance une présence régulière auprès d'un parent âgé, pas une assurance.

Modèle 3 — Paiement par prestation, avec catalogue

Qui paie	Famille ou payeur tiers
Pourquoi	Besoin précis et identifiable
Valeur fournie	Un livrable défini : une visite, un compte rendu, une démarche accomplie
Conflits d'intérêts	Faible
Risques réglementaires	Faibles si le catalogue exclut explicitement tout acte médical
Verdict	Le meilleur modèle pour démarrer et pour apprendre. Il vous force à définir des livrables, donc à savoir ce que vous vendez, donc à pouvoir le mesurer et le tarifier.

Modèle 4 — Partenariat avec les établissements de santé (B2B)

Qui paie	L'hôpital ou la clinique
Pourquoi	Conformité au décret 2025-481 , certification ARS,

	satisfaction, recouvrement, production documentaire
Valeur fournie	Contribution à des critères du référentiel, supports d'information, recueil de l'expérience patient, appui administratif
Conflits d'intérêts	Réel et sérieux : si l'hôpital vous paie, pouvez-vous encore aider une famille contre l'hôpital ?
Risques réglementaires	Faibles
Verdict	Le modèle le plus solide, et le seul avec un moteur réglementaire. Le conflit d'intérêts doit être traité frontalement, dans la convention : périmètre explicite, engagement de neutralité, et interdiction pour l'hôpital d'exiger le silence de votre part sur un fait grave.

Modèle 5 — Partenariat entreprises, assurances, diaspora

Qui paie	Un employeur, un assureur, un membre de la famille à l'étranger
Pourquoi	Avantage social ; réduction des coûts de sinistres ; impossibilité d'être présent
Valeur fournie	Accompagnement des salariés ou des ayants droit ; présence et compte rendu
Conflits d'intérêts	Réel avec un assureur — si l'assureur vous paie, vous pourriez être incité à limiter les dépenses de soins. À interdire contractuellement.
Risques réglementaires	Transferts internationaux de données personnelles pour le volet diaspora [À VÉRIFIER] ; intermédiation d'assurance
Verdict	Le volet diaspora est la piste B2C la plus prometteuse de toutes. Le volet assureur est à traiter avec prudence.

Modèle 6 — Hybride

Structure	Socle B2B (conventions hospitalières) + revenus B2C ciblés (diaspora, prestations à l'acte) + éventuel financement bailleur pour la part sociale
Verdict	La cible réaliste à 24 mois. Mais on n'arrive pas à un modèle hybride en le décrétant : on y arrive en ayant validé chaque brique séparément.

Ce que je retiens

Séquence recommandée : Modèle 3 (prestations au catalogue) pour apprendre → Modèle 4 (B2B conventionné) comme socle → Modèle 5 (diaspora) comme moteur de croissance → Modèle 6 comme état stable.

Ce que j'écarterais : le Modèle 1 comme activité principale, et toute forme de rémunération par un fournisseur de biens ou de services médicaux.

10.2 Gouvernance et éthique

Code de conduite de l'accompagnateur — les dix règles

À afficher, faire signer, et rappeler à chaque supervision.

1. **Je n'exerce aucun acte médical, paramédical ou pharmaceutique.** Je ne diagnostique pas, je ne prescris pas, je n'interprète pas, je n'évalue pas la gravité d'un symptôme.
2. **Je transmets les questions au professionnel ; je ne transmets jamais la réponse à sa place.**
3. **Je m'adresse d'abord au patient.** Je ne communique une information le concernant à un proche qu'avec son accord.
4. **Je ne conserve aucun document médical** au-delà de la durée strictement nécessaire à la démarche en cours, et jamais sans consentement écrit.
5. **Je n'accepte aucun cadeau, aucune commission, aucun avantage** d'un professionnel, d'une pharmacie, d'un laboratoire ou d'un établissement.
6. **Je ne qualifie jamais une situation de faute, d'erreur ou d'escroquerie.** Je décris des faits et j'oriente vers l'autorité compétente.
7. **Je ne critique jamais un soignant devant une famille.**
8. **Je respecte le règlement intérieur de l'établissement** et l'autorité du référent désigné.
9. **En cas de doute, je m'abstiens et j'appelle mon superviseur.**
10. **Si je vois un patient en danger, j'alerte immédiatement un soignant** — et je n'agis pas moi-même.

Procédures obligatoires

Situation urgente. Alerte immédiate et verbale de l'infirmier présent, puis du médecin de garde. Si aucune réaction : alerte du cadre de garde, puis du référent hospitalier de la convention. Consignation écrite de l'heure de chaque alerte et de la réponse obtenue. **Ne jamais poser d'acte, ne jamais transporter le patient soi-même, ne jamais conseiller un départ contre avis médical.**

Patient qui semble en danger. Même procédure. La description doit être factuelle et observable : « respire vite, ne répond plus depuis dix minutes » — jamais « je pense qu'il fait un choc ».

Demande d'un professionnel que l'accompagnateur ne comprend pas. Ne jamais exécuter par politesse. Reformuler, demander l'écrit, appeler le superviseur. Si la demande sort du périmètre conventionné, refuser poliment et en référer. Consigner.

Famille qui accuse un soignant. Écouter sans confirmer ni infirmer. Ne rien qualifier. Informer de l'existence des voies de recours — le circuit de l'article 8 et son délai de deux mois — et de la possibilité de consulter un avocat. Informer le référent hospitalier de l'existence d'une tension, sans reprendre l'accusation à son compte. Ne jamais se constituer témoin volontaire ; ne jamais mentir si l'on est appelé à témoigner.

Plainte contre votre entreprise. Accusé de réception sous 48 h. Instruction par une personne non impliquée. Réponse écrite sous 15 jours. Registre des plaintes. Analyse trimestrielle en comité.

Erreur de l'accompagnateur. Déclaration obligatoire au superviseur **dans la journée**, sans sanction pour la déclaration elle-même — c'est la seule façon d'avoir une culture d'erreur utilisable, et c'est aussi ce que promeut le décret 2025-481. Information de la famille. Réparation si possible. Analyse en comité. Sanction réservée à la dissimulation et à la répétition.

Conflits d'intérêts — règles structurelles

- Aucune rémunération d'un fournisseur de biens ou de services médicaux. Aucune exception.
- Déclaration annuelle d'intérêts de chaque salarié : liens familiaux ou financiers avec un établissement, une officine, un laboratoire.
- Recommandations toujours plurielles : jamais une seule officine, jamais un seul laboratoire, jamais un seul praticien.
- Publication de la politique tarifaire.
- Comité d'éthique externe (un juriste, un soignant, un représentant d'usagers), réuni au moins deux fois par an, avec pouvoir de saisine sur tout cas litigieux.

Données — engagements à publier

Niveau de données retenu et justification. Durée de conservation. Procédure de suppression, exécutée et vérifiable. Droits d'accès et de rectification, avec un point de contact réel. Procédure de notification en cas de violation. Statut de la démarche auprès de l'APDP.

Assurance

Responsabilité civile professionnelle **obligatoire avant la première prestation**. Précédent utile pour convaincre un assureur : l'article 77 de la loi n°2020-37 impose déjà cette obligation à tous les établissements sanitaires béninois. Vérifiez explicitement l'exclusion du risque médical dans votre police — et sachez que cette exclusion est aussi la preuve que vous n'exercez pas la médecine.

10.3 Recommandations pour la rédaction du business plan

Ce qu'il faut écrire noir sur blanc dès la première page

« Cette entreprise n'exerce aucune activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique. Elle n'établit aucun diagnostic, ne délivre aucune prescription, n'interprète aucun résultat et ne dispense aucun médicament. Elle intervient exclusivement sur l'organisation, l'information administrative, la logistique et la coordination du parcours, dans le respect de la loi n°2020-37 modifiée, de la loi n°2021-03 et du Code du numérique. »

Cette phrase n'est pas un avertissement juridique de bas de page. C'est votre **définition de produit**. Placez-la en tête.

La structure que je recommande

1. **Problème** — formulé comme un défaut de continuité de l'information dans une organisation, avec les données de votre enquête. Pas votre histoire personnelle. Votre histoire personnelle va dans la lettre d'accompagnement, pas dans le business plan.
2. **Cadre juridique** — court, précis, avec la phrase ci-dessus, le tableau Vert/Orange/Rouge et la mention explicite des points que vous faites vérifier par un avocat. **Montrer que vous connaissez vos limites est un signal de sérieux, pas de faiblesse.**
3. **Solution** — une offre principale, pas dix. Un livrable défini, un indicateur, un prix.
4. **Preuve** — les résultats de l'enquête, y compris ce qui les contredit. Un business plan qui ne contient aucun résultat défavorable n'est pas cru.
5. **Marché et segments** — B2B conventionné, diaspora, prestations à l'acte. Avec, pour chacun, le taux de conversion réellement observé.
6. **Modèle économique** — séquence 3 → 4 → 5 → 6.
7. **Opérations** — recrutement, formation, supervision, contrôle qualité, gestion des données.

8. **Gouvernance et éthique** — code de conduite, procédures, comité externe. Cette section est un argument commercial vis-à-vis des hôpitaux, pas une contrainte.
9. **Risques** — la matrice de la partie 8.1, avec les mitigations. Ne les minimisez pas : un investisseur qui découvre lui-même le risque médicament après avoir lu votre plan ne reviendra pas.
10. **Trajectoire** — pilote, mesure, décision. Avec des critères d'arrêt explicites.

Les cinq écrits à obtenir avant de lever le moindre franc

Écrit	Auprès de qui	Pourquoi
Consultation juridique sur le périmètre d'activité	Avocat béninois	Version consolidée de la loi 2020-37, exercice illégal, montage médicament
Convention de pilote	Un établissement	Sans elle, vous n'existez pas sur le terrain
Position sur la logistique médicament	ABMed	Le seul moyen de sortir de la zone grise
Autorisation ou avis de conformité	APDP	Avant le premier client, pas après
Texte intégral du décret 2025-481 et du référentiel	ARS	C'est le cahier des charges de votre offre B2B

Les cinq documents à produire

1. **CGV** avec obligation de moyens, exclusion du champ médical, exclusion de l'urgence vitale, plafond de responsabilité, politique de données.
2. **Contrat type à double signature** (patient / payeur).
3. **Formulaire de consentement du patient** au traitement de ses données et à la communication d'informations à des tiers désignés — bilingue, oralisable.
4. **Code de conduite** signé par chaque accompagnateur.
5. **Fiches de procédure** : urgence, danger, décès, accusation, erreur, plainte.

Trois erreurs à ne pas commettre

Ne fondez rien sur la version 2021 de la loi n°2020-37. Trente-six articles ont été modifiés en 2022, dont presque tous ceux qui vous intéressent. Faites établir la version consolidée avant d'écrire une ligne de juridique.

Ne promettez jamais un résultat médical, ni même implicitement. Le vocabulaire compte : « meilleure prise en charge », « soins plus sûrs », « éviter les complications » sont des promesses médicales, même dans une plaquette commerciale.

Ne démarrez pas par le médicament. C'est le service le plus visible, le plus demandé et le plus risqué. Il ne sera jamais votre principale source de revenus, et il peut vous coûter l'entreprise.

10.4 Feuille de route à 12 mois

Période	Objectif	Livrable
Mois 1-2	Sécuriser le socle juridique	Version consolidée de la loi ; consultation d'avocat ; premiers contacts ARS et APDP

Période	Objectif	Livrable
Mois 2-4	Enquête terrain	Rapport d'observation sur 3 sites, patients traceurs, entretiens
Mois 4-5	Test de solvabilité	Chiffres réels de conversion sur trois segments
Mois 5-6	Décision	Go / No-go / Pivot , sur critères écrits à l'avance
Mois 6-7	Cadre	Convention de pilote, CGV, code de conduite, assurance, autorisation APDP
Mois 7-12	Pilote	6 mois, un service, deux accompagnateurs, indicateurs avant/après
Mois 12	Évaluation publique	Rapport présenté à l'établissement et à l'ARS, y compris les résultats négatifs

Le point de décision du mois 6 doit être réel. Écrivez aujourd'hui, pendant que vous êtes lucide, les critères qui vous feraient arrêter. Par exemple : moins de X % des familles sollicitées paient effectivement ; aucun établissement ne signe de lettre d'intention ; l'avocat conclut à un risque pénal non maîtrisable. Un critère d'arrêt écrit à l'avance est la seule protection contre l'attachement à sa propre idée.

CONCLUSION

Existe-t-il au Bénin un problème réel ? Oui. Le parcours patient comporte des ruptures de continuité de l'information documentables, et le législateur lui-même l'a reconnu en imposant, par le décret n°2025-481, un dispositif de sécurité des patients dont l'un des cinq domaines est l'implication du patient et de la communauté.

Un service privé peut-il le résoudre légalement ? Partiellement, oui — à condition de renoncer à trois choses : le contenu médical, la logistique du médicament, et toute rémunération venant d'un fournisseur de soins ou de produits de santé. Ce qui reste est étroit. Ce qui reste est défendable.

Utilement ? Probablement, mais ce n'est pas démontré. Les bénéfices que vous attendez sont plausibles et non prouvés. Le protocole de la partie 9 existe pour trancher, et il doit être exécuté avant tout engagement financier.

Durablement ? C'est la question la plus incertaine. Le B2C grand public se heurte à une capacité de paiement documentée très faible. Le B2B dispose désormais d'un moteur réglementaire daté, ce qui est rare et précieux. La diaspora constitue une piste sérieuse que vous n'aviez pas identifiée.

Ma recommandation en une phrase : ne construisez pas une entreprise d'accompagnement humain à la demande — construisez une **fonction de continuité de l'information**, vendez-la d'abord aux organisations qui ont désormais l'obligation de la couvrir, et n'ajoutez l'accompagnement humain que là où le document et le processus ne suffisent pas.

C'est moins beau que votre idée de départ. C'est plus proche de ce que le droit béninois vous autorise et de ce que le marché béninois peut payer.

ANNEXE A — TABLEAU « QUI FAIT QUOI ? »

Acteur	Décide	Agit	Informe	Ne peut pas	Base principale
Patient	Accepte ou refuse tout acte ou traitement, à tout moment	Fournit des informations exactes, suit ou non les prescriptions, paie	Signale les complications et les anomalies	Être contraint sans les procédures des art. 11-13	L. 2020-37 art. 7, 9, 10, 45 ; Charte
Famille / accompagnant	Rien pour un adulte capable. Décide pour un mineur (parents)	Assiste, transporte, achète, paie, garde	Reçoit l'information avec l'accord du patient ; reçoit l'annonce d'un pronostic fatal sauf refus du patient	Consentir à la place d'un adulte capable ; accéder au dossier sans accord	L. art. 12, 13 ; déontologie art. 33
Personne de confiance	Donne un avis quand le patient ne peut exprimer sa volonté	—	—	Se substituer à un patient conscient	L. art. 12 [régime à vérifier]
Médecin	Diagnostic, prescription, indication, annonce	Examine, prescrit, opère, consigne	Informe le patient ; informe le chef d'établissement en cas de refus	Percevoir des commissions ; exercer dans des locaux de vente de médicaments ; faire de la publicité	L. art. 9, 11, 75 ; ord. 1973-14 art. 7, 11, 18, 20, 33, 35
Infirmier	Rôle propre [à vérifier]	Exécute les soins et les prescriptions, surveille	Transmet à l'équipe, alerte le médecin	Prescrire, diagnostiquer	[HYPOTHÈSE]
Sage-femme	Conduite d'un accouchement eutocique [à vérifier]	Suit la grossesse, accouche, soigne le nouveau-né	Alerte le médecin en cas de risque	Sortir du champ physiologique	[HYPOTHÈSE]
Pharmacien	Valide ou refuse la dispensation	Dispense, conseille, contrôle l'ordonnance	Informe le prescripteur en cas d'indisponibilité	Dispenser hors établissement habilité	L. 2021-03 art. 6, 17, 41, 73 ; L. 2020-37 art. 28
Établissement	Organisation, tarifs, procédures	Accueille, soigne, facture, constate les	Informe les patients ; produit les	Fonctionner sans assurance RC ; ignorer le	L. art. 65-68, 76, 77 ; décret 2025-481

Acteur	Décide	Agit	Informe	Ne peut pas	Base principale
		décès, audite	rapports mensuels d'audits de décès	dispositif de sécurité des patients	
ARS	Certification, accréditation (sur rapport au ministre)	Évalue, certifie, accompagne	Publie les référentiels et la Charte	[Traitement des plaintes non établi]	Décret 2019-417 art. 5, 6, 33
ABMed	Autorisations pharmaceutiques, homologations	Inspecte, contrôle, surveillance	Alerte sur les produits	—	Décret 2023-422
APDP	Autorise les traitements de données de santé	Contrôle, sanctionne	—	—	Code du numérique art. 394, 405, 407
Ordres professionnels	Discipline	Instruisent les plaintes	—	—	L. art. 8
Ministre chargé de la santé	Actes de certification et d'accréditation ; saisine possible pour faute	—	—	—	L. art. 8 ; décret 2019-417 art. 6
VOTRE ENTREPRISE	Rien de médical	Informe sur le circuit, oriente, accompagne, coordonne l'administratif, produit des livrables	Transmet les questions au professionnel ; alerte en cas de danger	Diagnostiquer, prescrire, interpréter, dispenser, consentir, qualifier une faute, annoncer un décès	Voir Annexe D

ANNEXE B — DROIT / OBLIGATION / TEXTE / ARTICLE

#	Droit ou obligation	Titulaire	Texte	Article	Fiabilité
1	Droit à la santé, égal accès aux soins	Patient	Loi n°2020-37 du 03/02/2021	5	TEXTE — à reconstruire post-2022
2	Vie privée, dignité, information,	Patient	Loi n°2020-37	6	TEXTE — à reconstruire

#	Droit ou obligation	Titulaire	Texte	Article	Fiabilité
	confidentialité, expression de la volonté				
3	Droit d'accepter ou de refuser un acte ou un traitement	Patient	Loi n°2020-37	7	TEXTE — à reconstrôler
4	Saisine du ministre, de l'ordre ou de la juridiction en cas de faute suspectée, dans les 2 mois	Patient / famille	Loi n°2020-37	8	TEXTE — à reconstrôler
5	Obligation de recueillir le consentement	Médecin / praticien	Loi n°2020-37	9	TEXTE — à reconstrôler
6	Réversibilité de la décision à tout moment	Patient	Loi n°2020-37	10	TEXTE — à reconstrôler
7	Consignation du refus au dossier, information du chef d'établissement , puis du procureur	Praticien / établissement	Loi n°2020-37	11	TEXTE — à reconstrôler
8	Procédure applicable au refus de la personne de confiance	Praticien	Loi n°2020-37	12	TEXTE — à reconstrôler
9	Refus parental mettant en danger la vie de l'enfant	Praticien / parents	Loi n°2020-37	13	TEXTE — à reconstrôler
10	Sanctions pénales en cas de violation des art. 6, 9-13	—	Loi n°2020-37	14	TEXTE — à reconstrôler
11	Protection du praticien par	Praticien	Loi n°2020-37	21	TEXTE

#	Droit ou obligation	Titulaire	Texte	Article	Fiabilité
	l'État				
12	Standard de comportement professionnel	Professionnel	Loi n°2020-37	22	TEXTE
13	Le pharmacien est au service du public	Pharmacien	Loi n°2020-37	28	TEXTE
14	Devoirs de la population usagère	Patient	Loi n°2020-37	45	TEXTE — à reconstrôler
15	Déclaration obligatoire sous 72 h, confidentialité stricte	Professionnel	Loi n°2020-37	56	TEXTE — à reconstrôler
16	Tout décès est médicalement constaté	Établissement	Loi n°2020-37	65	TEXTE — à reconstrôler
17	Pas d'acte de décès sans déclaration	—	Loi n°2020-37	66	TEXTE — à reconstrôler
18	Audit de décès obligatoire	Établissement	Loi n°2020-37	67	TEXTE
19	Rapport mensuel des audits de décès	Établissement	Loi n°2020-37	68	TEXTE
20	Sanction de la faute médicale	Praticien	Loi n°2020-37	75	TEXTE
21	Responsabilité civile de l'établissement	Établissement	Loi n°2020-37	76	TEXTE
22	Obligation d'assurance RC	Établissement	Loi n°2020-37	77	TEXTE
23	Modification de 36 articles de la loi 2020-37	—	Loi n°2022-17 du 19/10/2022	1er	TEXTE
24	Définition de l'audit de décès, de la	—	Loi n°2022-17	1er (nouveau)	TEXTE

#	Droit ou obligation	Titulaire	Texte	Article	Fiabilité
	déclaration obligatoire, de l'équité en santé				
25	Monopole pharmaceutique (préparation, importation, exportation, distribution)	Pharmacien	Loi n°2021-03 du 01/02/2021	6	TEXTE
26	Exceptions au monopole	Établissements agréés, vétérinaires	Loi n°2021-03	7	TEXTE
27	Dispensation réservée aux établissements habilités	Pharmacien	Loi n°2021-03	17	TEXTE
28	Approvisionnement des officines privées via grossistes-répartiteurs	Officine	Loi n°2021-03	41	TEXTE
29	Médicament non séparable des soins dans les établissements privés	Établissement privé	Loi n°2021-03	72	TEXTE
30	Approvisionnement des pharmacies publiques via centrales publiques	Établissement public	Loi n°2021-03	73	TEXTE
31	Interdiction de la vente hors des lieux autorisés — 1 à 5 ans + 500 000 à 2 000 000 FCFA	Tous	Loi n°2021-03	90	TEXTE
32	Sanctions pour fausses	Tous	Loi n°2021-03	91-95	TEXTE

#	Droit ou obligation	Titulaire	Texte	Article	Fiabilité
	déclarations				
33	Données de santé = données sensibles ; définition du consentement	—	Code du numérique (L. 2017-20 mod. L. 2020-35)	1er	TEXTE
34	Régime particulier des données de santé — autorisation préalable APDP	Responsable de traitement	Code du numérique	394	TEXTE sous réserve
35	Formalités préalables auprès de l'APDP, y compris traitements non automatisés	Responsable de traitement	Code du numérique	405, 407, 410	TEXTE sous réserve
36	Registre des traitements	Responsable de traitement	Code du numérique	435	TEXTE sous réserve
37	Pyramide sanitaire à trois niveaux	—	Décret n°2022-148	3	TEXTE
38	Structures de premier contact et paquet minimum de soins	—	Décret n°2022-148	11	TEXTE
39	Contenu de l'offre d'un hôpital de zone	—	Décret n°2022-148	13	TEXTE
40	Contenu de l'offre d'un CHD	—	Décret n°2022-148	21	TEXTE
41	Certification des établissements, accréditation des praticiens	ARS	Décret n°2019-417	5, 6	TEXTE
42	Commission qualité — instruction des	ARS	Décret n°2019-417	33	TEXTE

#	Droit ou obligation	Titulaire	Texte	Article	Fiabilité
	dossiers de certification				
43	Dispositif de sécurité des patients — 5 domaines, normes et critères	Établissements publics et privés	Décret n°2025-481 du 23/07/2025	non vérifié	TEXTE (existence) / PRATIQUE (contenu)
44	Le secret professionnel s'impose à tout médecin	Médecin	Ord. n°1973-14	7	TEXTE
45	Interdiction de la publicité et de l'exercice commercial	Médecin	Ord. n°1973-14	11	TEXTE
46	Interdiction de la dichotomie, des commissions et du partage d'honoraires	Médecin	Ord. n°1973-14	18 (2°, 4°, 5°)	TEXTE
47	Interdiction d'exercer dans des locaux commerciaux vendant des médicaments	Médecin	Ord. n°1973-14	20	TEXTE
48	Révélation du pronostic fatal à la famille, sauf refus du patient	Médecin	Ord. n°1973-14	33	TEXTE
49	Continuité des soins en cas de retrait	Médecin	Ord. n°1973-14	35	TEXTE
50	16 droits et 7 devoirs des patients	Patient	Charte des droits et devoirs des patients, 23/09/2025	—	TEXTE (existence) / liste incomplète

Lacunes assumées

Sujet	Statut
Contenu des 35 articles modifiés par la loi n°2022-17	Non obtenu — priorité 1
Texte intégral du décret n°2025-481	Non obtenu — priorité 2
Liste officielle complète des 16 droits et 7 devoirs	Non obtenu — priorité 3
Exercice illégal de la médecine — articles du Code pénal (loi n°2018-16)	Non localisé
Actes et compétences des infirmiers et sages-femmes au Bénin	Non trouvé
Régime du transport de médicaments par un tiers	Non trouvé — silence des textes
Arrêt des prestations et sort des dépenses engagées en cas de décès	Non trouvé — vide procédural
Régime de la personne de confiance (désignation, étendue)	Non trouvé
Contenu du décret n°2023-327 (AMO) et panier de soins	Non obtenu
Traitement des plaintes des usagers par l'ARS	Non établi
Régime CIMA applicable à un abonnement de services d'accompagnement	Non vérifié

ANNEXE C — PROBLÈME / CAUSE POSSIBLE / SOLUTION / INTERVENTION DU FACILITATEUR

Problème	Cause dominante probable	Solution structurelle	Intervention du facilitateur	Limite
Absence d'information à l'admission	Organisationnelle (1)	Fiche d'accueil standardisée par parcours	Concevoir la fiche pour l'établissement ; la remettre et l'expliquer	Ne rien ajouter au contenu médical
Langage médical incompris	Communication (3)	Formation à la communication ; supports en langues nationales	Reformuler la question du patient ; vérifier la compréhension ; renvoyer au soignant	Ne jamais reformuler la réponse médicale
Aucun interlocuteur identifié	Organisationnelle (1)	Référent désigné par service	Identifier et nommer le bon	Ne pas devenir cet interlocuteur

Problème	Cause dominante probable	Solution structurelle	Intervention du facilitateur	Limite
			interlocuteur	
Mauvaise orientation dans la pyramide	Communication (3) + incompréhension (8)	Signalétique, information communautaire	Orienter selon le décret 2022-148	Ne pas orienter selon un motif clinique
Attente excessive	Organisationnelle (1) + ressources (5)	Réorganisation des flux	Préparer les pièces à l'avance ; informer sur les horaires réels	Ne pas faire passer devant
Déplacement inutile	Organisationnelle (1)	Confirmation préalable systématique	Vérifier la disponibilité avant le déplacement	—
Rupture de stock hospitalière	Ressources (5) — chaîne publique, art. 73	Renforcement des centrales d'achat	Réduire le temps de recherche	Ne pas acheter, ne pas stocker, ne pas dispenser
Médicament introuvable	Ressources (5)	Système d'information sur les disponibilités	Recherche téléphonique, information plurielle	Voir 7.4 — zone à haut risque
Résultat d'examen qui ne revient pas	Communication (3)	Circuit de retour tracé	Garantir la boucle T6→T7	Ne pas ouvrir, ne pas lire, ne pas interpréter
Prestation payée devenue sans objet	Organisationnelle (1)	Procédure d'arrêt liée au changement de statut	Relevé daté des démarches ; alerte factuelle	Ne jamais qualifier d'escroquerie
Démarche poursuivie après un décès	Organisationnelle (1) — vide procédural	Procédure de synchronisation entre services	Signalement factuel sur mandat écrit ; demande de régularisation	Attendre l'annonce médicale
Ordonnance incomprise	Incompréhension (8)	Ordonnance lisible ; conseil pharmaceutique	Lire littéralement ce qui est écrit ; renvoyer au pharmacien	Ne pas expliquer l'indication
Résultat incompris	Incompréhension (8)	Consultation de restitution	Aucune — renvoi au prescripteur	Interdiction absolue
Absence de famille	Contexte social	Bénévolat, service social hospitalier	Présence — cœur de l'offre diaspora	Ne pas se substituer à la décision familiale
Communication en maternité	Communication (3)	Protocole d'information des familles	Information administrative, gratuité de la	Protocole renforcé ; jamais en salle sans accord

Problème	Cause dominante probable	Solution structurelle	Intervention du facilitateur	Limite
			césarienne	
Communication en urgence	Ressources (5) + organisation (1)	Poste d'information dédié	Très limité — informer, ne pas ralentir	Ne jamais gêner une équipe en action
Communication lors d'un décès	Organisationnelle (1)	Protocole d'annonce	Uniquement après l'annonce médicale	Interdiction d'annoncer
Atteinte à la confidentialité	Organisationnelle (1)	Formation, aménagement des espaces	Sensibiliser ; ne rien répéter	Vous êtes vous-même un risque
Données personnelles	Réglementaire (4)	Conformité APDP	Minimiser radicalement	Ne pas constituer de base médicale
Incapacité de payer	Ressources (5)	AMO, dispositif social hospitalier	Navigation AMO et gratuités	Ne pas avancer d'argent
Facture incomprise ou contestée	Communication (3)	Facturation lisible	Aider à lire ; poser des questions factuelles	Ne pas accuser de surfacturation

ANNEXE D — VERT / ORANGE / ROUGE

● VERT — sans condition particulière

Expliquer l'organisation et les circuits · Orienter dans la pyramide sanitaire · Aider à préparer les questions · Vérifier la compréhension et renvoyer au soignant · Traduire en langues nationales avec l'accord du professionnel · Accompagner physiquement dans les déplacements internes · Suivre les démarches administratives · Rappeler les rendez-vous · Informer sur les tarifs affichés · Informer sur les dispositifs de gratuité (césarienne) et sur l'AMO · Aider à lire une facture · Vérifier la disponibilité d'un examen avant déplacement · Diffuser la Charte des droits et devoirs des patients · Informer de l'existence du recours de l'article 8 et de son délai · Alerter un soignant · Produire des supports d'information pour un établissement · Recueillir l'expérience patient pour un établissement · Tenir un relevé administratif et financier des démarches engagées

● ORANGE — sous conditions cumulatives

Activité	Conditions
Présence en établissement	Convention écrite, badge, périmètre, référent
Lecture littérale d'une ordonnance	Aucun commentaire, renvoi systématique au pharmacien, formation, contrôle
Manipulation de documents médicaux	Consentement écrit du patient, autorisation APDP, aucune conservation, enveloppe close
Communication d'informations à un proche	Accord exprès et tracé du patient

Activité	Conditions
Recherche de disponibilité d'un médicament	Aucune contrepartie de l'officine, liste plurielle, traçabilité
Réservation d'un médicament	Au nom du patient, facture au nom du patient
Transport d'un médicament acheté par la famille	Ne pas lancer au démarrage. Sinon : montage complet de la partie 7.4 + avis d'avocat + position ABMed
Accompagnement d'une démarche de plainte	Information procédurale seule, aucune qualification, orientation vers un avocat
Intervention en maternité	Protocole renforcé, accord de la sage-femme responsable
Intervention en contexte de décès	Après l'annonce médicale, sur mandat écrit
Application mobile ou base de données	Autorisation APDP, minimisation, chiffrage, durée définie
Abonnement familial	Vérification du régime CIMA
Prestation pour un assureur	Interdiction contractuelle de toute incitation à limiter les soins

ROUGE — interdit

Diagnostiquer ou évoquer un diagnostic · Prescrire, modifier ou suspendre un traitement · Interpréter un résultat · Conseiller d'arrêter ou de poursuivre un traitement · Évaluer la gravité d'un symptôme · Donner, remettre ou vendre un médicament · Détenir un stock · Prendre une marge sur un médicament · Recevoir une commission d'un acteur de santé · Consentir à la place du patient · Annoncer un décès ou un pronostic fatal · Affirmer qu'il y a eu faute · Représenter une famille devant une juridiction ou un ordre · Constituer un dossier médical · Transmettre une information médicale sans consentement · Garantir un résultat médical · Nommer un professionnel dans une communication commerciale · Installer un point de service dans une pharmacie

ANNEXE E — SOURCES OFFICIELLES CONSULTÉES

Textes législatifs et réglementaires béninois

Texte	Lien
Loi n°2020-37 du 03/02/2021 portant protection de la santé des personnes	https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2020-37/
Loi n°2022-17 du 19/10/2022 portant modification de la loi n°2020-37	https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2022-17/
Loi n°2021-03 du 01/02/2021 portant organisation des activités pharmaceutiques	https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2021-03/
Loi n°2017-20 du 20/04/2018 portant Code du numérique	https://www.afapdp.org/wp-content/uploads/2018/06/Benin-Loi-2017-20-Portant-code-du-

Texte	Lien
	numerique-en-Republique-du-Benin.pdf
Loi n°2020-35 du 06/01/2021 modifiant le Code du numérique	https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2020-35/
Décret n°2025-481 du 23/07/2025 — dispositif pour la sécurité des patients	https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2025-481/
Décret n°2023-327 du 21/06/2023 — assurance maladie obligatoire	https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2023-327/
Décret n°2022-148 — organisation de la pyramide sanitaire	https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2022-148/download
Décret n°2019-417 du 25/09/2019 — création de l'ARS	https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2019-417/
Ordonnance n°1973-14 du 08/02/1973 — code de déontologie médicale	https://sgg.gouv.bj/doc/ordonnance-1973-14/
Code pénal — loi n°2018-16	https://assemblee-nationale.bj/wp-content/uploads/2020/03/le-nouveau-code-penal-2018.pdf
Portail du Secrétariat général du Gouvernement	https://sgg.gouv.bj/
Journal Officiel du Bénin	https://journalofficiel.gouv.bj/
Collection de textes de lois de l'Assemblée nationale	https://documentation-anbenin.org/
NATLEX / OIT — Bénin, loi n°2022-17	https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=113934

Institutions

Institution	Lien
Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS)	https://ars.presidence.bj/
Ministère de la Santé	https://sante.gouv.bj/
Agence Béninoise du Médicament (ABMed)	https://abmed.bj/presentation
Portail du Gouvernement — dispositif sécurité des patients	https://www.gouv.bj/article/2585/
Portail du Gouvernement — déploiement ARS Ouémé/Plateau	https://www.gouv.bj/article/2802/
Portail national des services publics	https://service-public.bj/
APIEx — formes d'entreprises et formalités	https://apiex.bj/vous-accompagner/creer-son-entreprise-2/les-formes-dentreprises-et-formalites-de-creation/
Ordre National des Médecins du Bénin	https://ordremedecinsbenin.bj/

Institution	Lien
PSSP Bénin — sécurité des patients	https://psspbenin.org/

Charte des droits et devoirs des patients

Source	Lien
Amnesty International Bénin — page de la charte	https://www.amnestybenin.org/charte-sur-les-droits-et-devoirs-des-patients-au-benin/
Amnesty International Bénin — lancement	https://www.amnestybenin.org/sante-au-benin-lancement-de-la-charte-des-droits-et-devoirs-des-patients/
La Nation — lancement de la charte	https://lanation.bj/actualites/regulation-du-secteur-de-la-sante-la-charte-des-droits-et-devoirs-des-patients-lancee
Matin Libre — mise en place de la charte	https://matinlibre.com/2025/09/24/droits-et-devoirs-des-patients-au-benin-une-charte-desormais-mise-en-place/

Presse et sources secondaires sur le décret n°2025-481

Source	Lien
Le Matinal — nouvelles exigences au 1er janvier 2026	https://lematinal.bj/qualite-de-soins-et-securite-des-patients-au-benin-de-nouvelles-exigences-des-le-1er-janvier-2026/
La Nation — un dispositif pour sécuriser les patients	https://lanation.bj/actualites/hopitaux-et-centres-de-sante-un-dispositif-pour-securiser-les-patients
La Nouvelle Tribune — Conseil des ministres	https://lanouvelletribune.info/2025/07/conseil-des-ministres-au-benin-reglementation-du-dispositif-pour-la-securite-des-patients/

Sources académiques et professionnelles

Source	Lien
Déterminants de l'incapacité des patients à payer les soins dans un hôpital de référence du sud Bénin, 2023 — Revue Française d'Économie et de Gestion	https://www.revuefreg.fr/index.php/home/article/view/2778
Qualité perçue des soins et satisfaction des patients des hôpitaux publics au Bénin	https://zenodo.org/records/10207443
Évaluation de la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne au Bénin — Santé Publique	https:// Cairn.info/revue-sante-publique-2013-4-page-507.html
Le médecin face aux exigences du livre 5 du Code du	https://360conseils.com/le-medecin-face-aux-

Source	Lien
numérique	exigences-du-livre-5eme-du-code-du-numerique/
APDP — fiche pratique de mise en conformité	https://archive.apdp.bj/wp-content/uploads/2021/11/Fiche.Pratique.Mise-en-conformite_Pt_OK_Validee.pdf
LEEM Afrique — réglementation pharmaceutique au Bénin	https://www.leemafrique.org/fr/reglementation-pharmaceutique-au-benin.asp
OMS — ordonnance n°73-14, code de déontologie médicale	https://extranet.who.int/cpcd/health-legislation/ordonnance-no-73-14-du-8-fevrier-1973-instituant-un-code-de-deontologie-medicale

Note finale sur la fiabilité

Cette étude a été construite à partir de sources officielles béninoises accessibles en ligne, lues par extraction automatique. Trois documents essentiels n'ont pas pu être lus intégralement : la loi n°2022-17, le décret n°2025-481 et la Charte officielle. Les affirmations qui en dépendent sont signalées comme telles.

Aucune affirmation de ce document ne doit être portée dans un contrat, un business plan destiné à des investisseurs, ou une présentation institutionnelle sans avoir été recoupée avec le Journal Officiel et validée par un avocat inscrit au barreau du Bénin.

Cette étude ne constitue pas un avis juridique.

PARTIE II — LE PÉRIMÈTRE DÉFENDABLE

Le cœur du dossier : la définition du produit. Le problème redéfini, la fonction, l'objet central, la frontière, les trois offres, le plan et les signaux d'arrêt.

Point de départ — Section 1.1 de l'étude : « *Oui, il existe au Bénin un problème réel. Non, ce n'est probablement pas exactement celui que vous pensez avoir identifié. Et la partie de ce problème qu'un service privé peut légalement traiter est plus étroite — mais aussi plus défendable — que le concept large de facilitateur du parcours patient.* »

Objet de cette note — Définir précisément cette partie plus étroite : ce que c'est, pour qui, avec quel livrable, à quelles conditions juridiques, et comment le prouver en 90 jours.

Statut — Document de travail. S'appuie sur l'étude juridique du 22 août 2026 et n'en répète pas les sources. Ne constitue pas un avis juridique.

1. LE PROBLÈME, REDÉFINI EN UNE PHRASE

1.1 La formulation

Dans le parcours de soins béninois, chaque acteur fait correctement son travail, et personne n'est chargé de relier ces travaux entre eux. Ce chaînage est assuré par défaut par la famille — c'est-à-dire par la personne la moins équipée pour le faire, et qui paie pour le privilège.

Le médecin prescrit. Le laboratoire analyse. La caisse encaisse. Le pharmacien dispense. L'infirmier administre. Chacun de ces actes peut être irréprochable, et le parcours dans son ensemble rester chaotique. Ce qui manque n'est pas la compétence : c'est le **chaînage**.

1.2 Pourquoi cette formulation est meilleure que la vôtre

Votre formulation initiale — *les familles ne comprennent pas, se perdent, perdent du temps et de l'argent* — est vraie mais elle désigne un symptôme, et elle a trois défauts pratiques.

Elle accuse implicitement. « Les familles ne comprennent pas » suggère que quelqu'un n'explique pas. Dit à un soignant, c'est un reproche. Dit à une direction, c'est une mise en cause. Vous fermez les portes avant d'avoir parlé.

Elle ne désigne aucun responsable, donc aucun payeur. Un problème de compréhension n'appartient à personne. Un problème de chaînage appartient à l'organisation. Les organisations ont des budgets ; les symptômes n'en ont pas.

Elle vise une capacité, pas un fait. « Comprendre » est difficile à mesurer. « Le résultat est-il revenu au prescripteur en moins de 24 heures ? » se mesure avec une montre.

1.3 Les trois conséquences, toutes mesurables

La famille transporte des documents qu'elle ne peut pas lire, entre des gens qui ne se parlent pas. Elle est le seul lien physique entre le prescripteur et le plateau technique. Si elle se trompe de service, si elle range le papier, si elle ne sait pas que le résultat est prêt — la chaîne casse, sans que personne ne s'en aperçoive.

La famille arbitre l'ordre des dépenses sans aucune information clinique. Face à une ordonnance de quatre lignes et à un budget qui n'en couvre que deux, quelqu'un décide. Ce quelqu'un est presque toujours la famille, et elle

décide sans savoir ce qui est urgent. C'est le point du parcours où une décision non médicale produit un effet médical.

La famille est le seul acteur qui voit le parcours en entier — et le seul que personne n'interroge. Le médecin voit sa consultation. Le laboratoire voit son prélèvement. La caisse voit son encaissement. La famille voit tout, de l'arrivée à la sortie. Cette information existe, elle est intégrale, et elle n'est collectée nulle part.

Ce troisième point est le plus important pour vous, parce qu'il contient à la fois le problème **et** votre porte d'entrée institutionnelle : depuis le décret n°2025-481, les établissements ont l'obligation d'impliquer le patient et la communauté. Ils ont donc besoin d'une information qu'ils ne collectent pas et que la famille détient.

1.4 Le retournement commercial

Voici ce qui change tout, et qui ne figurait pas dans votre document de départ :

La famille fait déjà ce travail. Gratuitement, mal, et en payant les conséquences de le faire mal.

Vous ne vendez donc pas un service nouveau à des gens qui n'en avaient pas besoin. Vous vendez la **professionnalisation d'un travail déjà effectué**, dont le coût réel est aujourd'hui payé en trajets inutiles, en journées de travail perdues, en examens refaits, en médicaments achetés pour rien.

La phrase commerciale n'est pas « payez-nous pour vous aider ». Elle est :

« Vous dépensez déjà cet argent. Vous ne le voyez pas parce qu'il part en petits morceaux. »

C'est vérifiable, c'est chiffrable, et c'est la seule proposition de valeur qui tienne face à une capacité de paiement faible. Toute la partie 7 de cette note sert à construire ce chiffre.

2. CE QUE VOUS ABANDONNEZ

Un périmètre plus étroit se définit d'abord par ce qui en sort. Quatre abandons, et ce que chacun vous rapporte.

Abandonné	Ce que ça retire	Ce que ça rapporte
Le concept large de « facilitateur du parcours patient » et ses dix promesses	L'impossibilité d'exécuter, de mesurer et de tarifier	Une seule promesse, donc un seul indicateur, donc une preuve possible
« Aider à comprendre ce que dit le médecin » comme promesse principale	Le risque quotidien de dérive vers l'exercice illégal	Une frontière qu'un accompagnateur de 24 ans peut tenir sans jugement personnel
La recherche et le transport de médicaments au lancement	Un risque pénal non chiffré (1 à 5 ans, art. 90 de la loi n°2021-03)	La possibilité de parler à un pharmacien sans le mettre sur la défensive
Le grand public comme canal principal	Une bataille contre une capacité de paiement documentée à 14,74 %	Deux payeurs qui ont un budget et une échéance

Ce que ces abandons ont en commun : chacun supprime une conversation difficile. Sans le médicament, le pharmacien devient un allié plutôt qu'un adversaire. Sans la promesse de compréhension médicale, le médecin cesse de vous voir comme un concurrent. Sans le grand public, vous cessez de vendre à des gens qui arbitrent entre vous et un repas.

Ce n'est pas un repli. C'est le passage d'une idée à un produit.

Une note personnelle, puisque vous avez demandé une analyse critique et non une validation : la partie que vous abandonnez est probablement celle qui vous tient le plus à cœur, parce que c'est celle qui répond à ce que vous avez vécu. Gardez-la comme boussole — elle vous dit pourquoi vous faites ça. Ne la gardez pas comme produit.

3. LA FONCTION : OPÉRATEUR DE CONTINUITÉ

3.1 Le nom, et pourquoi il compte

Abandonnez le mot « facilitateur ». Trois raisons.

Il est vague. Un facilitateur peut être n'importe quoi. Un directeur d'hôpital qui entend « facilitateur » doit deviner ce que vous faites, et il devinera mal.

Dans un contexte de santé, il sonne comme de l'intermédiation. Or l'intermédiation est précisément ce que la déontologie des professions de santé prohibe — commissions pour orientation de patients, partage d'honoraires, compérage (art. 18 de l'ordonnance n°1973-14). Vous porteriez, dès votre carte de visite, le mot qui déclenche la méfiance.

Il vous place à côté du système au lieu de dedans. « Continuité », au contraire, est un mot que le droit béninois emploie déjà : continuité des soins dans la loi n°2020-37, obligation de continuité en cas de retrait du médecin (art. 35 de l'ordonnance de 1973), droit à la continuité des soins dans la Charte de 2025. En reprenant le vocabulaire du système, vous devenez lisible par lui.

Nom de la fonction : opérateur de continuité du parcours. Elle ne concurrence personne : elle nomme un trou dans l'organigramme.

3.2 La définition, en une phrase

Nous faisons circuler l'information et les documents entre les acteurs d'un parcours de soins, et nous tenons la famille informée de l'état, du coût et du reste à faire — sans jamais toucher au contenu médical.

Cette phrase doit figurer en tête de vos statuts, de vos CGV, de votre business plan et de votre première diapositive. Elle est votre définition de produit **et** votre défense juridique. Ce sont les mêmes mots.

3.3 Les trois verbes, et rien d'autre

Verbe	Ce que ça veut dire	Ce que ça ne veut pas dire
Acheminer	Porter un document, une question ou une information d'un point à un autre, de façon tracée	Lire, interpréter, commenter, conserver
Tenir à jour	Maintenir un relevé daté de l'état des démarches, des paiements et du reste à faire	Constituer un dossier médical
Alerter	Signaler à un soignant un fait observable, ou signaler à la famille une échéance	Évaluer une gravité, poser un diagnostic, qualifier une faute

Si une tâche envisagée n'est ni acheminer, ni tenir à jour, ni alerter — elle sort du périmètre. Ce test à trois branches est plus simple à appliquer sur le terrain que n'importe quelle liste d'interdits, et il donne le même résultat.

4. L'OBJET CENTRAL : LE RELEVÉ DE PARCOURS

4.1 Pourquoi un objet, et pas seulement un service

Un service humain est invisible. On ne peut ni le montrer, ni le comparer, ni prouver qu'il a eu lieu. Une entreprise de services qui démarre sans objet tangible se retrouve à facturer de la présence — c'est-à-dire la chose la plus difficile à vendre et la plus facile à couper.

Il vous faut donc un **livrable physique**. Ce sera le relevé de parcours.

4.2 Ce que c'est

Un document simple, daté, tenu à jour par vous, **propriété de la famille**, qui répond à quatre questions à tout moment :

1. Où en est-on ?
2. Qu'est-ce qui a été payé ?
3. Qu'est-ce qui reste à faire ?
4. Où sont les papiers ?

Colonnes : date et heure · étape · lieu ou service · ce qui a été demandé · montant payé · statut (à faire / en cours / fait / annulé / **sans objet**) · où se trouve le document · prochaine échéance.

Le statut « **sans objet** » est là exprès. C'est la case qui résout votre cas critique : quand l'état du patient change — amélioration, aggravation, décès — une démarche engagée peut cesser d'avoir un sens. Aujourd'hui, aucun circuit ne le signale. Une ligne cochée « sans objet », datée, avec le montant en face, transforme une injustice diffuse en une demande de régularisation précise et polie.

4.3 Ce qu'il apporte, à chacun

Pour	Ce que ça change
La famille	Elle cesse de tout garder en tête. Elle sait ce qu'elle a payé. Elle a une trace.
Le soignant	Il reçoit une famille qui sait où elle en est, au lieu d'une famille qui redemande.
L'établissement	Il dispose, pour la première fois, d'une description factuelle de parcours réels — matière première du domaine « implication du patient » du décret n°2025-481.
Vous	Vous avez une preuve de valeur chiffrée à la fin de chaque épisode, et un objet à montrer avant de commencer.

4.4 Une correction importante à l'étude

Dans l'étude, j'ai écrit qu'il fallait « concevoir le service pour détenir le moins de données possible », en laissant entendre qu'un relevé purement administratif pourrait rester hors du régime des données de santé. **En y regardant de plus près, c'est trop optimiste et je le corrige ici.**

L'article 1er du Code du numérique définit les données concernant la santé comme *toute information concernant l'état physique et mental d'une personne, y compris les données génétiques et la prestation de services de soins*. Une ligne indiquant qu'une personne nommée a subi tel examen dans tel service à telle date **est** une donnée de santé au sens de cette définition. La minimisation ne vous fait pas sortir du régime de l'article 394.

Conséquence, sans ambiguïté : l'autorisation préalable de l'APDP est un prérequis de lancement, pas une mise en conformité ultérieure.

Ce que la minimisation vous apporte réellement, et c'est déjà beaucoup : un dossier APDP simple à instruire, un préjudice faible en cas de fuite, une suppression facile, et l'impossibilité pour un tiers de reconstituer un diagnostic à partir de vos écrits.

4.5 La décision de conception qui en découle

Version 1 : papier. Un seul exemplaire. Détenu par la famille. Aucune copie conservée par vous.

Vous remplissez, la famille garde. Vous ne constituez aucune base. À la fin de l'épisode, vous notez pour vous **trois chiffres agrégés et anonymes** — nombre de trajets, montant total, nombre de lignes « sans objet » — et rien d'autre.

Cette décision a l'air modeste. Elle est stratégique :

- elle rend votre dossier APDP défendable en une page ;
- elle supprime le risque de fuite de masse, qui est le seul risque capable de tuer la marque en une nuit ;
- elle vous oblige à prouver la valeur du service avant d'investir dans un outil ;
- et elle vous distingue immédiatement de toute application de santé qui aspire des données.

Le numérique viendra si — et seulement si — le terrain démontre que le papier ne suffit pas. Pas avant l'autorisation APDP. Jamais avant.

5. LA FRONTIÈRE, RENDUE OPÉRATIONNELLE

La règle « circuit, jamais contenu » est juste, mais elle est philosophique. Sur le terrain, à 22 heures, face à une mère qui pleure, un accompagnateur de 24 ans a besoin d'un test qu'il peut appliquer en deux secondes.

5.1 Le test des deux secondes

« Ma phrase resterait-elle vraie si je ne savais rien de la maladie de ce patient ? »

Oui → c'est du circuit → autorisé. Non → c'est du contenu → interdit.

Vérification sur des cas réels :

Phrase	Reste vraie sans connaître la maladie ?	Verdict
« Votre résultat est prêt, je le porte au Dr X. »	Oui	Autorisé
« Ce résultat est normal. »	Non	Interdit
« Au Bénin, la césarienne est prise en charge par l'État. »	Oui	Autorisé
« Achetez d'abord ce médicament-là, c'est le plus urgent. »	Non	Interdit

Phrase	Reste vraie sans connaître la maladie ?	Verdict
« Cet examen se fait au service X, il coûte tant, ils ouvrent à 8 h. »	Oui	Autorisé
« Ce n'est pas grave, rassurez-vous. »	Non	Interdit
« Vous avez payé ceci le 12, ce n'est pas encore fait. »	Oui	Autorisé
« Le médecin aurait dû demander cet examen plus tôt. »	Non	Interdit

Le test fonctionne parce qu'il ne demande aucun jugement clinique pour être appliqué — il demande seulement de vérifier si la phrase dépend d'un savoir médical. C'est exactement la compétence que vos accompagnateurs auront.

5.2 Le second test, pour les cas restants

« Est-ce que je réponds, ou est-ce que je fais poser la question ? »

Faire poser la question est toujours autorisé. Répondre à la place ne l'est jamais.

5.3 Les huit phrases qu'on dit

1. « Votre résultat est prêt. Je le porte au Dr X et je vous confirme quand il l'aura reçu. »
2. « Je ne peux pas vous dire ce que ce résultat signifie — ce n'est pas mon métier et je n'en ai pas le droit. Allons ensemble poser la question au médecin. »
3. « Voici ce que le médecin a écrit. Pour savoir pourquoi, c'est à lui qu'il faut demander. Je peux vous aider à préparer la question. »
4. « Au Bénin, la césarienne est prise en charge par l'État. Demandons au service ce qui reste à votre charge. »
5. « Cet examen se fait au service X, il ouvre à telle heure et coûte tant. J'appelle pour vérifier qu'ils peuvent le faire aujourd'hui avant qu'on se déplace. »
6. « Vous avez payé ceci le 12, et ce n'est pas encore fait. Voulez-vous que je demande au service où ça en est ? »
7. *(au soignant)* « La famille me dit ne pas avoir compris ce point. Pouvez-vous le reprendre avec eux quand vous aurez un moment ? »
8. *(au soignant, en urgence)* « Madame X respire vite et ne répond plus depuis dix minutes. » — des faits observables, jamais une interprétation.

5.4 Les huit phrases qu'on ne dit jamais

1. « Ce n'est rien. » / « C'est grave. »
2. « Ce résultat est normal. »
3. « À votre place, je... »
4. « Achetez ce médicament-là en premier. »
5. « Le médecin aurait dû... »
6. « C'est une erreur. » / « On vous a arnaqués. »
7. « Il est parti. » — l'annonce d'un décès appartient au médecin, sans exception.

8. « Vous pouvez arrêter ce traitement. »

5.5 Le test d’affichage

Pour les cas que les deux premiers tests ne tranchent pas :

« Est-ce que je pourrais écrire cette phrase sur une affiche dans le couloir de l’hôpital, sans qu’un médecin s’y oppose ? »

Si oui, c’est du circuit. Si vous hésitez, c’est non.

6. LES TROIS OFFRES

Une seule promesse par offre. Un seul livrable. Un seul indicateur.

6.1 Offre A — La boucle de l’examen

C’est votre offre d’entrée. La plus simple à expliquer, la plus facile à mesurer, la moins risquée juridiquement.

Promesse	Votre résultat revient au médecin qui l’a demandé, dans le délai utile.
Livrable	Acheminement tracé sous enveloppe close + confirmation écrite de réception par le prescripteur.
Qui paie	La famille présente, à l’acte. Ou l’établissement, au forfait.
Preuve de valeur	Délai prescription → résultat chez le prescripteur, mesuré avant et après.
Risque juridique	Faible. Enveloppe jamais ouverte, aucune conservation, consentement écrit du patient. Classée Orange à l’annexe D de l’étude, uniquement pour la manipulation du document.
Ce qui la rend crédible	Elle produit un effet médical réel — une consultation qui n’est pas reportée — sans qu’aucun acte médical soit posé.
Prérequis	Consentement écrit du patient · autorisation APDP · convention avec l’établissement.

6.2 Offre B — Pack conformité « implication du patient »

C’est votre socle. Le seul segment doté d’un moteur réglementaire daté.

Promesse	Contribuer à votre mise en conformité au domaine « implication du patient et de la communauté » du dispositif de sécurité des patients.
Livrables	Supports d’information par parcours, en français et en langues nationales · diffusion et affichage de la Charte des droits et devoirs des patients · protocole de recueil

	de l'expérience patient et rapport trimestriel · appui à la partie organisationnelle de l'audit de décès et à la production du rapport mensuel.
Qui paie	L'établissement, sur budget qualité ou conformité.
Preuve de valeur	Nombre de critères du référentiel documentés · pièces versées au dossier de certification · évolution des réclamations.
Risque juridique	Faible. Aucun acte de soin, aucune donnée clinique, aucun accès au dossier médical.
Ce qui la rend crédible	L'établissement a une échéance qui ne vient pas de vous. Vous ne vendez pas une idée, vous réduisez un retard.
Prérequis	Obtenir le texte intégral du décret n°2025-481 et le référentiel de normes auprès de l'ARS. Sans le référentiel, vous vendez à l'aveugle.

Avertissement : les cinq domaines, les 21 normes et les 134 critères proviennent de sources institutionnelles secondaires, pas du texte lui-même. Ne construisez pas une offre chiffrée sur ces nombres avant d'avoir le document.

6.3 Offre C — Présence et compte rendu (diaspora)

C'est votre moteur de croissance. Le seul segment B2C où la capacité de paiement n'est pas le facteur limitant.

Promesse	Quelqu'un de confiance auprès de votre parent, et un compte rendu écrit.
Livrables	Visite à fréquence convenue · compte rendu écrit non médical sous 24 h · relevé de parcours tenu à jour · coordination administrative · alerte immédiate en cas d'événement, avec renvoi systématique au soignant pour tout ce qui est clinique.
Qui paie	Le membre de la famille à l'étranger, en devise, par abonnement mensuel.
Preuve de valeur	Le compte rendu lui-même, plus les dépenses évitées figurant au relevé.
Risque juridique	Moyen — le plus élevé des trois. Consentement écrit du patient obligatoire et distinct de celui du payeur. Régime des transferts internationaux de données à vérifier. Régime CIMA à vérifier si l'abonnement ressemble à une couverture.
Ce qui la rend crédible	Ce que ce client achète n'est pas de la compréhension médicale — c'est une présence et une trace. C'est exactement ce que vous pouvez livrer sans franchir aucune ligne.
Prérequis	Contrat à double signature · autorisation APDP

	incluant le transfert · vérification CIMA · script strict du compte rendu.
--	--

La règle qui protège cette offre : le compte rendu décrit ce qui a été **fait**, jamais ce que le patient **a**. « Consultation à 9 h 15, examen prescrit, payé, réalisé à 14 h, résultat remis au Dr X à 16 h. Votre mère a mangé et a dormi. » Pas un mot de plus. Si le client à l'étranger veut savoir comment va sa mère médicalement, il appelle le médecin — et vous l'aidez à obtenir ce rendez-vous téléphonique.

6.4 L'ordre de lancement

Ordre	Offre	Pourquoi maintenant
1	A — La boucle de l'examen	La moins chère à tester, la plus rapide à mesurer. C'est votre laboratoire.
2	B — Pack conformité	Cycle de vente long : commencez les rendez-vous dès la semaine 8, même sans produit fini.
3	C — Diaspora	Ne la lancez qu'une fois A rodée : ce client paie pour de la fiabilité, et une erreur en début de vie coûte la réputation du segment entier.

7. LE COÛT CACHÉ : VOTRE ARGUMENT COMMERCIAL

7.1 Pourquoi c'est le cœur du sujet

Face à une capacité de paiement documentée à 14,74 % dans un hôpital de référence du sud du Bénin, aucun argument de confort ne tiendra. Le seul argument qui puisse fonctionner est arithmétique :

Le service se paie avec de l'argent que la famille perd déjà.

Encore faut-il le prouver. Ce chiffre n'existe pas aujourd'hui — c'est le premier livrable de votre enquête terrain.

7.2 La structure de calcul

Coût caché d'un épisode, pour un ménage :

Poste	Comment le mesurer
Trajets évitables	Nombre de déplacements n'ayant donné lieu à aucun acte × coût aller-retour
Journées de travail perdues évitables	Jours d'absence de l'accompagnant imputables à l'attente ou aux allers-retours × revenu journalier
Examens refaits	Nombre × coût unitaire
Médicaments achetés en double, ou achetés puis non utilisés	Montant des produits concernés
Prestations payées devenues sans objet	Montant des lignes « sans objet » du relevé

Poste	Comment le mesurer
Dépenses engagées alors qu'un dispositif de gratuité s'appliquait	Montant payé à tort — la césarienne est le cas d'école
Total	Somme. Ce sont des pertes sèches : rien ne vient en déduction.

Le classeur Excel joint contient ce calcul sous forme de feuille à remplir, avec les formules. **Aucun chiffre n'y est pré-rempli** — les renseigner avant l'enquête reviendrait à fabriquer le résultat que vous cherchez.

7.3 La règle de décision

Si le coût caché moyen mesuré est inférieur à trois fois le prix de votre prestation, il n'y a pas de marché B2C. Point.

Pourquoi trois. En dessous d'un facteur trois, l'économie n'est pas assez visible pour qu'une famille en situation de contrainte financière décide de payer d'avance un bénéfice incertain. Les gens n'arbitrent pas à la marge quand chaque franc compte : ils exigent une évidence.

Ce seuil est un choix de prudence, pas une loi. Retenez-le, écrivez-le, et si vous le déplacez plus tard, faites-le en connaissance de cause plutôt que par optimisme.

7.4 Ce que vous ne devez surtout pas faire

Ne construisez pas ce chiffre à partir de votre expérience personnelle, aussi marquante soit-elle. Un épisode difficile est, par construction, un cas extrême — c'est pour cela qu'il vous a marqué. La moyenne est ailleurs, et c'est la moyenne qui décide de votre entreprise.

Mesurez sur 30 à 50 parcours, dont vous chercherez délibérément à inclure ceux qui se sont bien passés.

8. LES QUATRE CHIFFRES À PRODUIRE

Aucune décision d'investissement, aucun recrutement, aucun dépôt de statuts avant d'avoir ces quatre nombres.

#	Chiffre	Comment	Seuil de décision
1	Coût caché moyen par épisode (FCFA)	30 à 50 parcours suivis, relevé + entretien de sortie	$\geq 3 \times$ le prix envisagé, sinon pas de B2C
2	Délai médian prescription → résultat chez le prescripteur (heures)	Registres, sur 3 établissements	S'il est déjà court, l'offre A n'a pas de marché sur ce site
3	Taux de conversion payant réel (%)	Offre A proposée à 30-50 familles, à prix affiché. On compte ceux qui paient, pas ceux qui disent oui.	À fixer par vous, par écrit, avant de commencer
4	Lettres d'intention d'établissements (nombre)	5 directions sollicitées avec l'offre B	≥ 2 sur 5

Le chiffre 3 est celui que presque tous les porteurs de projet omettent, parce que c'est le seul qui peut faire mal. Une réponse déclarative à « paieriez-vous ? » n'a aucune valeur prédictive : les gens répondent oui par politesse, par sympathie pour vous, ou parce qu'ils imaginent une situation qu'ils ne vivent pas. **Faites payer, vraiment, dès le test.**

9. LE PLAN 90 JOURS

Semaines	Chantier	Livrable attendu
1-2	Sécuriser le socle juridique	Version consolidée de la loi n°2020-37 (post-2022) · consultation d'avocat sur le périmètre · premier contact APDP · demande écrite du référentiel à l'ARS
1-2	Outils	Relevé de parcours imprimé · formulaire de consentement bilingue · code de conduite · fiches de procédure
3-6	Observation	30 à 50 patients traceurs sur 3 sites contrastés (hôpital de zone, CHD, structure de premier contact), avec autorisation écrite des directions
5-8	Entretiens	Direction, médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, patients, accompagnants — grilles fournies en partie 9.3 de l'étude
6-7	Consolidation	Chiffres 1 et 2 produits
7-10	Test de solvabilité	Offre A vendue réellement, à prix affiché, à 30-50 familles → chiffre 3
8-11	Institutionnel	5 rendez-vous de direction avec l'offre B → chiffre 4
12	Décision	Note écrite : go / no-go / pivot, argumentée sur les quatre chiffres

Deux règles pour que ce plan tienne.

Celui qui observe ne doit pas être celui qui vend. Sinon l'observation devient une démonstration, et vous ne mesurez plus rien.

Les rendez-vous établissements commencent en semaine 8, pas en semaine 12. Un cycle de vente hospitalier public se compte en mois : si vous attendez d'avoir un produit fini pour commencer à parler, vous perdrez un trimestre.

10. LES TROIS SIGNAUX D'ARRÊT

Écrivez-les maintenant, pendant que vous êtes lucide et que rien n'est encore engagé. C'est la seule protection existante contre l'attachement à sa propre idée.

Signal 1 — Personne ne paie et personne ne signe. Si le taux de conversion payant réel est inférieur au seuil que vous aurez fixé par écrit **et** qu'aucun établissement ne signe de lettre d'intention sur cinq sollicités : le marché n'existe pas sous cette forme. Arrêtez ou changez de problème.

Signal 2 — Le risque juridique porte sur le cœur, pas sur la périphérie. Si l'avocat conclut à un risque pénal non maîtrisable sur l'acheminement de documents ou sur la tenue du relevé — c'est-à-dire sur le cœur du métier, et non sur le médicament que vous avez déjà écarté : le périmètre défendable n'existe pas. Arrêtez.

Signal 3 — Le coût caché est trop faible. Si le coût caché moyen mesuré est inférieur à trois fois votre prix : pas de B2C. Si, en plus, l'offre B ne trouve pas preneur : arrêtez.

Et un quatrième, plus difficile à entendre. Si vous n'obtenez pas une seule convention écrite en 90 jours, malgré des rendez-vous obtenus et des interlocuteurs polis, ce n'est probablement pas un problème d'exécution commerciale. C'est le signal que le système ne veut pas d'un tiers dans ses murs. Ce serait une information précieuse, et elle mérite d'être entendue plutôt que contournée.

11. LA CHECKLIST AVANT LA PREMIÈRE PRESTATION

Aucune ligne ne peut être sautée. Aucune n'est facultative.

	À obtenir	Auprès de
☐	Version consolidée de la loi n°2020-37 après la loi n°2022-17	SGG / Journal Officiel
☐	Consultation écrite d'un avocat sur le périmètre d'activité	Barreau du Bénin
☐	Autorisation de traitement de données de santé	APDP
☐	Texte intégral du décret n°2025-481 et référentiel de normes	ARS
☐	Charte officielle des droits et devoirs des patients	ARS ou Amnesty International Bénin
☐	Convention écrite avec au moins un établissement	Direction
☐	Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur
☐	CGV : obligation de moyens, exclusion du champ médical, exclusion de l'urgence vitale	Avocat
☐	Contrat type à double signature patient / payeur	Avocat

	À obtenir	Après de
☐	Formulaire de consentement du patient, bilingue et oralisable	—
☐	Code de conduite signé par chaque accompagnateur	—
☐	Fiches de procédure : urgence, danger, décès, accusation, erreur, plainte	—

Si vous n'avez pas les quatre premières lignes, vous n'avez pas de projet — vous avez une intention.

12. LE PITCH EN 90 SECONDES

À un directeur d'hôpital

« Vous avez douze mois pour vous mettre en conformité avec le dispositif de sécurité des patients, et l'un des cinq domaines porte sur l'implication du patient et de la communauté. C'est un domaine où il faut produire des documents et de la donnée d'expérience patient, et je suppose que ce n'est pas ce qui vous manque le moins.

Nous ne touchons à rien de médical. Nous faisons circuler les documents entre vos services, nous tenons un relevé non clinique du parcours des familles, et nous vous rendons l'information qu'elles détiennent et que personne ne collecte.

Je vous propose un pilote de six mois sur un seul service, avec des indicateurs définis avant de commencer et une clause de résiliation immédiate. Si les chiffres sont mauvais, je viendrai vous le dire. »

À un médecin-chef

« Vos patients arriveront en consultation avec leurs documents complets et leurs questions préparées. Nous ne réexpliquons rien : quand une famille n'a pas compris, nous la ramenons vers vous. Nous ne touchons ni au diagnostic, ni à la prescription, ni à l'interprétation — c'est écrit dans nos contrats et dans le code de conduite que chaque accompagnateur signe. »

À un pharmacien

« Nous ne dispensons rien, nous ne stockons rien, nous ne prenons aucune marge et nous n'accepterons jamais de commission d'une officine. Ce n'est pas notre métier et la loi ne nous le permet pas. »

À un membre de la diaspora

« Vous financez les soins de votre mère et vous n'avez aucun moyen de savoir où ça en est. Nous allons la voir, nous nous occupons des démarches, et vous recevez un compte rendu écrit sous vingt-quatre heures — de ce qui a été fait, pas de ce qu'elle a. Pour sa santé, c'est le médecin qu'il faut appeler, et nous pouvons vous aider à obtenir ce rendez-vous. »

À une famille sur place

« Vous allez faire ces trajets, remplir ces papiers et avancer cet argent de toute façon. Nous le faisons avec vous, nous notons tout, et à la fin vous saurez exactement ce que vous avez payé et pourquoi. »

CONCLUSION

Le périmètre défendable tient en quatre décisions :

Un problème — personne n'assure le chaînage entre des acteurs qui font chacun correctement leur travail, et ce chaînage retombe sur la famille.

Une fonction — opérateur de continuité. Acheminer, tenir à jour, alerter. Rien d'autre.

Un objet — le relevé de parcours. Papier, propriété de la famille, aucune copie conservée, autorisation APDP obtenue avant la première ligne écrite.

Trois offres, dans l'ordre — la boucle de l'examen pour apprendre, le pack conformité pour tenir, la diaspora pour croître.

Et un chiffre qui décide de tout le reste : **le coût caché de l'auto-coordination familiale**. S'il est élevé, vous avez une entreprise. S'il est faible, vous avez rendu service à quelqu'un une fois, et c'était déjà bien.

Allez le mesurer.

PARTIE III — LES QUATRE DEMANDES ÉCRITES

Semaines 1 et 2. Trois courriers prêts à signer et un brief de consultation.

Comment utiliser ce document. Quatre courriers et un brief, prêts à signer. Remplacez tous les champs entre crochets [...]. N’inventez aucune adresse : vérifiez-la sur le site de l’institution ou par téléphone avant l’envoi.

Trois règles d’envoi.

Déposez en main propre contre décharge chaque fois que c’est possible, et gardez le double tamponné. Au Bénin comme ailleurs, un courrier déposé avec décharge existe ; un courriel peut toujours n’être jamais arrivé.

Envoyez les quatre la même semaine. Les délais de réponse administratifs se cumulent mal : si vous attendez la réponse de l’un pour envoyer l’autre, vous perdez un mois par étape.

Doublez systématiquement d’un courriel avec le courrier scanné en pièce jointe, et notez la date des deux dans un tableau de suivi. Une relance polie à J+15 est normale et attendue.

COURRIER 1 — Secrétariat général du Gouvernement

Objet : version consolidée de la loi n°2020-37, telle que modifiée par la loi n°2022-17.

C’est la demande la plus importante des quatre. Sans le texte des 36 articles modifiés, tout votre édifice juridique repose sur une version périmée.

[Prénom NOM]

[Adresse complète]

[Téléphone] — [Courriel]

À Monsieur le Secrétaire général du Gouvernement Secrétariat général du Gouvernement [Adresse — à vérifier sur ssg.gouv.bj]

Cotonou, République du Bénin

[Ville], le [date]

Objet : demande de communication de la version consolidée de la loi n°2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes

Monsieur le Secrétaire général,

Je conduis actuellement une étude sur le cadre juridique applicable à l’accompagnement administratif et logistique des patients et de leurs familles dans les établissements de santé de notre pays, en vue de la création d’une entreprise de services dans ce domaine.

Cette étude m’a conduit à consulter la loi n°2020-37 du 3 février 2021 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin, ainsi que la loi n°2022-17 du 19 octobre 2022 qui la modifie. Cette dernière énumère à son article premier trente-six articles modifiés, parmi lesquels les articles 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 45, 65 et 66.

Les versions numériques auxquelles j’ai pu accéder ne m’ont pas permis d’établir le contenu exact de ces articles dans leur rédaction en vigueur.

Je sollicite en conséquence la communication :

1. de la version consolidée de la loi n°2020-37 telle que modifiée par la loi n°2022-17 ;

2. à défaut, du texte intégral de la loi n°2022-17 dans une version lisible ;
3. de l'indication des éventuels textes postérieurs ayant modifié, complété ou abrogé ces dispositions ;
4. le cas échéant, de la référence des numéros du Journal officiel de publication.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément et pour m'acquitter, s'il y a lieu, des frais de reproduction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'expression de ma considération distinguée.

[Signature]

[Prénom NOM]

COURRIER 2 — Autorité de Régulation du Secteur de la Santé

Objet : référentiel du dispositif de sécurité des patients, et Charte des droits et devoirs des patients.

Ce courrier a un double objet. Il vous procure le cahier des charges de votre offre destinée aux établissements, et il vous fait exister auprès du régulateur — ce qui vaut, à terme, plus que le document lui-même.

Ne demandez pas d'autorisation dans ce courrier. Vous n'en avez pas besoin à ce stade, et une demande d'autorisation appelle une réponse qui peut être négative par prudence. Informez, sollicitez de la documentation, proposez un échange. C'est tout.

[Prénom NOM]

[Adresse complète]

[Téléphone] — [Courriel]

À Monsieur le Président de l'Autorité de Régulation du Secteur de la Santé [Adresse — à vérifier sur ars.presidence.bj]

Cotonou, République du Bénin

[Ville], le [date]

Objet : demande de documentation relative au dispositif pour la sécurité des patients et à la Charte des droits et devoirs des patients

Monsieur le Président,

Je conduis une étude sur les conditions dans lesquelles un opérateur privé pourrait contribuer, dans le strict respect du droit en vigueur et sans exercer aucune activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique, à l'information administrative des patients et de leurs familles et à la circulation des documents au sein des établissements de santé.

Mes travaux m'ont conduit au décret n°2025-481 du 23 juillet 2025 portant réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin, et à la Charte des droits et devoirs des patients lancée le 23 septembre 2025. Le domaine relatif à l'implication du patient et de la communauté retient particulièrement mon attention.

Je sollicite à cette fin la communication des documents suivants, s'ils sont publics :

1. le texte intégral du décret n°2025-481 du 23 juillet 2025 ;
2. le référentiel de normes et de critères applicable aux établissements hospitaliers et aux structures de premier contact ;
3. la Charte des droits et devoirs des patients dans sa version officielle ;
4. tout guide, manuel ou support méthodologique que votre Autorité met à disposition des établissements pour leur mise en conformité ;

5. le calendrier de mise en conformité et les modalités d'évaluation.

Je souhaite par ailleurs porter à votre connaissance l'existence de mon projet et son périmètre, que je définis comme suit :

L'activité envisagée consiste à faire circuler l'information et les documents entre les acteurs d'un parcours de soins, et à tenir les familles informées de l'état d'avancement des démarches, de leur coût et de ce qui reste à accomplir. Elle exclut expressément tout diagnostic, toute prescription, toute interprétation de résultat, toute dispensation de médicament et toute substitution à un professionnel de santé réglementé.

Je serais honoré de pouvoir vous exposer ce projet, ou de le présenter à la personne que vous voudrez bien désigner, afin de m'assurer qu'il s'inscrit dans les orientations de votre Autorité et de recueillir vos observations avant tout démarrage.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

[Signature]

[Prénom NOM]

COURRIER 3 — Autorité de Protection des Données à caractère Personnel

Objet : demande de conseil préalable et engagement de la démarche d'autorisation.

Deux remarques avant de l'envoyer.

Ne dites pas que vous avez déjà commencé. Vous n'avez pas commencé. Ce courrier est une démarche préalable, et c'est précisément ce qui la rend recevable.

Ne minimisez pas. N'écrivez pas « nous ne traitons que des données administratives ». La définition de l'article 1er du Code du numérique inclut la prestation de services de soins : votre relevé contient des données de santé, dites-le vous-même. Une autorité qui découvre elle-même ce que vous avez tenté de dissimuler ne vous fait plus confiance ensuite.

[Prénom NOM]

[Adresse complète]

[Téléphone] — [Courriel]

À Monsieur le Président de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel [Adresse — à vérifier sur apdp.bj]

Cotonou, République du Bénin

[Ville], le [date]

Objet : demande de conseil préalable en vue d'un traitement de données à caractère personnel comportant des données de santé

Monsieur le Président,

Je projette de créer une entreprise de services dont l'activité consisterait à accompagner les patients et leurs familles dans les démarches administratives et logistiques liées à un parcours de soins, à l'exclusion de toute activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique.

Avant tout démarrage d'activité et avant tout traitement de données, je souhaite soumettre le projet à votre appréciation.

Nature du traitement envisagé. L'entreprise tiendrait, pour chaque patient accompagné, un relevé daté des démarches engagées comportant : la date et l'heure, l'étape du parcours, le lieu ou le service concerné, la nature administrative de la démarche, le montant payé, l'état d'avancement, la localisation des documents et la prochaine échéance.

Qualification que je retiens. Bien que ce relevé ne comporte aucun élément clinique — ni diagnostic, ni symptôme, ni interprétation — je considère qu'il constitue un traitement de données de santé au sens de l'article premier du Code du numérique, dès lors que cette définition inclut les informations relatives à la prestation de services de soins. Je considère en conséquence que ce traitement relève du régime particulier prévu à l'article 394 et de l'autorisation préalable de votre Autorité.

Mesures de minimisation déjà retenues. Le relevé serait établi en un exemplaire unique sur support papier, remis à la famille et conservé par elle. L'entreprise n'en conserverait aucune copie. À l'issue de chaque accompagnement, seules trois données agrégées et anonymes seraient conservées à des fins statistiques : le nombre de lignes, le montant total et le montant des prestations devenues sans objet. Aucun fichier informatique nominatif ne serait constitué au démarrage.

Consentement. Le consentement exprès et écrit du patient lui-même serait recueilli préalablement à toute intervention, sur un formulaire distinct de l'engagement contractuel de la personne qui règle la prestation, celle-ci pouvant être un tiers.

Je sollicite en conséquence :

1. votre appréciation sur la qualification que je retiens et sur le régime applicable ;
2. l'indication de la procédure et du formulaire à utiliser, ainsi que des pièces attendues ;
3. votre avis sur les mesures de minimisation envisagées et sur celles que vous jugeriez nécessaires ;
4. votre position sur le régime applicable à un éventuel transfert d'informations vers un membre de la famille résidant hors de la République du Bénin, à la demande et avec le consentement écrit du patient ;
5. l'indication des délais d'instruction, afin que je puisse organiser mon calendrier de lancement en conséquence.

Je m'engage à ne débiter aucune activité impliquant un traitement de données à caractère personnel avant l'accomplissement complet des formalités que vous m'indiquerez.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

[Signature]

[Prénom NOM]

BRIEF 4 — Consultation d'avocat

Ce document n'est pas un courrier. C'est le cahier des charges de la consultation. Remettez-le à l'avocat avant le premier rendez-vous, avec l'étude juridique et la note de cadrage.

Pourquoi un brief écrit. Un avocat payé à l'heure et à qui l'on expose un projet oralement passera la moitié du temps à reconstituer les faits. Un brief écrit avec des questions numérotées transforme une conversation en livrable. Demandez explicitement une réponse écrite question par question.

Ce que je vous demande

Une consultation écrite, répondant point par point aux questions ci-dessous, distinguant clairement ce qui est certain, ce qui est probable et ce qui n'est pas tranché.

Le projet, en un paragraphe

Création d'une entreprise de services dont l'activité consiste à faire circuler l'information et les documents entre les acteurs d'un parcours de soins, et à tenir les familles informées de l'état des démarches, de leur coût et de ce qui reste à faire. L'entreprise n'exerce aucune activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique. Elle ne diagnostique pas, ne prescrit pas, n'interprète aucun résultat, ne dispense aucun médicament et ne se substitue à aucun professionnel réglementé.

Documents joints

- Étude juridique, institutionnelle, opérationnelle et stratégique du 22 août 2026
- Note de cadrage opérationnel « Le périmètre défendable »
- Modèle de relevé de parcours
- Projets de conditions générales, de contrat type et de code de conduite

Questions

A — Le texte applicable

A1. Quelle est la rédaction en vigueur des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 45, 65, 66 de la loi n°2020-37, après la loi n°2022-17 ? Merci de fournir le texte.

A2. Le délai de deux mois pour saisir le ministre chargé de la santé, l'ordre professionnel ou la juridiction compétente en cas de faute médicale suspectée figure-t-il toujours à l'article 8 ? Quelle est sa nature — délai de forclusion, de prescription, ou simple recommandation ? Quel est son point de départ ?

A3. Le régime de la personne de confiance mentionnée à l'article 12 est-il précisé quelque part — modalités de désignation, étendue des pouvoirs, forme exigée ?

A4. L'ordonnance n°1973-14 du 8 février 1973 instituant un code de déontologie médicale est-elle toujours en vigueur ? Comment s'articule-t-elle avec la loi n°2020-37 modifiée ? Existe-t-il un code de déontologie plus récent ?

A5. Existe-t-il des textes réglementaires définissant les actes et compétences des infirmiers et des sages-femmes en République du Bénin ?

B — L'exercice illégal

B1. Quels articles du Code pénal (loi n°2018-16) ou d'un autre texte répriment l'exercice illégal de la médecine, de la pharmacie et des professions paramédicales ? Quelles sont les peines encourues ?

B2. Le fait, pour un tiers non professionnel de santé, de **lire à voix haute** à une personne non lettrée le contenu littéral d'une ordonnance, sans aucun commentaire ni explication de l'indication, est-il susceptible de qualification pénale ?

B3. Le fait de **transporter un document médical sous enveloppe close** entre un laboratoire et le médecin prescripteur, sur mandat écrit du patient, sans en prendre connaissance, est-il licite ? Sous quelles conditions ?

B4. Le fait d'**informer une famille de l'existence d'un dispositif public de gratuité**, par exemple la prise en charge de la césarienne, et de l'aider à faire valoir ce droit, appelle-t-il une réserve quelconque ?

B5. Le fait de **tenir un relevé daté des démarches administratives et des paiements** d'un patient, sans aucun élément clinique, est-il susceptible d'être requalifié en tenue de dossier médical ?

C — Le médicament

C1. Quel est le périmètre exact de l'interdiction posée aux articles 6 et 90 de la loi n°2021-03 ? La notion de « distribution » y couvre-t-elle le transport ponctuel d'un produit acheté par un particulier ?

C2. Un montage dans lequel la famille est l'acheteur et le propriétaire du médicament, la facture étant émise par l'officine au nom du patient, le tiers n'intervenant que comme mandataire de transport sans marge ni stockage, est-il défendable ? Quelles conditions cumulatives le rendraient acceptable ?

C3. Quelle est votre appréciation du risque, sachant que l'activité serait professionnelle, répétée et rémunérée ?

C4. Ma décision actuelle est de ne pas lancer ce service. Confirmez-vous que c'est le bon arbitrage à ce stade ?

D — Données personnelles

D1. Confirmez-vous que le relevé de parcours décrit constitue un traitement de données de santé relevant de l'autorisation préalable de l'APDP ?

D2. Quelles sont les obligations exactes du responsable de traitement : registre, durée de conservation, désignation éventuelle d'un délégué, procédure de notification en cas de violation ?

D3. Quel est le régime applicable au transfert d'informations vers un membre de la famille résidant à l'étranger, avec le consentement écrit du patient ?

D4. Un accompagnateur salarié, non professionnel de santé, peut-il être valablement tenu à une obligation de confidentialité par la seule voie contractuelle ? Quelle est la sanction en cas de manquement ?

E — Responsabilité et contrats

E1. Une clause limitant la responsabilité de l'entreprise au montant de la prestation est-elle opposable en droit béninois, notamment face à un consommateur ?

E2. Une clause excluant toute intervention en situation d'urgence vitale est-elle valable et suffisante ?

E3. Quelle est la portée de la distinction obligation de moyens / obligation de résultat pour cette activité ?

E4. L'entreprise peut-elle être recherchée en responsabilité pour un dommage médical survenu pendant un accompagnement ? Sur quel fondement ?

E5. Le contrat à double signature patient / payeur que je propose est-il juridiquement solide ? Que faut-il y corriger ?

E6. L'assurance de responsabilité civile professionnelle est-elle obligatoire pour cette activité ? À défaut, que recommandez-vous ?

F — Statut et régulation

F1. Sous quelle forme sociale me conseillez-vous d'exercer, et quel objet social rédiger ?

F2. Cette activité relève-t-elle d'une autorisation, d'un agrément ou d'une déclaration préalable auprès du ministère de la santé, de l'ARS ou d'une autre autorité ?

F3. Un abonnement mensuel donnant accès à des prestations d'accompagnement en cas de maladie est-il susceptible d'être requalifié en produit d'assurance au sens de la réglementation CIMA ? Comment structurer l'offre pour éviter cette requalification ?

F4. Une convention avec un établissement public de santé appelle-t-elle des précautions particulières — marchés publics, autorisation de tutelle, autre ?

G — La question de synthèse

G1. Au vu de l'ensemble, identifiez-vous un risque juridique **majeur** portant sur le cœur de l'activité — l'acheminement de documents et la tenue du relevé — et non sur ses périphéries déjà écartées ?

Cette dernière question est celle qui décide de la suite. Si la réponse est oui, le projet s'arrête.

TABLEAU DE SUIVI DES DEMANDES

Destinataire	Objet	Déposé le	Décharge	Courriel le	Relance J+15	Réponse reçue le	Suite
SGG	Version consolidée						
ARS	Référentiel + Charte						
APDP	Conseil préalable						
Avocat	Consultation écrite						

Rappel. Ces modèles sont des documents de travail. Faites-les relire par votre avocat avant envoi, en particulier le courrier à l'APDP : ce que vous y écrivez sur la qualification de votre traitement vous engage.

PARTIE IV — LE KIT D'ENQUÊTE TERRAIN

Semaines 3 à 11. Protocole, fiche patient traceur, grilles d'entretien, test de solvabilité.

Ce que ce kit sert à éviter. Construire une entreprise sur une expérience personnelle. Vous avez vécu un épisode qui vous a marqué. Il vous dit qu'un problème **existe**. Il ne vous dit ni sa fréquence, ni sa distribution, ni s'il est le plus douloureux parmi les problèmes possibles, ni si quelqu'un paierait pour l'éviter.

Ce que ce kit produit. Les quatre chiffres de la décision de la semaine 12.

1. LES TROIS QUESTIONS, ET POURQUOI IL FAUT LES SÉPARER

Question	Méthode	L'erreur classique
Le problème existe-t-il ?	Observation directe et registres	Se contenter de demander aux gens. Ils répondent toujours oui.
Est-il fréquent ?	Comptage sur un échantillon défini d'avance	Généraliser à partir des cas les plus marquants
Quelqu'un paierait-il pour l'éviter ?	Test d'engagement réel	Demander « paieriez-vous ? ». La réponse déclarative n'a aucune valeur.

La troisième est la seule qui décide de l'existence de votre entreprise, et c'est celle que presque personne ne teste.

Les six règles de conduite de l'enquête

Celui qui observe n'est pas celui qui vend. Si la même personne fait les deux, l'observation devient une démonstration et vous ne mesurez plus rien. Si vous êtes seul, séparez au moins dans le temps : observez pendant quatre semaines sans jamais proposer quoi que ce soit.

Question ouverte d'abord, toujours. « Racontez-moi ce qui s'est passé depuis votre arrivée » avant toute question fermée. Les questions fermées fabriquent les réponses qu'elles contiennent.

Cherchez activement les parcours qui se sont bien passés. S'ils sont majoritaires, votre marché est plus petit que prévu — et c'est une information que vous devez vouloir connaître. N'interrogez jamais uniquement les mécontents : le biais de sélection est le tueur silencieux des études de marché.

Triangulez. Ne retenez un fait que s'il est confirmé par deux sources de nature différente : un témoignage **et** une observation, ou un témoignage **et** un registre.

Notez l'écart entre le vécu et le mesuré. Une attente d'une heure vécue comme trois heures n'est pas une erreur de mesure : c'est un problème d'information, et c'est exactement votre métier.

Aucune donnée clinique, jamais. Pas de diagnostic, pas de symptôme, pas de nom de soignant. Vos formulaires ne prévoient pas de case pour cela — c'est délibéré.

2. PROTOCOLE D'OBSERVATION — LE PATIENT TRACEUR

Ce que c'est

Suivre un patient de son arrivée à sa sortie en notant uniquement la **chronologie** et les **étapes** : où il va, quand, combien de temps il attend, combien il paie, avec qui il parle. Jamais ce qu'il a.

C'est la méthode la plus convaincante auprès d'une direction hospitalière, parce qu'elle produit un schéma plutôt qu'une opinion. Un directeur peut contester votre analyse ; il ne peut pas contester une chronologie horodatée.

Préparation

	Étape
☐	Choisir trois établissements contrastés : un hôpital de zone, un CHD, une structure de premier contact
☐	Obtenir une autorisation écrite de chaque direction — sans autorisation, aucune observation
☐	Vérifier l'existence d'un comité d'éthique compétent et, le cas échéant, obtenir son avis [à vérifier auprès de la direction]
☐	Se présenter au chef de service et à l'infirmier-chef avant de commencer
☐	Convenir d'un badge ou d'un signe distinctif visible
☐	Fixer l'échantillon : 30 à 50 parcours, répartis entre les trois sites

Sur place

Vous restez dans les couloirs, jamais dans les chambres. Vous ne suivez personne dans une salle de soins. Vous n'assistez à aucune consultation sans autorisation explicite du soignant **et** du patient.

Vous notez des faits horodatés. Rien d'autre.

Ce que l'on compte

- Le trajet réel : nombre d'arrêts, nombre de personnes à qui le patient ou sa famille parle, nombre de retours en arrière
 - Le temps d'attente à chaque étape
 - Le nombre de fois où la même question est posée à des personnes différentes
 - Le délai entre la prescription d'un examen et la remise du résultat au prescripteur
 - Le nombre de patients repartis sans avoir vu un soignant
 - Le nombre d'orientations vers l'extérieur pour un médicament
 - Le nombre de déplacements n'ayant donné lieu à aucun acte
-

3. FICHE PATIENT TRACEUR

À imprimer, une par parcours suivi. Format A4.

Identifiant du parcours [site]-[n°] **Date** **Observateur** **Site** ☐ Hôpital de zone ☐ CHD ☐ Structure de premier contact **Consentement recueilli** ☐ oui ☐ non — *sans consentement, on n'observe pas* **Accompagnant présent** ☐ oui ☐ non — si oui, lien :

Chronologie

Heure	Étape	Lieu / service	À qui il parle (fonction)	Attente (min)	Payé (FCFA)	Observation factuelle

Compteurs de fin de parcours

Indicateur	Valeur
Durée totale du parcours (h)	
Nombre d'arrêts	
Nombre de personnes différentes sollicitées	
Nombre de retours en arrière	
Attente cumulée (min)	
Attente au paiement (min)	
Montant total payé (FCFA)	
Nombre de déplacements sans acte	

Indicateur	Valeur
Examen prescrit ? ☐ oui ☐ non — si oui, délai prescription → résultat chez le prescripteur (h)	
Orientation vers l'extérieur pour un médicament ? ☐ oui ☐ non	
Le patient est-il reparti sans voir de soignant ? ☐ oui ☐ non	

Trois questions au patient ou à l'accompagnant, à la sortie

Compréhension — noter la réponse telle qu'elle est donnée, sans corriger

1. Pouvez-vous me dire ce qui a été décidé aujourd'hui ? ☐ répond clairement ☐ répond partiellement ☐ ne sait pas
2. Savez-vous ce que vous devez faire maintenant ? ☐ oui ☐ partiellement ☐ non
3. Savez-vous quand vous devez revenir, et pourquoi ? ☐ oui ☐ partiellement ☐ non

Score de compréhension : / 3

Vécu

4. Combien de temps avez-vous eu l'impression d'attendre au total ? (*comparer à l'attente mesurée*)
5. Y a-t-il eu un moment où vous ne saviez pas quoi faire ? Qu'avez-vous fait ?
6. Avez-vous payé quelque chose qui n'a finalement servi à rien ? FCFA — quoi :
7. Combien de trajets avez-vous faits pour cet épisode ?
8. Avez-vous manqué le travail ? jours

4. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À L'OBSERVATION

À lire à voix haute si la personne ne lit pas. Un exemplaire remis, un exemplaire conservé.

Étude sur l'organisation des parcours de soins

[Nom de la structure ou du porteur] · [Téléphone]

Ce que nous faisons. Nous étudions comment se déroulent concrètement les démarches dans cet établissement : où vous allez, combien de temps vous attendez, quels papiers vous portez. Cette étude a été autorisée par la direction de l'établissement.

Ce que nous notons. Les heures, les lieux, les montants que vous payez, les démarches que vous faites.

Ce que nous ne notons jamais. Votre maladie. Ce que le médecin vous dit. Le nom des soignants. Aucune information sur votre santé n'est enregistrée.

Ce que cela change pour vous. Rien. Nous n'intervenons pas dans vos soins. Nous ne parlons pas aux soignants de votre cas. Votre prise en charge est exactement la même que vous acceptiez ou non.

Vous êtes libre. Vous pouvez refuser. Vous pouvez accepter puis changer d'avis à tout moment, sans avoir à vous expliquer, et sans aucune conséquence.

Ce que deviennent les informations. Elles sont regroupées avec d'autres, sans votre nom. Elles sont détruites au plus tard le [date]. Vous pouvez demander à tout moment que les vôtres soient effacées en appelant le numéro ci-dessus.

☐ J'accepte d'être observé pendant mes démarches d'aujourd'hui. ☐ J'accepte de répondre à quelques questions à la fin.

Nom ou initiales Signature ou empreinte Date

Recueilli par Lu à voix haute ☐ oui ☐ non Langue

5. GRILLES D'ENTRETIEN

Toujours en fin d'enquête, jamais au début : vous devez savoir ce que vous cherchez avant de demander. 30 à 45 minutes. Enregistrez seulement avec accord écrit.

5.1 Direction

1. Où en êtes-vous de la mise en conformité au dispositif de sécurité des patients ? Quels critères du domaine « implication du patient » vous posent le plus de difficulté ?
2. Combien de réclamations recevez-vous par mois ? Sur quoi portent-elles ?
3. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher aujourd'hui : les impayés, les litiges, le turnover, autre chose ?
4. Qui, dans votre organisation, est responsable de l'information des familles ?
5. Quand un patient paie un examen qui n'est finalement pas réalisé, que se passe-t-il ?
6. Qu'est-ce qui vous ferait refuser un partenaire extérieur dans vos services ?
7. Si un prestataire extérieur vous apportait des documents prêts pour votre dossier de certification, à quelles conditions l'accepteriez-vous ?

5.2 Médecins

1. Combien de temps consacrez-vous en moyenne à expliquer des choses non cliniques ?
2. Quelle proportion de vos patients revient sans avoir fait ce que vous aviez prescrit ? Pourquoi, selon vous ?
3. Que faites-vous quand un examen que vous avez prescrit ne revient jamais ?
4. Comment apprenez-vous qu'un résultat est prêt ?
5. Qu'est-ce qu'un tiers extérieur ne devrait **jamais** faire dans votre service ?
6. Si vous pouviez déléguer une seule tâche non médicale, laquelle ?

5.3 Infirmiers

1. Combien de fois par jour répondez-vous à la même question d'accompagnants ?
2. Que se passe-t-il quand un patient n'a pas de famille présente ?
3. Comment les familles apprennent-elles l'évolution de l'état d'un patient ?
4. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps ?
5. Quand un traitement change, qui l'explique à la famille ?
6. Qu'est-ce qui vous inquiéterait si une personne extérieure était présente dans le service ?

5.4 Sages-femmes

1. Les femmes savent-elles que la césarienne est prise en charge ? Que croient-elles devoir payer ?

2. Comment se passe l'information de la famille pendant le travail ?
3. Quelles ruptures d'information voyez-vous le plus souvent en post-partum ?
4. Les femmes repartent-elles avec un document écrit ? Le comprennent-elles ?
5. Qu'est-ce qui rendrait une présence extérieure acceptable en maternité — et inacceptable ?

5.5 Pharmaciens

1. À quelle fréquence orientez-vous une famille vers l'extérieur pour un produit indisponible ?
2. Que font les familles ensuite ? Reviennent-elles ?
3. Voyez-vous revenir des produits achetés et non utilisés ?
4. Comment savez-vous qu'un produit est en rupture ailleurs ?
5. Qu'est-ce qui vous poserait un problème déontologique dans une aide à la recherche de disponibilité ?

5.6 Patients — après la sortie, jamais pendant les soins

1. **Racontez-moi ce qui s'est passé depuis votre arrivée.** (*Laissez dérouler sans interrompre. C'est la question la plus informative des huit.*)
2. Y a-t-il eu un moment où vous ne saviez pas quoi faire ? Qu'avez-vous fait ?
3. Combien avez-vous dépensé en tout ?
4. Y a-t-il quelque chose que vous avez payé et qui n'a servi à rien ?
5. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué ce que vous aviez ? Avez-vous compris ?
6. Combien de trajets avez-vous faits ?
7. Qui vous a le plus aidé, ici ?
8. Qu'est-ce qui vous aurait le plus soulagé ?

5.7 Accompagnants

1. Combien de jours avez-vous manqué le travail ?
 2. Qu'avez-vous dû faire vous-même que vous ne pensiez pas devoir faire ?
 3. À qui vous êtes-vous adressé quand vous ne compreniez pas ?
 4. Avez-vous porté des papiers d'un service à un autre ? Lesquels ?
 5. Avez-vous avancé de l'argent ? Combien ?
 6. Qu'est-ce qui vous aurait le plus aidé ?
-

6. LE TEST DE SOLVABILITÉ — SEMAINES 7 À 10

C'est la phase décisive. Ne demandez jamais « paieriez-vous ? ». Faites payer.

Protocole

	Étape
☐	Définir une prestation unique, limitée et clairement décrite : l'acheminement tracé d'un résultat d'examen jusqu'au médecin prescripteur, avec confirmation de réception
☐	Fixer un prix affiché. L'écrire sur un support visible.

	Étape
☐	Écrire avant de commencer le taux de conversion en dessous duquel vous arrêtez
☐	Proposer à 30 à 50 familles, dans les mêmes conditions
☐	Faire varier le prix entre sous-groupes pour observer l'élasticité
☐	Ne jamais offrir la prestation gratuitement « pour tester » : un service gratuit ne prouve rien
☐	Compter séparément les quatre chiffres ci-dessous

Les quatre compteurs

Compteur	Ce qu'il vaut
Nombre de familles à qui l'offre a été présentée	Le dénominateur
Nombre qui acceptent d'écouter	De la politesse
Nombre qui disent oui	De la sympathie
Nombre qui paient effectivement	Le seul qui compte
Nombre qui reviennent une deuxième fois	La preuve de valeur réelle

En parallèle — tester le segment diaspora

Offre simple : une visite, un compte rendu écrit sous 24 heures, la coordination administrative. Diffusée dans des réseaux de Béninois de l'étranger. Mesurez le taux de conversion et le prix accepté.

Hypothèse à falsifier, pas à confirmer : ce segment convertira mieux et à un prix supérieur. Si ce n'est pas le cas, vous l'apprendrez ici pour un coût nul.

7. RÈGLES DE SAISIE

Une ligne par parcours dans la feuille de saisie du classeur Excel. Trois interdits absolus dans les formulaires comme dans la saisie :

- aucune donnée clinique ;
- aucune identification nominative d'un professionnel de santé ;
- aucune qualification de faute.

Avant de conclure quoi que ce soit sur une difficulté observée, appliquez la grille des huit catégories de l'étude — dysfonctionnement organisationnel, erreur humaine, problème de communication, contrainte réglementaire, manque de ressources, mauvaise pratique, faute potentielle, incompréhension du patient. Vous ne concluez **jamais** en catégorie 6 ou 7.

8. CE QUE VOUS PRODUISEZ EN SEMAINE 12

Une note écrite de trois pages, remise à vous-même et à votre avocat :

1. Les quatre chiffres, bruts.
2. Ce qu'ils confirment de vos hypothèses.
3. **Ce qu'ils contredisent.** Cette section doit exister. Si elle est vide, votre enquête a échoué : vous avez cherché à avoir raison.
4. La décision : go, no-go, ou pivot — et laquelle des trois offres survit.

PARTIE V — LE DOSSIER POUR UNE DIRECTION D'ÉTABLISSEMENT

À partir de la semaine 8. Note de présentation, projet de convention, préparation du rendez-vous.

Comment utiliser ce dossier. Deux pièces : une note de présentation de quatre pages à laisser après le rendez-vous, et un projet de convention à ne sortir qu'au deuxième entretien. Ne remettez jamais la convention au premier rendez-vous — vous passeriez pour quelqu'un qui vend plutôt que pour quelqu'un qui propose.

Ce qu'il faut avoir en tête en entrant. Le directeur en face de vous n'a pas de problème d'idées. Il a un problème de temps, de personnel et d'échéance. Vous ne venez pas lui expliquer son établissement : vous venez lui proposer de réduire un retard qu'il connaît déjà mieux que vous.

Un chiffre à ne jamais avancer. Le contenu exact du référentiel — nombre de domaines, de normes et de critères — provient de sources secondaires et n'a pas été vérifié dans le texte. Ne citez aucun de ces nombres devant un directeur avant d'avoir obtenu le décret auprès de l'ARS. Il le connaît mieux que vous, et une erreur vous discrédite en une phrase.

Ce qu'il ne faut jamais dire. Que vous avez constaté des dysfonctionnements. Que vous défendez les patients. Que la communication est mauvaise. Ces trois phrases sont entendues comme des reproches et referment la porte avant la fin de la première minute.

PIÈCE 1 — NOTE DE PRÉSENTATION

À imprimer sur quatre pages et à laisser après l'entretien.

Proposition de pilote

Contribution à la mise en conformité au dispositif pour la sécurité des patients — domaine « implication du patient et de la communauté »

[Nom de la structure] · [Contact] · [Date]

Ce que nous proposons

Un pilote de six mois, sur **un seul service** de votre choix, à indicateurs définis avant le démarrage et avec clause de résiliation immédiate.

Nous n'exerçons aucune activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique. Nous ne posons aucun diagnostic, n'établissons aucune prescription, n'interprétons aucun résultat et ne dispensons aucun médicament.

Notre activité tient en trois verbes :

Acheminer	Porter un document, une question ou une information d'un point à un autre de votre établissement, de façon tracée et sous enveloppe close.
Tenir à jour	Maintenir, pour chaque famille accompagnée, un relevé daté et non clinique de l'état des démarches,

	des paiements et de ce qui reste à faire.
Alerter	Signaler à un soignant un fait observable, ou à une famille une échéance.

Rien d'autre.

Pourquoi maintenant

Le décret n°2025-481 du 23 juillet 2025 réglemente le dispositif pour la sécurité des patients. L'un de ses domaines porte sur l'implication du patient et de la communauté.

C'est un domaine qui exige des **livrables** : supports d'information, recueil structuré de l'expérience patient, traçabilité. Ce sont des tâches de production documentaire, chronophages, qui ne relèvent pas du soin et qui viennent s'ajouter à une charge déjà lourde.

C'est exactement ce que nous savons faire, et c'est la seule chose que nous proposons.

Ce que nous livrons pendant le pilote

Livrable	Fréquence	Forme
Supports d'information par parcours, en français et en langues nationales	Une fois, puis mises à jour	Fiches A5 imprimables, validées par votre équipe avant diffusion
Diffusion et explication de la Charte des droits et devoirs des patients	Continu	Affichage + remise commentée
Acheminement tracé des résultats d'examen vers le prescripteur	Continu	Registre horodaté, confirmation de réception
Relevé de parcours remis aux familles	Par patient accompagné	Papier, propriété de la famille
Recueil structuré de l'expérience patient	Continu	Rapport trimestriel remis à la direction
Appui à la partie organisationnelle de l'audit de décès et à la production du rapport mensuel	Mensuel	Chronologie des démarches, points de rupture de circulation de l'information. Aucun accès aux données cliniques.

Ce que nous nous engageons à ne pas faire

Cette liste fait partie de la convention. Elle n'est pas une précaution de style.

- Aucun diagnostic, aucune prescription, aucune interprétation de résultat, aucune évaluation de gravité
- Aucune dispensation, détention ni transport de médicament
- Aucune ouverture des enveloppes contenant des documents médicaux
- Aucun accès au dossier médical

- Aucune communication d'information médicale à un tiers sans accord écrit du patient
- Aucune qualification de faute, d'erreur ou de manquement, ni auprès des familles ni auprès de quiconque
- Aucune critique d'un professionnel devant une famille
- Aucune commission, aucun avantage d'une officine, d'un laboratoire, d'une clinique ou d'un praticien
- Aucune constitution de base de données médicales

Les indicateurs

Mesurés avant le démarrage et à six mois, avec le même instrument, et **communiqués même s'ils sont mauvais**.

Indicateur	Unité	Source	Mesure initiale	À 6 mois
Délai médian prescription → résultat chez le prescripteur	heures	Registres du service et du laboratoire		
Venues n'ayant donné lieu à aucun acte	n / semaine	Registres d'admission		
Présentations à un niveau inadapté de la pyramide sanitaire	%	Observation		
Attente médiane au paiement	minutes	Chronométrage sur échantillon		
Score de compréhension à la sortie de consultation	/3	Trois questions fermées, échantillon constant		
Prestations engagées devenues sans objet	n / mois	Registres + relevés		
Réclamations reçues par l'établissement	n / mois	Direction		
Taux de recouvrement	%	Administration		
Documents produits pour le dossier de certification	n	Direction		
Temps soignant consacré à des explications non cliniques	min / poste / jour	Auto-déclaration, échantillon de postes		

Ce que nous ne prétendons pas mesurer. L'amélioration de la sécurité du patient elle-même. Un pilote de six mois sur un service ne peut pas la démontrer, et nous ne la revendiquons pas.

Ce que le pilote coûte, et ce qu'il ne coûte pas

Personnel mis à disposition	Deux accompagnateurs formés et supervisés, à notre charge
Ce que nous demandons à l'établissement	Un référent désigné, un accès aux registres pour la mesure des indicateurs, et un badge
Ce que nous ne demandons pas	Aucun local dédié, aucun poste informatique, aucun personnel de votre établissement
Financement	[à compléter — mixte recommandé : une part établissement, une part bailleur ou fondation]

Les trois issues, prévues dès la signature

Arrêt. Les indicateurs ne bougent pas, ou la présence pose problème. La convention prend fin, sans indemnité, sur préavis de quinze jours.

Poursuite. Les indicateurs bougent. Nous convenons d'un contrat de prestation.

Transfert de compétence. Vos équipes reprennent l'activité, avec les outils et la méthode que nous laissons. **Nous considérons cette issue comme un succès et nous la présentons comme telle.**

Deux engagements que nous prenons dès maintenant

Une part gratuite. [X] % de nos heures sont réservées à des patients désignés par votre service social, sans contrepartie. Un service payant d'accompagnement crée mécaniquement deux catégories de patients dans le même couloir ; nous préférons traiter ce problème avant qu'on nous le pose.

Aucun bénéfice tiré d'un litige. Aucune part de notre chiffre d'affaires, aucun partenariat, aucune rémunération ne dépend d'un contentieux impliquant votre établissement. Cet engagement figure dans la convention.

PIÈCE 2 — PROJET DE CONVENTION

À faire relire par votre avocat avant toute remise. Ce modèle est un point de départ, pas un contrat prêt à signer. Une convention avec un établissement public peut appeler des précautions particulières — autorisation de tutelle, règles de la commande publique — qui n'ont pas été vérifiées ici.

CONVENTION DE PILOTE

Entre les soussignés :

[Dénomination de l'établissement], [forme], dont le siège est à [adresse], représenté par [nom], agissant en qualité de [fonction],

ci-après « l'Établissement »,

et

[Dénomination de l'entreprise], [forme], immatriculée sous le n° [RCCM], dont le siège est à [adresse], représentée par [nom], agissant en qualité de [fonction],

ci-après « l'Opérateur »,

il a été convenu ce qui suit.

Article 1 — Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'Opérateur intervient, à titre expérimental, au sein du service [dénomination] de l'Établissement, afin de contribuer à l'information administrative des patients et de leurs familles ainsi qu'à la circulation des documents entre les services.

Article 2 — Périmètre de l'intervention

L'intervention de l'Opérateur se limite strictement aux activités suivantes :

- 2.1** Acheminer, sous enveloppe close et de manière tracée, des documents entre les services de l'Établissement, sur mandat écrit du patient.
- 2.2** Tenir à jour, pour chaque famille accompagnée, un relevé daté des démarches engagées, des montants payés et de ce qui reste à accomplir, à l'exclusion de toute donnée clinique.
- 2.3** Informer les patients et leurs familles de l'organisation de l'Établissement, des circuits, des tarifs affichés et des dispositifs publics de prise en charge.
- 2.4** Diffuser la Charte des droits et devoirs des patients et les supports d'information validés par l'Établissement.
- 2.5** Signaler à un professionnel de santé de l'Établissement tout fait observable justifiant son attention, sans aucune appréciation de nature médicale.
- 2.6** Recueillir l'expérience des patients selon un protocole validé par l'Établissement, et lui en remettre la synthèse.
- 2.7** Apporter un appui à la production des documents organisationnels relevant du dispositif pour la sécurité des patients, sans accès aux données cliniques.

Article 3 — Interdictions expresses

L'Opérateur s'interdit expressément :

- a) de poser ou d'évoquer un diagnostic, d'établir ou de modifier une prescription, d'interpréter un résultat d'examen, d'évaluer la gravité d'un symptôme ;
- b) de dispenser, détenir, acheter, transporter ou remettre un médicament ;
- c) d'ouvrir les enveloppes contenant des documents médicaux, ou d'en prendre connaissance ;
- d) d'accéder au dossier médical d'un patient ;
- e) de communiquer une information relative à un patient à un tiers, y compris un proche, sans le consentement écrit du patient ;
- f) de qualifier une situation de faute, d'erreur ou de manquement, auprès d'un patient, d'une famille ou de tout tiers ;
- g) de formuler devant un patient ou une famille une appréciation critique sur un professionnel de santé ;

- h) de percevoir ou de verser une commission, une rémunération ou un avantage quelconque de la part d'une officine, d'un laboratoire, d'un établissement de soins ou d'un praticien ;
- i) de constituer un fichier de données de santé au-delà de ce qui est autorisé par l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel ;
- j) d'intervenir dans une situation d'urgence vitale, qui relève exclusivement de l'Établissement.

Le manquement à l'une quelconque de ces interdictions constitue un manquement grave au sens de l'article 13.

Article 4 — Référent et modalités de présence

4.1 L'Établissement désigne un référent, [nom et fonction], interlocuteur unique de l'Opérateur.

4.2 Les intervenants de l'Opérateur portent en permanence un badge distinctif mentionnant leur qualité et le nom de l'Opérateur.

4.3 Ils interviennent aux jours et heures suivants : [à compléter], dans les seuls locaux suivants : [à compléter].

4.4 Ils n'accèdent à aucune chambre, salle de soins, salle de naissance ou bloc sans autorisation expresse du professionnel responsable **et** du patient.

4.5 Ils se conforment au règlement intérieur de l'Établissement et à l'autorité des professionnels de santé présents.

Article 5 — Consentement des patients

5.1 Aucune intervention n'a lieu sans le consentement écrit préalable du patient, recueilli sur un formulaire distinct de tout engagement contractuel souscrit par un tiers payeur.

5.2 Le consentement est révoquant à tout moment, sans forme ni justification.

5.3 L'Opérateur remet à l'Établissement, sur demande, le modèle de formulaire utilisé.

Article 6 — Données à caractère personnel

6.1 L'Opérateur déclare avoir accompli les formalités préalables requises auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel et en justifie auprès de l'Établissement avant tout démarrage.

6.2 Le relevé de parcours est établi en un exemplaire unique, remis à la famille. L'Opérateur n'en conserve aucune copie.

6.3 L'Opérateur ne conserve, à des fins statistiques, que des données agrégées et anonymes.

6.4 Les intervenants de l'Opérateur sont contractuellement tenus à une obligation de confidentialité, dont la méconnaissance constitue une faute grave.

6.5 Toute violation de données est portée à la connaissance de l'Établissement dans les vingt-quatre heures.

Article 7 — Indicateurs et évaluation

7.1 Les indicateurs figurant en annexe sont mesurés conjointement avant le démarrage, puis au terme du pilote.

7.2 L'Établissement donne accès à l'Opérateur aux registres nécessaires à cette seule mesure.

7.3 Le rapport final est remis à l'Établissement, quels que soient ses résultats. L'Opérateur s'engage à y faire figurer les résultats défavorables.

7.4 Aucune publication ni communication externe relative au pilote ne peut intervenir sans l'accord écrit préalable de l'Établissement.

Article 8 — Accès équitable

L'Opérateur réserve [X] % de ses heures d'intervention à des patients désignés par le service social de l'Établissement, sans contrepartie financière d'aucune sorte.

Article 9 — Signalement des situations urgentes

9.1 L'Opérateur alerte immédiatement le professionnel de santé présent, puis le cadre de garde, en décrivant des faits observables et sans aucune appréciation médicale.

9.2 Il consigne l'heure de chaque alerte et la réponse obtenue.

9.3 Il ne pose aucun acte, ne transporte aucun patient et ne conseille jamais un départ contre avis médical.

Article 10 — Assurance

L'Opérateur justifie, avant tout démarrage, d'une assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité, et en communique l'attestation à l'Établissement ainsi qu'à chaque renouvellement.

Article 11 — Propriété des livrables

11.1 Les supports d'information produits dans le cadre du pilote sont la propriété de l'Établissement, qui peut les utiliser sans limitation de durée, y compris après le terme de la convention.

11.2 Les données recueillies auprès des patients appartiennent à l'Établissement.

11.3 La méthode et les outils propres de l'Opérateur demeurent sa propriété.

Article 12 — Durée

La présente convention est conclue pour une durée de six mois à compter du [date]. Elle ne se renouvelle pas par tacite reconduction.

Article 13 — Résiliation

13.1 L'Établissement peut résilier la présente convention **à tout moment, sans motif et sans indemnité**, par simple notification écrite, moyennant un préavis de quinze jours.

13.2 En cas de manquement à l'une des interdictions de l'article 3, ou en cas d'atteinte à la sécurité d'un patient, **la résiliation est immédiate et de plein droit**, sans préavis ni indemnité, sur simple notification écrite.

13.3 L'Opérateur dispose de la même faculté de résiliation sans motif, moyennant le même préavis.

13.4 En cas de résiliation, l'Opérateur remet sans délai à l'Établissement l'ensemble des documents et données lui appartenant, et détruit tout élément conservé.

Article 14 — Absence d'exclusivité et de rémunération croisée

14.1 La présente convention n'emporte aucune exclusivité au bénéfice de l'une ou l'autre partie.

14.2 L'Opérateur déclare ne percevoir aucune rémunération, commission ou avantage d'un tiers à raison de son intervention au sein de l'Établissement.

14.3 Aucune part de la rémunération de l'Opérateur ne dépend, directement ou indirectement, de l'issue d'un litige impliquant l'Établissement ou l'un de ses agents.

Article 15 — Conditions financières

[À compléter]

Article 16 — Litiges

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend né de l'exécution de la présente convention. À défaut d'accord dans un délai de trente jours, le litige est porté devant les juridictions compétentes de [ville].

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.

Pour l'Établissement [nom, fonction, signature]

Pour l'Opérateur [nom, fonction, signature]

Annexe 1 — Tableau des indicateurs et leur mesure initiale **Annexe 2** — Modèle de relevé de parcours **Annexe 3** — Modèle de formulaire de consentement du patient **Annexe 4** — Code de conduite des intervenants **Annexe 5** — Attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle **Annexe 6** — Justificatif des formalités accomplies auprès de l'APDP

PIÈCE 3 — PRÉPARATION DU RENDEZ-VOUS

Les quatre-vingt-dix premières secondes

« Vous avez une échéance de mise en conformité sur le dispositif de sécurité des patients, et l'un des domaines porte sur l'implication du patient et de la communauté. C'est un domaine qui demande de produire des documents et de la donnée d'expérience patient — et je suppose que ce n'est pas ce qui vous manque le moins.

Nous ne touchons à rien de médical. Nous faisons circuler les documents entre vos services, nous tenons un relevé non clinique du parcours des familles, et nous vous rendons l'information qu'elles détiennent et que personne ne collecte aujourd'hui.

Je vous propose un pilote de six mois sur un seul service, avec des indicateurs définis avant de commencer et une clause de résiliation immédiate. Si les chiffres sont mauvais, je viendrai vous le dire.

»

Puis vous vous taisez.

Les six objections que vous entendrez

Objection	Réponse
« Nous n'avons pas de budget. »	« Le pilote peut démarrer sans ligne budgétaire de votre côté : nous cherchons un cofinancement. Ce que je vous demande d'abord, c'est un référent et un accès aux registres. »
« Vous allez déranger les équipes. »	« Un seul service, deux personnes, des horaires convenus avec l'infirmier-chef, et une résiliation à quinze jours sans motif. Si nous dérangeons, vous nous arrêtez. »
« C'est le rôle de nos assistantes sociales. »	« Absolument, et nous ne le prenons pas. Nous prenons l'acheminement des documents et la production des supports — la partie qui leur mange du

Objection	Réponse
	temps sans relever de leur métier. »
« Vous allez pousser les gens à porter plainte. »	« C'est écrit à l'article 3 : nous ne qualifions jamais une situation de faute, et aucune part de notre chiffre d'affaires ne dépend d'un litige. Nous rappelons aussi aux familles leurs devoirs, pas seulement leurs droits. »
« Et si vous voyez quelque chose ? »	« Nous décrivons des faits à votre référent, par écrit. Nous ne les interprétons pas et nous ne les diffusons pas. L'article 7.4 nous interdit toute communication externe sans votre accord. »
« Qu'est-ce que vous y gagnez ? »	« Une preuve. Nous démarrons : nous avons besoin d'un site où mesurer si ce que nous croyons est vrai. C'est pour cela que le rapport final vous est remis même s'il est mauvais. »

Ce que vous emportez

☐ La note de présentation, imprimée en deux exemplaires
 ☐ Un relevé de parcours vierge, imprimé — le montrer vaut mieux que le décrire
 ☐ Le code de conduite
 ☐ Le tableau des indicateurs, vierge
 ☐ **Pas la convention.** Elle vient au deuxième rendez-vous.

Après le rendez-vous, le jour même

Un courriel de trois lignes : merci, voici ce que j'ai compris de vos priorités, voici ce que je vous propose comme prochaine étape et à quelle date. Une proposition sans date ne se transforme jamais en convention.

PARTIE VI — DOCUMENTS CONTRACTUELS ET PROCÉDURES

Avant la première prestation payante. CGV, contrat, consentement, code de conduite, six fiches de procédure.

Avertissement, à lire en entier. Ces modèles sont des documents de travail. Ils n'ont pas été rédigés par un avocat et n'ont pas été confrontés au droit béninois positif. Trois points en particulier doivent être vérifiés avant tout usage : l'opposabilité d'une clause limitative de responsabilité face à un consommateur, la validité de l'exclusion de l'urgence vitale, et la portée réelle d'une obligation de confidentialité purement contractuelle pesant sur une personne non tenue au secret professionnel. Ces trois questions figurent au brief de consultation remis à l'avocat.

Ce que ces documents ne remplacent pas. L'autorisation de l'APDP. Une clause contractuelle bien rédigée ne vaut pas conformité.

DOCUMENT 1 — CONDITIONS GÉNÉRALES DE SERVICE

Article 1 — Objet et définition du service

1.1 [Dénomination], ci-après « le Prestataire », exerce une activité de services consistant à faire circuler l'information et les documents entre les acteurs d'un parcours de soins, et à tenir informées les personnes accompagnées de l'état d'avancement des démarches, de leur coût et de ce qui reste à accomplir.

1.2 Le service se limite à trois actions : acheminer un document ou une question ; tenir à jour un relevé daté des démarches ; alerter un professionnel de santé d'un fait observable ou une famille d'une échéance.

Article 2 — Ce que le Prestataire n'est pas

Le Prestataire n'exerce aucune activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique.

Il n'est ni un établissement de santé, ni un professionnel de santé, ni un établissement pharmaceutique, ni un assureur, ni un intermédiaire d'assurance, ni un auxiliaire de justice.

En conséquence, le Prestataire ne peut en aucun cas et ne s'engage en aucun cas à :

- a) poser ou évoquer un diagnostic ;
- b) établir, modifier, suspendre ou commenter une prescription ;
- c) interpréter un résultat d'examen ;
- d) évaluer la gravité d'un symptôme ou l'état de santé d'une personne ;
- e) conseiller de poursuivre ou d'interrompre un traitement ;
- f) dispenser, détenir, acheter, transporter ou remettre un médicament ;
- g) se substituer à un médecin, un infirmier, une sage-femme, un pharmacien ou tout autre professionnel réglementé ;
- h) consentir à un acte médical au nom du Client ou du Patient ;
- i) annoncer un décès ou un pronostic ;
- j) qualifier une situation de faute, d'erreur ou de manquement ;
- k) représenter quiconque devant une juridiction ou un ordre professionnel ;
- l) garantir un résultat médical, quel qu'il soit.

Toute demande portant sur l'un de ces points est refusée et renvoyée au professionnel de santé compétent.

Article 3 — Obligation de moyens

3.1 Le Prestataire est tenu d'une **obligation de moyens** et non d'une obligation de résultat.

3.2 Il met en œuvre les diligences raisonnables d'un professionnel normalement diligent. Il ne garantit ni la disponibilité d'un produit ou d'un service, ni un délai de réalisation, ni l'issue d'une démarche, ni aucun résultat médical.

3.3 Le Prestataire n'a aucune maîtrise de l'organisation, des délais, des tarifs ou de la disponibilité des établissements de santé, laboratoires, officines et administrations auprès desquels il intervient.

Article 4 — Urgence vitale

Le Prestataire n'intervient pas dans les situations d'urgence vitale, qui relèvent exclusivement des établissements et des professionnels de santé.

En présence d'un fait observable justifiant l'attention d'un soignant, le Prestataire alerte immédiatement le professionnel présent, puis le cadre de garde, et consigne l'heure de chaque alerte. Il ne pose aucun acte, ne transporte aucun patient et ne formule aucune appréciation médicale.

Article 5 — Le Patient et le Client

5.1 Le **Patient** est la personne dont le parcours de soins fait l'objet de l'accompagnement. Il est le seul titulaire des droits relatifs à son état de santé et aux informations le concernant.

5.2 Le **Client** est la personne qui commande et règle la prestation. Il peut être le Patient lui-même ou un tiers.

5.3 Le règlement de la prestation ne confère au Client aucun droit d'accès aux informations médicales du Patient. Le Prestataire ne transmet une information concernant le Patient qu'avec le consentement écrit de celui-ci, révocable à tout moment.

5.4 Lorsque le Client n'est pas le Patient, la souscription requiert la signature des deux.

5.5 Le retrait du consentement du Patient met fin à la transmission d'informations le concernant, sans que le Client puisse s'en prévaloir pour obtenir réparation.

Article 6 — Données à caractère personnel

6.1 Le Prestataire traite des données à caractère personnel comportant des données de santé au sens de la réglementation applicable. Il a accompli les formalités préalables requises auprès de l'Autorité de Protection des Données à caractère Personnel.

6.2 Le relevé de parcours est établi en un exemplaire unique, remis au Patient ou à la personne qu'il désigne. Le Prestataire n'en conserve aucune copie.

6.3 Le Prestataire ne conserve, à des fins statistiques, que des données agrégées ne permettant aucune identification.

6.4 Le Prestataire ne constitue aucun dossier médical.

6.5 Le Patient dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'effacement, exerçable auprès de [contact].

6.6 Les documents éventuellement acheminés le sont sous enveloppe close. Le Prestataire ne les ouvre pas et n'en prend pas connaissance.

Article 7 — Absence de conflit d'intérêts

7.1 Le Prestataire ne perçoit aucune commission, rémunération ou avantage d'une officine, d'un laboratoire, d'un établissement de soins, d'un praticien ou d'un fournisseur de biens ou de services de santé.

7.2 Lorsqu'il informe d'une disponibilité ou d'une adresse, le Prestataire indique systématiquement plusieurs possibilités et n'en recommande aucune.

7.3 Aucune part de la rémunération du Prestataire ne dépend, directement ou indirectement, de l'issue d'un litige.

Article 8 — Prix et paiement

8.1 Les prix sont affichés et communiqués avant toute commande. [Grille tarifaire en annexe]

8.2 Le Prestataire n'avance aucun fonds pour le compte du Client ou du Patient et ne procède à aucun règlement en leur nom.

8.3 [Modalités et délais de paiement à compléter]

Article 9 — Responsabilité

9.1 La responsabilité du Prestataire ne peut être engagée qu'en cas de manquement prouvé à son obligation de moyens, ayant causé un préjudice direct et certain.

9.2 Le Prestataire n'est pas responsable des actes, omissions, délais, tarifs ou décisions des professionnels et établissements de santé, des laboratoires, des officines et des administrations.

9.3 Le Prestataire n'est pas responsable des conséquences d'une information inexacte ou incomplète fournie par le Client ou le Patient.

9.4 [Clause de plafonnement — rédaction à valider par un avocat, l'opposabilité d'une telle clause face à un consommateur devant être vérifiée en droit béninois]

9.5 Le Prestataire est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de [assureur], police n° [numéro]. L'attestation est communiquée sur simple demande.

Article 10 — Durée, résiliation, réclamation

10.1 [Durée et modalités à compléter]

10.2 Le Patient peut retirer son consentement à tout moment, sans forme et sans justification.

10.3 Toute réclamation est adressée à [contact]. Elle fait l'objet d'un accusé de réception sous quarante-huit heures et d'une réponse écrite sous quinze jours.

10.4 Le Prestataire tient un registre des réclamations, examiné trimestriellement.

Article 11 — Droit applicable

Les présentes conditions sont soumises au droit de la République du Bénin. Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend. À défaut, le litige est porté devant les juridictions compétentes de [ville].

DOCUMENT 2 — CONTRAT DE PRESTATION À DOUBLE SIGNATURE

Un exemplaire par accompagnement. Deux originaux : un pour le Client, un pour le Prestataire.

CONTRAT DE PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

N° [référence] — [date]

Les parties

Le Prestataire — [dénomination, RCCM, adresse, téléphone]

Le Client — Nom [.....] · Qualité [.....] · Adresse [.....] · Téléphone [.....]

Lien avec le Patient : ☐ le Patient lui-même ☐ conjoint ☐ enfant ☐ parent ☐ autre : [.....]

Réside : ☐ en République du Bénin ☐ à l'étranger — pays [.....]

Le Patient — Nom [.....] · Établissement [.....]

Prestation commandée

☐ Acheminement de documents entre services, avec confirmation de réception ☐ Tenue du relevé de parcours
☐ Accompagnement des démarches administratives ☐ Information sur les circuits, les tarifs et les dispositifs de prise en charge ☐ Compte rendu écrit non médical, fréquence : [.....] ☐ Autre : [.....]

Durée [.....] **Prix** [.....] **FCFA Modalités de règlement** [.....]

Déclarations expresses

Le Client reconnaît avoir reçu et lu les conditions générales de service, et déclare comprendre que :

☐ le Prestataire n'exerce **aucune activité médicale, paramédicale ou pharmaceutique** ; ☐ le Prestataire n'établira **aucun diagnostic**, n'interprétera **aucun résultat**, ne commentera **aucune prescription** et ne remettra **aucun médicament** ; ☐ le Prestataire est tenu d'une **obligation de moyens** et ne garantit **aucun résultat**, notamment médical ; ☐ le Prestataire **n'intervient pas** dans les situations d'urgence vitale ; ☐ **le règlement de la prestation ne donne aucun droit d'accès aux informations médicales du Patient** ; ☐ le Patient peut retirer son consentement à tout moment, ce qui met fin à la transmission d'informations le concernant, sans remboursement au titre des prestations déjà exécutées ; ☐ le Prestataire ne perçoit **aucune commission** d'une officine, d'un laboratoire, d'un établissement ou d'un praticien.

Signatures

Le Client — Nom [.....] Date [.....] Signature [.....]

Le Patient — *(indispensable ; à défaut, son représentant légal, en précisant sa qualité)* Nom [.....] Qualité [.....] Date [.....] Signature ou empreinte [.....]

Le Prestataire — Nom [.....] Date [.....] Signature [.....]

Sans la signature du Patient ou de son représentant légal, la prestation ne démarre pas. Cette règle n'a aucune exception, y compris lorsque le Client insiste, lorsqu'il a déjà payé, ou lorsqu'il est le chef de famille.

DOCUMENT 3 — CONSENTEMENT DU PATIENT

À lire à voix haute si la personne ne lit pas. Un exemplaire remis au Patient.

Ce que je vous propose

[Dénomination] · [Téléphone]

Nous vous aidons pour les papiers, les déplacements et l'organisation de vos démarches dans cet établissement.

Ce que nous faisons. Nous portons vos documents d'un service à un autre. Nous notons ce que vous faites, ce que vous payez et ce qui reste à faire. Nous vous rappelons vos rendez-vous. Nous vous disons où aller et ce que ça coûte.

Ce que nous ne faisons jamais. Nous ne sommes pas des soignants. Nous ne vous dirons jamais ce que vous avez, ce que veut dire un résultat, ni quel médicament prendre. Pour tout cela, c'est au médecin qu'il faut demander — et nous vous aiderons à lui poser la question.

Ce que nous écrivons sur vous. La date, le lieu, la démarche, ce que vous avez payé. **Jamais votre maladie.** Ce papier vous appartient et nous ne gardons aucune copie.

Qui peut savoir. Personne d'autre que vous, sauf si vous nous dites par écrit à qui nous pouvons parler.

☐ **J'accepte que [dénomination] m'accompagne dans mes démarches.**

☐ **J'accepte qu'il transporte mes documents sous enveloppe fermée, sans les ouvrir.**

☐ **J'accepte qu'il donne des informations sur mes démarches à :** Nom [.....] Lien [.....] Téléphone [.....]

☐ Cette personne réside à l'étranger — pays [.....]

☐ **Je préfère qu'il ne parle à personne d'autre que moi.**

Vous pouvez changer d'avis quand vous voulez, en le disant simplement, sans avoir à vous expliquer, et sans que cela change quoi que ce soit à vos soins.

Nom du Patient [.....] Date [.....] Signature ou empreinte [.....]

Lu à voix haute ☐ oui ☐ non Langue [.....] Par [.....]

DOCUMENT 4 — CODE DE CONDUITE DE L'ACCOMPAGNATEUR

À signer par chaque intervenant avant sa première mission. Un exemplaire conservé au dossier du personnel.

Les dix règles

1. Je n'exerce aucun acte médical, paramédical ou pharmaceutique. Je ne diagnostique pas, je ne prescris pas, je n'interprète pas, je n'évalue pas la gravité d'un symptôme.
2. Je transmets les questions au professionnel ; je ne transmets jamais la réponse à sa place.
3. Je m'adresse d'abord au patient. Je ne communique une information le concernant à un proche qu'avec son accord écrit.
4. Je ne conserve aucun document médical au-delà de la durée strictement nécessaire à la démarche en cours, et jamais sans consentement écrit. Je n'ouvre aucune enveloppe.
5. Je n'accepte aucun cadeau, aucune commission, aucun avantage d'un professionnel, d'une pharmacie, d'un laboratoire ou d'un établissement.
6. Je ne qualifie jamais une situation de faute, d'erreur ou d'escroquerie. Je décris des faits et j'oriente vers l'autorité compétente.
7. Je ne critique jamais un soignant devant une famille.
8. Je respecte le règlement intérieur de l'établissement et l'autorité du référent désigné.
9. En cas de doute, je m'abstiens et j'appelle mon superviseur.
10. Si je vois un patient en danger, j'alerte immédiatement un soignant — et je n'agis pas moi-même.

Les trois tests

Le test des deux secondes. « Ma phrase resterait-elle vraie si je ne savais rien de la maladie de ce patient ? » Oui, c'est du circuit, c'est autorisé. Non, c'est du contenu, c'est interdit.

Le test de la réponse. « Est-ce que je réponds, ou est-ce que je fais poser la question ? » Faire poser la question est toujours autorisé. Répondre à la place ne l'est jamais.

Le test de l'affiche. « Pourrais-je écrire cette phrase sur une affiche dans le couloir de l'hôpital, sans qu'un médecin s'y oppose ? » Si j'hésite, c'est non.

Ce que je peux dire, ce que je ne dirai jamais

J'ai le droit de dire	Je ne dirai jamais
« Votre résultat est prêt, je le porte au Dr X. »	« Ce résultat est normal. »
« Je ne peux pas vous dire ce que ça signifie. Allons le demander au médecin. »	« Ce n'est rien. » / « C'est grave. »
« Voici ce que le médecin a écrit. Pour savoir pourquoi, demandons-lui. »	« À votre place, je... »
« La césarienne est prise en charge par l'État. »	« Achetez ce médicament-là en premier. »
« Cet examen se fait au service X, il coûte tant. »	« Le médecin aurait dû... »
« Vous avez payé ceci le 12, ce n'est pas encore fait. »	« C'est une erreur. » / « On vous a arnaqués. »
« La famille n'a pas compris ce point, pouvez-vous le reprendre ? »	« Il est parti. »
« Madame X respire vite et ne répond plus depuis dix minutes. »	« Vous pouvez arrêter ce traitement. »

Engagement

Je reconnais avoir reçu, lu et compris le présent code de conduite ainsi que les fiches de procédure qui l'accompagnent. Je comprends que le manquement à l'une de ces règles constitue une faute pouvant justifier une sanction, et que la dissimulation d'un manquement constitue une faute plus grave que le manquement lui-même.

Nom [.....] Fonction [.....] Date [.....] Signature [.....]

DOCUMENT 5 — LES SIX FICHES DE PROCÉDURE

À imprimer au format carte et à remettre à chaque accompagnateur avec le code de conduite.

FICHE 1 — SITUATION URGENTE

Ce que je fais, dans cet ordre

1. J'alerte **immédiatement et verbalement** l'infirmier présent.
2. Si aucune réaction sous deux minutes, j'alerte le médecin de garde.

3. Si aucune réaction, j'alerte le cadre de garde, puis le référent de la convention.
4. Je note l'heure de chaque alerte et la réponse obtenue.
5. J'appelle mon superviseur dès que la situation est prise en charge.

Comment je décris. Des faits observables uniquement : « respire vite », « ne répond plus depuis dix minutes », « saigne », « est tombée ». Jamais : « je pense que », « ça a l'air », « c'est probablement ».

Ce que je ne fais sous aucun prétexte. Poser un acte. Toucher, déplacer ou transporter le patient. Donner à boire ou à manger. Administrer quoi que ce soit. Conseiller un départ contre avis médical. Conduire quelqu'un moi-même à l'hôpital.

Si la famille me demande d'agir. « Je n'ai pas le droit et je ne saurais pas faire. J'ai prévenu l'infirmier à telle heure, je vais le relancer maintenant. »

FICHE 2 — PATIENT QUI SEMBLE EN DANGER

Même procédure que la fiche 1.

La difficulté propre à cette situation est que rien ne se passe encore. Vous voyez quelque chose que personne ne regarde. Alerte quand même : décrire un fait ne coûte rien, ne pas le décrire peut coûter beaucoup.

Si l'on me répond que ce n'est rien. Je note l'heure, la personne alertée (par sa fonction) et la réponse. Je n'insiste pas au-delà d'une relance. Je préviens mon superviseur le jour même. Je ne dis rien à la famille de mon inquiétude.

Pourquoi je ne dis rien à la famille. Parce que je n'ai pas la compétence pour savoir si mon inquiétude est fondée, et que l'alarmer sans raison est un préjudice réel.

FICHE 3 — DÉCÈS

Avant l'annonce

Je ne dis rien. Je ne laisse rien deviner. Je ne modifie ni mon attitude ni mon visage. Si la famille me demande, je réponds : « c'est au médecin qu'il faut demander, je vais chercher quelqu'un. »

L'annonce ne m'appartient pas. Elle appartient au médecin, sans exception, quelles que soient les circonstances et quelle que soit l'insistance.

Après l'annonce

1. Je me tiens à distance. Je ne parle pas de démarches.
2. Je n'entreprends rien sans un mandat écrit de la famille.
3. Quand la famille me le demande, et pas avant, je reprends le relevé de parcours avec elle.

Ce que je fais ensuite, sur mandat écrit

- Je signale aux services concernés, de façon factuelle, que le patient est décédé et qu'une démarche est en cours. Formulation : « Nous constatons qu'un examen payé le 12/03 n'a pas été réalisé et souhaitons connaître la procédure applicable. »
- Je réunis les justificatifs des sommes engagées.
- J'accompagne les démarches administratives.
- Si l'établissement refuse, j'informe la famille de l'existence de voies de recours et je m'arrête là.

Ce que je ne dis jamais. Que c'est anormal. Que c'est une faute. Qu'on a fait payer pour rien. Une démarche poursuivie après un décès est presque toujours un défaut de synchronisation entre des circuits qui n'ont pas été conçus pour se parler — pas une escroquerie.

FICHE 4 — UNE FAMILLE ACCUSE UN SOIGNANT

Ce que je fais

1. J'écoute jusqu'au bout, sans interrompre.
2. Je ne confirme pas. Je ne conteste pas. Je ne commente pas.
3. Je reconnais l'émotion sans valider le fait : « je comprends que ce soit très difficile. »
4. J'informe de l'existence de voies de recours, sans recommander de les emprunter : le ministre chargé de la santé, l'ordre professionnel concerné, ou la juridiction compétente — et un délai court s'applique [à confirmer après vérification de la version consolidée de la loi].
5. Je suggère de consulter un avocat.
6. J'informe le référent de l'établissement qu'une tension existe, **sans reprendre l'accusation à mon compte** : « la famille de la chambre 4 exprime un mécontentement, je préfère que vous le sachiez. »
7. Je préviens mon superviseur le jour même et je consigne par écrit.

Ce que je ne fais jamais

Donner mon avis. Dire « vous avez raison » ou « vous avez tort ». Me proposer comme témoin. Recueillir des preuves. Mettre en relation avec un avocat déterminé. Publier ou répéter quoi que ce soit.

Si je suis appelé à témoigner. Je dis la vérité sur ce que j'ai vu, et rien de plus. Je ne mens jamais. Je ne me porte pas volontaire non plus.

FICHE 5 — UN PROFESSIONNEL ME DEMANDE QUELQUE CHOSE QUE JE NE COMPRENDS PAS

Je n'exécute jamais par politesse.

1. Je reformule : « si je comprends bien, vous me demandez de... »
2. Je demande l'écrit lorsque la demande porte sur un document, un produit ou un déplacement.
3. Si la demande sort de mon périmètre, je refuse poliment : « ce n'est pas dans ce que nous avons le droit de faire, je vais en référer à mon responsable. »
4. J'appelle mon superviseur.
5. Je consigne.

Trois demandes que je refuse toujours, quelle que soit la personne qui les formule

- Aller chercher, transporter ou remettre un médicament.
- Ouvrir une enveloppe, lire un résultat, ou expliquer un document médical à une famille.
- Transmettre une information sur un patient à quelqu'un qui n'a pas son accord écrit.

Comment refuser sans se fâcher. « Je ne peux pas, ce n'est pas autorisé pour nous. Mais je peux faire ceci à la place. » Proposer une alternative dans la même phrase désamorce presque toujours.

FICHE 6 — PLAINTES CONTRE NOUS, ET ERREUR DE NOTRE PART

Une plainte est déposée contre nous

1. Accusé de réception écrit sous quarante-huit heures.
2. Instruction par une personne **non impliquée**.

3. Réponse écrite sous quinze jours.
4. Inscription au registre des plaintes.
5. Analyse en comité trimestriel.

Nous ne discutons jamais une plainte sur le moment, et nous ne demandons jamais à la personne de la retirer.

J'ai commis une erreur

Je la déclare à mon superviseur dans la journée.

La déclaration d'une erreur n'est **jamais** sanctionnée. C'est la seule façon d'avoir une culture d'erreur utilisable — et c'est aussi ce que promeut le dispositif national de sécurité des patients.

Ce qui est sanctionné, c'est la **dissimulation** et la **répétition**.

Ensuite :

1. La famille est informée.
2. Réparation lorsqu'elle est possible.
3. Analyse en comité : que faut-il changer pour que cela ne se reproduise pas ?
4. Si l'erreur a eu lieu dans un établissement conventionné, le référent en est informé par nous — jamais par lui.

CHECKLIST — AVANT LA PREMIÈRE PRESTATION

	Document	Statut
☐	Conditions générales de service, relues par un avocat	
☐	Contrat type à double signature, relu par un avocat	
☐	Formulaire de consentement du Patient, bilingue et oralisable	
☐	Code de conduite, signé par chaque accompagnateur	
☐	Six fiches de procédure, imprimées et remises	
☐	Relevé de parcours imprimé	
☐	Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle	
☐	Justificatif des formalités accomplies auprès de l'APDP	
☐	Convention signée avec au moins un établissement	
☐	Registre des réclamations ouvert	

	Document	Statut
☐	Registre des erreurs déclarées ouvert	
☐	Superviseur identifié et joignable pendant les heures d'intervention	

Les quatre premières lignes conditionnent les huit autres. Ne démarrez pas sans elles.